PEDOMAN

Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan di Indonesia

Climate-Resilient and Environmentally Sustainable Healthcare Facility (CRESHCF)



Direktorat Kesehatan Lingkungan
Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia

2025

PEDOMAN
Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan
di Indonesia

Climate-Resilient and Environmentally Sustainable Healthcare Facility (CRESHCF)

Copyright © 2025. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
Diterbitkan oleh:
Kementerian Kesehatan RI

Dilarang menggunakan atau memperbanyak isi buku ini secara keseluruhan atau sebagian, baik dalam bentuk fotokopi, cetak, mikrofilm, sarana elektronik, atau bentuk lainnya, kecuali untuk tujuan pendidikan atau non-komersial, dengan atribusi yang sesuai kepada sumber.

Cara Mengutip:
Kementerian Kesehatan. (2025). Pedoman Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tangguh Iklim dan Lestari Lingkungan di Indonesi. Jakarta (ID): Kementerian Kesehatan

ISBN:

Desain halaman muka oleh **piarea.co.id**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat karuniaNya, kami dapat menyelesaikan Pedoman Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan. Pedoman ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) yang berketahanan iklim dan lestari lingkungan.

Perubahan iklim memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap sektor kesehatan, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah berkomitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan guna membangun ketahanan sistem kesehatan terhadap dampak perubahan iklim. Komitmen ini diwujudkan melalui ratifikasi Perjanjian Paris yang diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2025. Fasilitas pelayanan kesehatan terdampak langsung dari bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, cuaca ekstrim) dan juga secara tidak langsung (peningkatan kasus penyakit sensitif iklim, perubahan prevalensi penyakit, ancaman kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain-lain).

Dalam memastikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas dalam konteks perubahan iklim, terdapat empat syarat utama, yaitu : sumber daya manusia yang memiliki kapasitas memadai, pengelolaan air, sanitasi, kebersihan dan limbah yang sesuai standar, ketersediaan energi yang berkelanjutan, serta infrastruktur, teknologi dan produk. Hasil dari penilaian ini akan menggambarkan pemetaan fasyankes dengan kapasitas, risiko dan dampak tinggi, sedang dan rendah. Selanjutnya akan ada rekomendasi strategi intervensi sesuai hasil penilaian.

Terima kasih kami ucapkan kepada lintas program, lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah, perguruan tinggi, mitra pembangunan dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Pedoman Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan (Fas – Bik – Lin). Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat pada pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan di Indonesia. Saran dan kritik terhadap pedoman ini sangat diharapkan guna menyempurkan pedoman ipada edisi selanjutnya.

Jakarta, Juli 2025

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit

drg. Murti Utami, MPH

TIM PENYUSUN

Dokumen pedoman ini, tersusun atas kontribusi dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan melalui: kelompok diskusi terfokus, bimbingan teknis, wawancara mendalam, konsultasi dan berbagai masukan lainnya. Oleh karena itu, apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan kepada:

Pengarah

Then Suyanti	Kementerian Kesehatan
Perdinan PhD. M.NRE	KOMLI/IPB University

Penanggung Jawab

Tutut Indra Wahyuni	Kementerian Kesehatan

Tim Penyusun

Sandy Dwi Waseso	Kementerian Kesehatan
Dewi Marlina	Kementerian Kesehatan
Adelina Hutahuruk	Kementerian Kesehatan
Trisno Soebarkah	Kementerian Kesehatan
Astrid Salome	Kementerian Kesehatan
Nur Asni	Kementerian Kesehatan
Dini Surgayanti	Kementerian Kesehatan
Ela Edithya	Kementerian Kesehatan
Aisyah Amini	Kementerian Kesehatan
Sutrisno	Kementerian Kesehatan
Donal Simanjuntak	Kementerian Kesehatan
Itsnaeni Abbas	WHO Indonesia
Indah Deviyanti	WHO Indonesia

Tim Teknis

Ailsa Widya Fitri	PIAREA
Suvany Aprilia	PIAREA
Ryco Farysca Adi	PIAREA
Syafararisa Dian Pratiwi	PIAREA
Nurul Chairunnisa	PIAREA
Rizki Abdul Basit	PIAREA

Editor

Itsnaeni Abbas	WHO Indonesia
Ryco Farysca Adi	PIAREA
Syafararisa Dian Pratiwi	PIAREA

Terima kasih juga disampaikan kepada WHO Indonesia yang telah mendukung dan memberi pendampingan melalui kerja sama dengan Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang baik dalam perencanaan dan pengimplementasian Fasyankes Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan.

DAFTAR SINGKATAN

ASI	:	Adaptasi Sistem dan Infrastruktur saat ini
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
CRESHCF	:	*Climate-Resilient And Environmentally Sustainable Health Care Facility*
EWS	:	*Early Warning System*
Fasyankes	:	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
GRK	:	Gas Rumah Kaca
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
KOFLK	:	Keberlanjutan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan
KPK	:	Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran
K3	:	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
MFK	:	Manajemen Fasilitas Kesehatan
MR	:	Manajemen Risiko
NDC	:	*Nationally Determined Contribution*
PK	:	Pengembangan Kapasitas
PKK	:	Peraturan Kesehatan dan Keselamatan
PP	:	Pemantauan Penilaian
PPI	:	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
PPOK	:	Penyakit Paru Obstruktif Kronis
PSTB	:	Promosi Sistem dan Teknologi Baru
RAN-API	:	Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SIKELIM	:	Sistem Informasi Kelola Limbah Medis
UU	:	Undang-Undang
WASH	:	*Water, Sanitation, and Hygiene*
WHO	:	*World Health Organization*

DAFTAR ISTILAH

Badai	:	Fenomena meteorologi yang melibatkan angin kencang, hujan deras, petir atau hujan es (BNPB)
Banjir	:	Peristiwa ketika air menenggelamkan atau mengenangi suatu daratan karena volume air yang meningkat (BNPB)
Dampak	:	Konsekuensi yang timbul akibat suatu kejadian atau bencana, termasuk kerugian terhadap manusia, lingkungan, ekonomi, dan infrastruktur
Energi	:	Pengelolaan energi yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dalam fasilitas kesehatan
Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	:	Tempat yang menyediakan fasilitas kesehatan, mencakup rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang perlu untuk dilakukan tinjauan mengenai kesehatan lingkungannya.
INARISK	:	Portal hasil kajian risiko yang menggunakan arcgis server sebagai *data services* yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik (Rp.), potensi kerugian ekonomi (Rp.) dan potensi kerusakan lingkungan (ha) dan terintegrasi dengan realisasi pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana sebagai tool monitoring penurunan indeks risiko bencana (BNPB)
Kebakaran Hutan	:	Suatu keadaan dimana hutan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan (BNPB)
Kekeringan	:	Ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (BNPB)
Kenaikan Muka Air Laut	:	Peningkatan ketinggian permukaan laut relatif terhadap daratan di lokasi tertentu (WHO)
Kesiapan	:	Serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum suatu bencana atau kejadian darurat untuk meningkatkan kapasitas agar dapat merespon dengan efektif
Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran	:	Mengomunikasikan, mengoordinasikan, dan meningkatkan kesadaran terkait ketahanan iklim dan kelestarian lingkungan di antara petugas kesehatan, pasien, pengunjung, komunitas sasaran, dan dengan sektor lain.
Kuratif	:	Tindakan yang bertujuan untuk mengobati, menyembuhkan, atau memperbaiki kondisi pasien yang mengalami gangguan kesehatan
Manajemen Risiko	:	Memperkuat kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengelola risiko air, sanitasi, bahan kimia, dan limbah pelayanan kesehatan bagi pekerja, pasien, dan masyarakat yang dilayani, dengan memasukkan penilaian ketahanan iklim dan kelestarian lingkungan dalam merespons bahaya dan mengidentifikasi serta mengurangi paparan dan kerentanan.

Pemantauan Penilaian (Energi)	:	Informasi mengenai layanan energi harus mempertimbangkan ketahanan iklim dan kelestarian lingkungan untuk mendorong tindakan.
Pemantauan Penilaian (WASH)	:	Informasi mengenai air, sanitasi, penggunaan bahan kimia, dan pengelolaan limbah pelayanan kesehatan mempertimbangkan ketahanan iklim dan kelestarian lingkungan untuk mendorong tindakan.
Pemulihan	:	Proses yang dilakukan setelah bencana untuk mengembalikan kondisi individu, masyarakat, dan lingkungan keadaan yang lebih stabil
Pencegahan	:	Upaya yang dilakukan untuk mencegah risiko sebelum terjadi
Pengembangan Kapasitas	:	Pelatihan, informasi dan manajemen pengetahuan yang ditargetkan untuk petugas pelayanan kesehatan untuk menanggapi risiko iklim dan ancaman lingkungan yang diakibatkan oleh pengoperasian Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Peraturan Kesehatan dan Keselamatan (Energi)	:	Peraturan tentang penggunaan dan akses energi diterapkan dengan mempertimbangkan variabilitas dan perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan.
Peraturan Kesehatan dan Keselamatan (WASH)	:	Peraturan air, sanitasi, keamanan bahan kimia, dan limbah pelayanan kesehatan diterapkan dengan mempertimbangkan variabilitas dan perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan.
Preventif	:	Tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya penyakit atau masalah kesehatan sebelum terjadi
Promotif	:	Promosi kesehatan atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui edukasi dan perilaku hidup sehat
Rehabilitatif	:	Upaya atau proses pemulihan kemampuan fisik, mental, dan sosial seseorang untuk mencapai kondisi optimal
Resilience (Ketahanan)	:	Ketahanan dalam mengantisipasi, merespon, beradaptasi, dan pulih dari guncangan dan tekanan, sambil mempertahankan fungsi inti (Permenkes No. 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan**)**
Respons	:	Tindakan yang dilakukan segera setelah bencana terjadi untuk menyelamatkan nyawa, melindungi aset, dan memenuhi kebutuhan dasar
Sumber Daya Manusia	:	Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki jumlah tenaga kesehatan yang cukup dengan kondisi kerja yang sehat dan aman, kapasitas untuk menghadapi risiko kesehatan akibat perubahan iklim, serta kesadaran dan pemberdayaan untuk memastikan tindakan yang ramah lingkungan.
Sustainable (lestari)	:	Mengacu pada prinsip pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam konteks lingkungan, ekonomi, dan sosial, sustainability bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan manusia dan kelestarian alam.

Tabel intervensi A	:	Berorientasi pada penyesuaian dan perlindungan terhadap risiko iklim - (*Resilience*)
Tabel intervensi B	:	Bertujuan mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan operasional fasilitas kesehatan - (*Sustainable*)
Sumber daya Kesehatan	:	Individu yang terlibat dalam kegiatan yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
WASH	:	WASH mencakup penyediaan air bersih, sanitasi aman, dan praktik kebersihan di fasilitas kesehatan untuk melindungi kesehatan pasien, staf, dan komunitas, serta mendukung keberlanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Limbah layanan kesehatan	:	Limbah layanan kesehatan mencakup semua limbah medis, seperti limbah infeksius, tajam, kimia, farmasi, dan limbah umum, yang harus dikelola secara aman dan ramah lingkungan untuk meminimalkan risiko kesehatan dan dampak lingkungan.

STRUKTUR DOKUMEN

Bab	Deskripsi
1. Pendahuluan	Landasan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim di bidang kesehatan, dengan fokus pada pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan (FAS-BIK-LIN) yang mencakup komitmen bidang kesehatan pada *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan COP26. Bagian ini juga menjelaskan tujuan, sasaran, dan manfaat dari Fasyankes Berketahanan Iklim
2. Penyelenggaraan	Menguraikan strategi dalam pelaksanaan penilaian hingga panduan prioritas penilaian fasyankes berketahanan iklim di Indonesia. Bagian ini juga menjelaskan Kontribusi atau peran para pihak dalam penyelenggaraan Fasyankes Berketahanan Iklim baik tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten / kota serta lintas sektor pendukung
3. Pelaksanaan Penilaian	Menjelaskan proses dalam pelaksanaan penilaian fasyankes berketahanan iklim di Indonesia, meliputi 1) Skema Pelaksanaan, 2) Pembentukan tim pelaksana (mencakup unit yang dapat berkontribusi dalam pengisian instrumen penilaian di fasyankes), 3) Komponen penilaian, 4) instrumen penilaian, 5) skema Penilaian (mencakup skema pelaksanaan penilaian pada aplikasi SIKELIM hingga skema perhitungan skor penilaian), hingga 6) Penyusunan Rekomendasi Intervensi (bagian ini memberikan rekomendasi dan pilihan rencana aksi sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim).
4. Pemantauan dan Evaluasi	Menjelaskan tahapan tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan program, termasuk monitoring dan evaluasi terhadap penilaian fasilitas pelayanan kesehatan berketahanan iklim di Indonesia yang perlu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, hingga Kementerian Kesehatan. Pembagian peran dalam pelaksaan Pemantauan dan evaluasi didasarkan pada peringkat hasil penilaian FAS-BIK-LIN.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUJUAN 2
1.3 RUANG LINGKUP 2
1.4 SASARAN 2
1.5 MANFAAT 3
BAB II PENYELENGGARAAN 5
2.1 STRATEGI PELAKSANAAN 5
2.2 PRIORITAS PENILAIAN FASYANKES 5
2.3 PERAN PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN PENILAIAN FASYANKES BERKETAHANAN IKLIM 6
BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN 8
3.1 SKEMA PELAKSANAAN 8
3.2 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DI FASYANKES 9
3.2.1 Identifikasi Unit Teknis di Fasyankes 9
3.2.2 Audiensi dan Sosialisasi 10
3.2.3 Inventarisasi Struktur Tim 10
3.2.4 Legalitas dan Pengesahan 10
3.2.5. Pelaksanaan Kapasitas dan Pendampingan 10
3.3 KOMPONEN PENILAIAN 11
3.4 INSTRUMEN PENILAIAN 14
3.4.1 Formulir Identifikasi Kapasitas 15
3.4.2 Formulir Identifikasi Bahaya dan Dampak 15
3.4.3 Formulir Identifikasi Kerentanan 15
3.5 SKEMA PENGISIAN INSTRUMEN PENILAIAN 17
3.5.1 Skema Pelaksanaan Pengisian Formulir Penilaian oleh Fasyankes 17
3.5.2 Skema Perhitungan Instrumen Penilaian 20
3.6 PENYUSUNAN REKOMENDASI INTERVENSI 22
3.6.1 Rekomendasi Strategi Intervensi 22
3.6.2 Rekomendasi Intervensi Aksi 26
3.6.3 Contoh Hasil Penilaian Fasyankes dan Rekomendasi Intervensinya 38
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI 41
REFERENSI 45
LAMPIRAN 48
LAMPIRAN 1. Skoring dan Perhitungan Nilai Instrumen Penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan 48
LAMPIRAN 2. Format Surat Keputusan (SK) 54
LAMPIRAN 3. Formulir / Instrumen Penilaian FAS-BIK-LIN 57
1. Formulir 1 Identifikasi Kapasitas Fasyankes 57
2. Formulir 2 Identifikasi Bahaya dan Dampaknya 66
3. Formulir 3 Identifikasi Kerentanan 91

DAFTAR GAMBAR

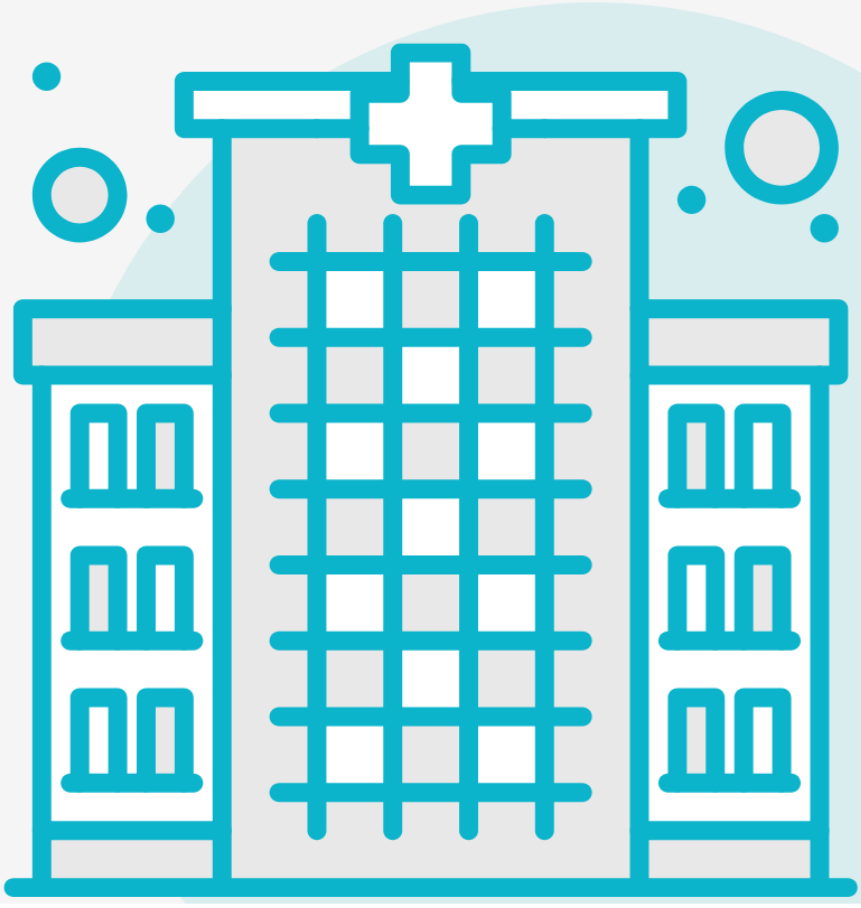
Gambar 3.1 Rancangan Peran Para Pihak dalam Pelaksanaan Penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim 8
Gambar 3.2 Rancangan pembentukan tim pelaksana Fasyankes Berketahanan Iklim 9
Gambar 3.3 Rancangan struktur Tim Pelaksana Fasyankes Berketahanan Iklim 10
Gambar 3.4 Komponen Penyusun Instrumen Penilaian 13
Gambar 3.5 Kerangka kerja formulir penilaian 14
Gambar 3.6 Komponen Instrumen Penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim 16
Gambar 3.7 Matriks status akhir Fasyankes berdasarkan hasil penilaian 23
Gambar 4.1 Contoh tampilan peringkat Fasyankes yang sudah melakukan penilaian dan dapat digunakan lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota atau Provinsi untuk Pemantauan dan Evaluasi..... 43

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Unit teknis yang dapat berkontribusi sebagai tim penilaian FAS-BIK-LIN 10
Tabel 3.2 Tampilan pengisian instrumen FAS-BIK-LIN pada aplikasi SIKELIM..... 17
Tabel 3.3 Visualisasi hasil penilaian FAS-BIK-LIN pada aplikasi SIKELIM..... 19
Tabel 3.4 Tabel skoring perhitungan formulir identifikasi kapasitas Fasyankes..... 21
Tabel 3.5 Tabel skoring perhitungan identifikasi Bahaya dan Dampak 21
Tabel 3.6 Tabel skoring perhitungan identifikasi kerentanan..... 22
Tabel 3.7 Strategi Intervensi berdasarkan Status Fasyankes 24
Tabel 3.8 Kriteria dan tahapan pengembangan rekomendasi intervensi aksi..... 26
Tabel 3.9 Rincian Intervensi Aksi berdasarkan Strategi pada masing-masing Status Fasyankes..... 28
Tabel 4.1 Tabel peran dinas terkait dalam pemantauan dan evaluasi Fasyankes Berketahanan Iklim 41

BAB I
PENDAHULUAN

Perubahan iklim memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap sektor kesehatan, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan guna membangun ketahanan sistem kesehatan terhadap dampak perubahan iklim. Komitmen ini diwujudkan melalui ratifikasi Perjanjian Paris, yang diatur dalam UU No. 16/2016. Tujuan pedoman ini adalah memberikan panduan untuk Fasyankes dalam menilai kapasitas dan kerentanannya terhadap dampak perubahan iklim. Dengan adanya pedoman ini dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kesiapan Fasyankes, pengurangan emisi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi umat manusia saat ini. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Pasifik dan Hindia), berada dalam wilayah iklim tropis yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Letak geografis ini membuat Indonesia memiliki karakteristik iklim yang unik, dipengaruhi oleh pola muson, ekuatorial, dan lokal. Akibatnya, pola curah hujan, suhu, dan kelembaban di berbagai wilayah Indonesia pun sangat bervariasi.

Secara umum, perubahan iklim dipicu oleh faktor alamiah dan aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Gas-gas ini menumpuk di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global, yang kemudian memicu berbagai dampak lingkungan seperti peningkatan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. Perubahan ini berdampak luas pada berbagai sektor, termasuk energi, industri, limbah, pertanian, kehutanan, dan terutama sektor kesehatan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengidentifikasi empat persyaratan utama untuk memastikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas dalam konteks perubahan iklim, sebagaimana yang tercantum dalam WHO *Guidance for Climate-Resilient and Environmentally Sustainable Health Care Facilities*), yaitu:

1. Sumber daya manusia yang memiliki kapasitas memadai.
2. Pengelolaan air, sanitasi, kebersihan (*Water and Sanitation Hygiene*) dan limbah yang sesuai standar
3. Ketersediaan energi yang berkelanjutan.
4. Infrastruktur, teknologi dan produk (penggunaan alat kesehatan yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun, teknologi hemat energi, energi terbarukan, serta rantai pasok dan sistem penyimpanan yang aman dan minim polusi)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan guna membangun ketahanan sistem kesehatan terhadap dampak perubahan iklim. Komitmen ini diwujudkan melalui ratifikasi Perjanjian Paris, yang diatur dalam UU No. 16/2016. Indonesia juga turut berpartisipasi dalam Inisiatif Program Kesehatan *Conference of Parties* ke 26[1]. Melalui Surat Menteri Kesehatan RI Nomor KS.02.03/Menkes/1234/2021, Indonesia menegaskan komitmen dan dukungan Indonesia terhadap inisiatif Kesehatan pada Perubahan Iklim. Pada *Enhanced* NDC (2022) menetapkan aspek adaptasi yang berfokus pada ketahanan di sektor kesehatan. Sejalan dengan amanat NDC ini dan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memperkuat integrasi isu lingkungan dan iklim dalam sistem kesehatan nasional. Sebagai langkah konkret, Permenkes No. 2 Tahun 2023 disahkan untuk mengatur penerapan kesehatan lingkungan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Peraturan ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui strategi mitigasi dan adaptasi yang didasarkan pada kerangka 10 *Building Blocks* WHO.

[1] https://www.who.int/initiatives/alliance-for-transformative-action-on-climate-and-health/commitments

Sektor kesehatan memiliki peran ganda dalam konteks perubahan iklim. Di satu sisi, sistem pelayanan kesehatan berada di garis depan dalam merespons dampak perubahan iklim; di sisi lain, sektor ini juga dituntut untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkannya sendiri. Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, badai, dan cuaca ekstrem. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan lonjakan kasus penyakit yang sensitif terhadap iklim, perubahan pola penyakit, serta ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan perlu terus diperkuat agar mampu mengelola risiko iklim yang semakin kompleks. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan "*Pedoman Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan"* sebagai dasar bagi transformasi sistem kesehatan yang adaptif dan berkelanjutan.

1.2 TUJUAN

Tujuan Umum fasyankes berketahanan iklim ini adalah: Menjadi acuan untuk pelaksanaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) Berketahanan Iklim dan Lestari lingkungan.

Tujuan Khusus fasyankes berketahanan iklim ini adalah:

a. Memberikan panduan bagi Fasyankes untuk melakukan penilaian kapasitas terkini dalam rangka menuju Fasyankes berketahanan iklim dan lestari lingkungan;
b. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) di berbagai level (manajerial dan teknis), serta stakeholder terkait dalam pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan berketahanan iklim dan lestari lingkungan.
c. Mendorong pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) di berbagai level (manajerial dan teknis) dalam menerapkan praktik-praktik kegiatan atau proses bisnis pelayanan kesehatan yang sejalan dengan kerangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di bidang kesehatan.
d. Mendorong terciptanya fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) berketahanan iklim dan lestari lingkungan

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim yang dilakukan pada Rumah Sakit dan Puskesmas meliputi:

a. Mengidentifikasi kapasitas Fasyankes dalam membangun ketahanan iklim dan lestari lingkungan.
b. Mengidentifikasi bahaya, potensi, serta dampak yang dihasilkan oleh perubahan iklim berdasarkan lokasi Fasyankes.
c. Mengidentifkasi kerentanan saat ini pada Fasyankes dalam menghadapi bahaya iklim yang terjadi.

1.4 SASARAN

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan fasyankes berketahanan iklim ini adalah:

a. Lintas sektor terkait
b. Lintas program terkait
c. Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota
d. Rumah Sakit
e. Puskesmas
f. Organisasi Profesi/Lembaga Swadaya Masyarakat
g. Mitra Pembangunan

1.5 MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan fasyankes berketahanan iklim ini adalah:

a. Meningkatnya ketahanan fasilitas kesehatan terhadap bencana dan perubahan iklim, menjaga kontinuitas layanan kesehatan.
b. Mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat melalui pencegahan penyakit dan peningkatan respons terhadap krisis kesehatan.
c. Mengurangi emisi karbon fasilitas kesehatan dengan mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan.
d. Mendorong teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi, fasilitas kesehatan dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang
e. Mendukung keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
f. Sebagai dasar dalam menyusun perencanaan penganggaran.



BAB II
PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan penilaian mencakup penguatan komitmen pemerintah daerah, pembentukan tim pelaksanaan di Fasyankes, dan penegakan regulasi. Prioritas diberikan kepada Fasyankes yang telah terintegrasi dan aktif dalam melakukan pelaporan pengelolaan limbah medis dalam SIKELIM agar penilaian lebih efektif dan berbasis data yang akurat. Selain itu prioritas diberikan kepada Fasyankes yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim, sehingga perlu dinilai lebih awal dan dengan intensitas lebih sering. Pemangku kepentingan banyak terlibat dalam mendukung proses penilaian seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Fasyankes dan LSM atau Organisasi Masyarakat Sipil.

BAB II
PENYELENGGARAAN

2.1 STRATEGI PELAKSANAAN

1. **Penjaringan dan Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah:** Menginisiasi dan mengonsolidasikan komitmen pemerintah daerah bahwa pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim di sektor kesehatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Komitmen ini ditujukan untuk mendukung penerapan prinsip Fasyankes Berketahanan Iklim melalui regulasi daerah, alokasi anggaran, dan integrasi dalam rencana pembangunan daerah.
2. **Pembentukan Tim FAS-BIK-LIN di Fasyankes:** Menetapkan tim pelaksana internal (misalnya tim mutu atau tim K3) yang bertanggung jawab atas penilaian, pengumpulan data, dan tindak lanjut rencana aksi Fasyankes Berketahanan Iklim. Tim ini bertugas mengisi instrumen penilaian, mengoordinasikan pengumpulan bukti dokumen, serta memastikan integrasi hasil ke dalam perencanaan fasilitas.
3. **Penguatan Komitmen dan Regulasi Internal Fasilitas:** Mendorong setiap Puskesmas dan Rumah Sakit menyusun dokumen komitmen tertulis terhadap penerapan Fasyankes Berketahanan Iklim, termasuk melalui revisi SOP, Rencana Usaha Kesehatan Puskesmas (RUK), Rencana Strategis Rumah Sakit, dan dokumen mutu lainnya. Komitmen ini diperkuat dengan dukungan kepala daerah dan Dinas Kesehatan setempat.
4. **Integrasi Kemitraan Teknis dan Non-Teknis di Level Lokal:** Mendorong kerja sama lintas sektor di tingkat kabupaten/kota, termasuk dengan BPBD, DLH, Dinas PUPR, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung penyediaan data iklim lokal, pendampingan teknis, dan solusi infrastruktur adaptif.
5. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Stakeholder:** Melaksanakan pelatihan berkala dan pengembangan kapasitas bagi petugas kesehatan, manajer fasilitas, serta komunitas lokal terkait dampak perubahan iklim dan langkah-langkah adaptasi. Pelatihan mencakup penggunaan alat penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim, manajemen risiko iklim, sistem peringatan dini, dan pendekatan tanggap darurat berbasis iklim.
6. **Mobilisasi Sumber Pembiayaan Internal dan Eksternal:** Mendorong pemanfaatan dana operasional, BOK, dana BLUD, serta akses hibah dan kemitraan CSR untuk membiayai aksi-aksi prioritas dalam rencana tindak lanjut hasil penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim. Perlu dibangun mekanisme transparan dan akuntabel untuk pelaporan dan evaluasi anggaran ini.

2.2 PRIORITAS PENILAIAN FASYANKES

Seluruh Fasyankes di Indonesia di bawah Kementerian Kesehatan harus dinilai ketahanan iklim dan kelestarian lingkungannya. Namun, prioritas diberikan kepada Fasyankes yang telah terintegrasi dan aktif dalam melakukan pelaporan pengelolaan limbah medis dalam aplikasi SIKELIM agar penilaian lebih efektif dan berbasis data yang akurat. Selain itu prioritas diberikan kepada Fasyankes yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim, sehingga perlu dinilai lebih awal dan dengan intensitas lebih sering. Faktor yang menentukan prioritas adalah:

- **Lokasi yang Rentan terhadap Bencana Iklim**
  Fasyankes yang terletak di daerah rawan banjir, longsor, daerah pesisir, dan wilayah kering. Fasyankes yang terletak di lokasi rentan terhadap bencana iklim diharapkan dapat melakukan penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim ini untuk memastikan kesiapan fasilitas dan menghadapi bencana iklim serta memastikan

Fasyankes tersebut tetap berfungsi dalam keadaan ekstrem (kejadian bencana iklim).

- **Fasyankes dengan Infrastruktur dan Utilitas Terbatas**
  Fasyankes yang mengalami gangguan listrik dan pasokan air terbatas perlu mendapatkan perhatian lebih karena keterbatasan ini dapat menghambat operasional medis dan pencegahan infeksi penyakit.
- **Fasyankes dengan Populasi yang Tinggi atau Kelompok Rentan**
  Rumah sakit rujukan utama, pusat kesehatan ibu dan anak, serta Fasyankes yang menangani populasi balita, lansia, dan pasien dengan penyakit kronis harus diprioritaskan karena perubahan iklim dapat meningkatkan risiko penyakit bagi kelompok rentan ini.
- **Fasyankes dengan Peralatan Medis Sensitif Perubahan Cuaca dan Iklim**
  Fasilitas dengan teknologi medis canggih yang bergantung pada listrik stabil dan lingkungan steril harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketahanan sistem pendukungnya. Peralatan medis sensitif merujuk pada perangkat kesehatan yang memerlukan kondisi operasional stabil, seperti suplai listrik yang tidak terputus, kelembaban terkendali, dan lingkungan steril agar dapat berfungsi dengan optimal. Gangguan pada faktor-faktor ini dapat menyebabkan malfungsi atau penurunan akurasi, yang berisiko menghambat layanan medis dan membahayakan keselamatan pasien.

2.3 PERAN PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN PENILAIAN FASYANKES BERKETAHANAN IKLIM

- **Kementerian Kesehatan (Pemerintah Pusat) dan Dinas Kesehatan Provinsi** bertindak sebagai pengelola utama sistem SIKELIM, melakukan analisis tren nasional dan subnasional, dan memastikan bahwa hasil penilaian digunakan untuk penyusunan kebijakan dan pengembangan program ketahanan iklim di sektor kesehatan.
- **Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota** melakukan pemantauan hasil penilaian yang masuk ke dalam sistem dan memastikan bahwa Fasyankes telah mengisi dengan benar serta menindaklanjuti rekomendasi intervensi yang diberikan oleh sistem.
- **Dinas Lingkungan Hidup dan Manajemen Risiko Bencana** bertugas untuk meninjau hasil penilaian terkait aspek lingkungan dan risiko iklim, serta memberikan rekomendasi tambahan jika diperlukan.
- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** berperan penting dalam mendukung ketahanan Fasyankes terhadap bencana dan perubahan iklim. Perannya mencakup analisis risiko, penyediaan data ancaman, evaluasi kesiapan fasilitas, serta pelatihan kesiapsiagaan seperti simulasi evakuasi dan respons risiko iklim guna memastikan kesiapan menghadapi situasi darurat.
- **Fasyankes** bertanggung jawab mengisi formulir penilaian melalui akun masing-masing di aplikasi SIKELIM. Proses ini didukung oleh tim pelaksana yang terdiri dari berbagai unit yang dapat berkontribusi dalam pengisian instrumen penilaian fasyankes berketahanan iklim seperti Unit Sanitarian, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Kesehatan Lingkungan. Selain itu, beberapa unit lain juga dapat turut berperan dalam pengisian formulir, seperti Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Unit Pemeliharaan Infrastruktur, sesuai dengan rincian yang dijelaskan pada bagian 4.2.
- **LSM dan organisasi masyarakat sipil** mendukung ketahanan iklim sektor kesehatan melalui advokasi, peningkatan kesadaran, serta pendampingan Fasyankes dalam program adaptasi berkelanjutan. Mereka juga memperkuat kapasitas komunitas melalui edukasi, pelatihan, dan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif mitigasi, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah layanan kesehatan.

BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN

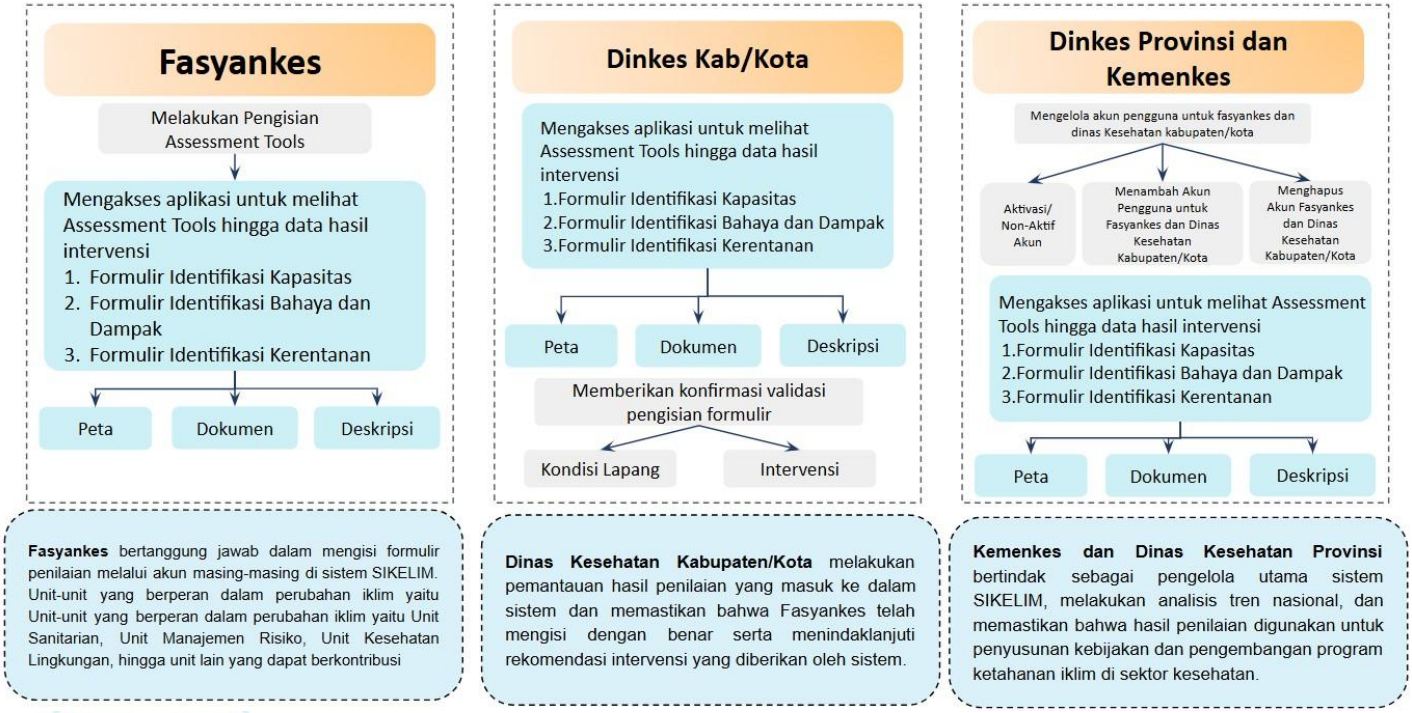
Penilaian yang dilakukan melalui platform SIKELIM yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, mencakup: **1) Penilaian Kapasitas; 2) Identifikasi Bahaya dan Dampak; 3) Identifikasi Kerentanan**. Dalam proses pengisian penilaian melibatkan unit teknis yang berada di Fasyankes. Intrumen yang diisi berdasarkan kondisi eksisting di Fasyankes, dinilai menggunakan bobot penilaian dan kategori sehingga menghasilkan nilai mengenai kesiapan dan risiko terhadap dampak perubahan iklim. Hasil penilaian divisualisasikan dalam bentuk peta, grafik, dan rekomendasi intervensi. Sehingga berdasarkan hasil tersebut, dapat merancang aksi yang tepat untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan Fasyankes.



BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN

3.1 SKEMA PELAKSANAAN

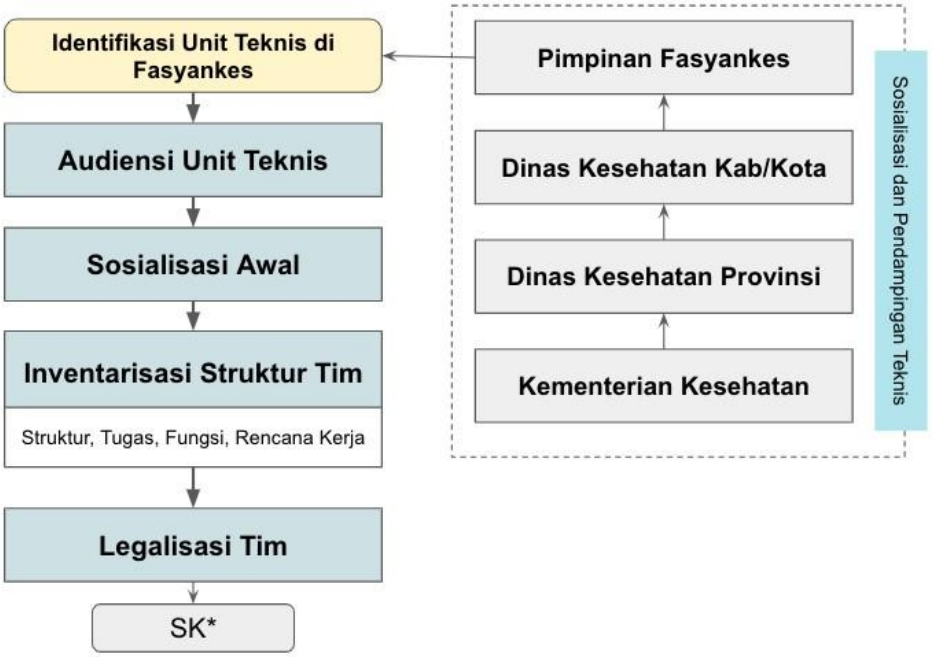
Proses penilaian kedepannya dapat dilakukan pada aplikasi SIKELIM. Tiga pihak (Gambar 4.1) yang terlibat dalam pengisian instrumen penilaian adalah Fasyankes, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kemenkes. Fasyankes bertanggung jawab untuk mengisi formulir penilaian melalui aplikasi SIKELIM, termasuk mengisi Formulir Penilaian Fasyankes, Formulir Identifikasi Bahaya dan Dampak, dan Formulir Kerentanan. Fasyankes juga melakukan pengisian dokumen dan deskripsi pendukung terkait dengan kondisi fasilitas kesehatan mereka. **Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota** memiliki peran untuk mengakses aplikasi, memverifikasi hasil pengisian dari Fasyankes, serta memberikan konfirmasi validasi terhadap formulir yang telah diisi, termasuk memastikan kondisi lapangan sesuai dengan data yang diberikan. **Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan** bertindak sebagai pengelola utama aplikasi SIKELIM, mengelola akun pengguna Fasyankes dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta melakukan analisis data untuk menghasilkan hasil penilaian yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terkait ketahanan iklim dalam sektor kesehatan. Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi juga memastikan akurasi data dan mendukung pengembangan kapasitas di tingkat kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Fasyankes Berketahanan Iklim.



Gambar 3.1. Rancangan Peran Para Pihak dalam Pelaksanaan Penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim

3.2 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DI FASYANKES

Tim pelaksana penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan (FAS-BIK-LIN) di tingkat fasyankes dibentuk untuk memastikan proses pengisian instrumen penilaian ketahanan iklim dan kelestarian lingkungan berjalan efektif. Tim ini terdiri dari penanggung jawab utama serta unit-unit teknis yang memiliki kapasitas dan pemahaman mendalam mengenai kondisi Fasyankes terkait aspek ketahanan iklim dan lingkungan.



Gambar 3.2. Rancangan pembentukan tim pelaksana Fasyankes Berketahanan Iklim[2]

Pembentukan tim pelaksana Fasyankes Berketahanan Iklim dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis untuk memastikan keterlibatan unit yang relevan dan kapasitas teknis yang memadai dalam proses pengisian instrumen penilaian. Tahapan tersebut meliputi:

3.2.1 Identifikasi Unit Teknis di Fasyankes

Melakukan inventarisasi unit-unit yang memiliki kapasitas teknis dan pemahaman terkait kondisi fasyankes berketahanan iklim dan kelestarian lingkungan. Unit utama[3] dan pendukung yang berpotensi terlibat diidentifikasi untuk memastikan cakupan unit yang sesuai. Unit yang bertanggung jawab dalam pengisian formulir penilaian bisa berasal dari bagian yang memiliki kapasitas teknis[4] yang memahami kondisi Fasyankes untuk menilai aspek ketahanan iklim dan kelestarian lingkungan. Selain itu, beberapa unit pendukung juga dapat berkontribusi dalam penyediaan data dan validasi informasi. Secara teknis, dalam aplikasi hanya tersedia satu akun yang mewakili masing-masing Fasyankes. Meskipun demikian, pengisian dapat dilakukan secara kolaboratif oleh tim dari unit-unit teknis yang relevan di bawah koordinasi akun fasyankes tersebut. Tabel 3.1. menyajikan unit teknis yang dapat berkontribusi dalam pengisian formulir.

---

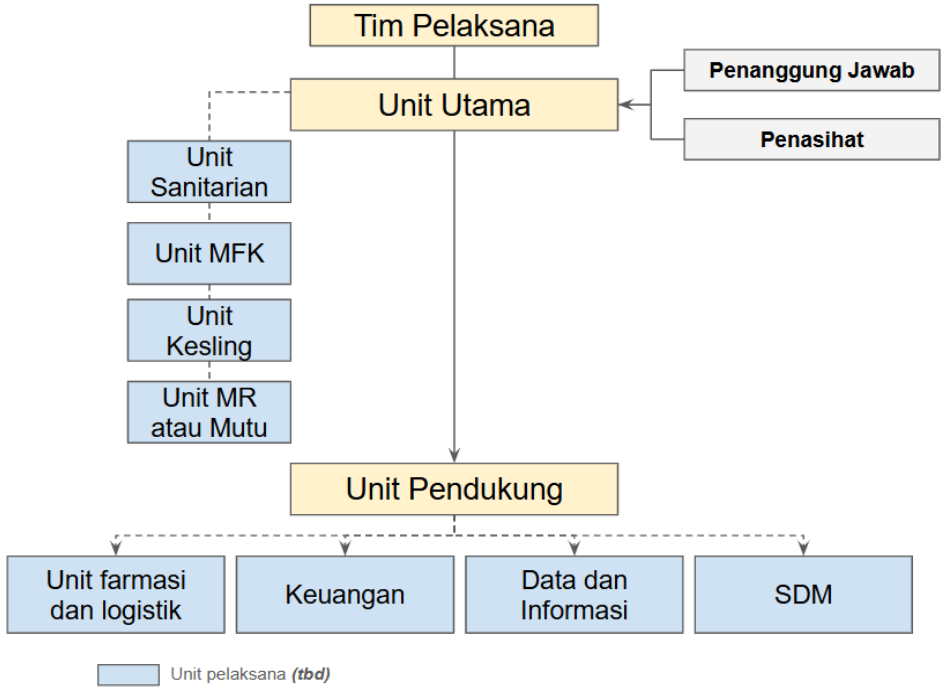
[2] Template SK Tim Pelaksana tersedia pada Lampiran 2

[3] **Unit utama** memiliki tanggung jawab utama dalam pengisian formulir, sementara **unit pendukung** dapat memberikan masukan atau validasi data.

[4] **Pelatihan teknis** dapat dilakukan secara berkala agar semua unit memahami metode pengisian yang benar dan dapat menghasilkan data yang akurat.

Tabel 3.1. Unit teknis yang dapat berkontribusi sebagai tim penilaian FAS-BIK-LIN

Jenis Fasyankes	Bagian	Unit
Rumah Sakit	Komite Mutu	- Pengendalian Penyakit Infeksi - K3 - Manajemen Fasilitas - Manajemen Risiko
	Instalasi Pemeliharaan Sarana	- Kesehatan Lingkungan - Infrastruktur
	Unit terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan	
	Perencanaan dan Anggaran	
	Hubungan Masyarakat (Humas)	
	Tim Siaga Bencana	
Puskesmas	Manajemen Fasilitas Kesehatan (MFK)	- Sarana dan Prasarana - K3 - Kesehatan Lingkungan - Utilitas - Pelatihan atau Diklat - Tim Tanggap Darurat Bencana
	Manajemen Mutu	- Pengendalian Penyakit Infeksi - Manajemen Risiko
	Manajemen Keuangan	- Perencanaan dan Anggaran



Gambar 3.3. Rancangan struktur Tim Pelaksana Fasyankes Berketahanan Iklim

3.2.2 Audiensi dan Sosialisasi

Melakukan pertemuan awal dengan pemangku kepentingan, termasuk pimpinan unit terkait dan penanggung jawab Fasyankes, untuk menyampaikan tujuan pembentukan tim pelaksana dan menjelaskan peran masing-masing unit dalam pengisian formulir

Fasyankes Berketahanan Iklim. Sosialisasi ini bertujuan membangun kesepahaman dan komitmen bersama.

3.2.3 Inventarisasi Struktur Tim

Menyusun struktur tim pelaksana yang mencakup penanggung jawab dan anggota dari unit-unit teknis utama atau sebagai unit pendukung. Struktur ini menetapkan peran dan tanggung jawab tiap anggota tim, serta mekanisme koordinasi antar unit.

3.2.4 Legalitas dan Pengesahan

Pengesahan tim pelaksana melalui surat keputusan atau dokumen resmi dari pimpinan Fasyankes penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai mekanisme kelembagaan. Dokumen ini membantu memperjelas peran masing-masing anggota tim dan memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan dan koordinasi kegiatan di lingkungan Fasyankes.

3.2.5 Pelaksanaan Kapasitas dan Pendampingan

Melaksanakan pelatihan atau pendampingan teknis kepada anggota tim agar memahami instrumen penilaian dan prosedur pengisian dengan tepat. Pendampingan ini memastikan kualitas data dan efektivitas kerja tim.

3.3 KOMPONEN PENILAIAN

Penilaian Fasyankes berketahanan iklim dilihat dari tiga komponen, yaitu:

1) Identifikasi Kapasitas
2) Identifikasi Bahaya dan Dampak
3) Identifikasi Kerentanan

Penilaian Fasyankes berketahanan iklim mengukur empat aspek utama sejalan dengan Panduan global WHO (2020) yang mengusulkan empat prasyarat utama untuk memastikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tangguh iklim dan lestari lingkungan, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.4. Masing-masing komponen dijelaskan sebagai berikut.

- **Sumber Daya Kesehatan :** Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan kondisi kerja yang layak dalam jumlah yang memadai, diberdayakan dan diberi informasi untuk menanggapi tantangan-tantangan lingkungan ini.
  Tujuan dari pelaksanaan Komponen ini yaitu :
  1. **Sumber Daya Manusia:** Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki jumlah tenaga kesehatan yang memadai, dengan kondisi kerja yang sehat dan aman, kapasitas untuk menghadapi risiko kesehatan akibat perubahan iklim, serta memiliki kesadaran dan pemberdayaan untuk menjalankan tindakan yang berkelanjutan secara lingkungan.
  2. **Pengembangan Kapasitas:** Pelatihan, penyediaan informasi, dan manajemen pengetahuan yang ditujukan bagi tenaga kesehatan agar mampu merespons risiko iklim dan meminimalkan dampak lingkungan dari operasional fasilitas pelayanan kesehatan.
  3. **Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran:** Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kesadaran terkait ketahanan iklim dan keberlanjutan lingkungan di kalangan tenaga kesehatan, pasien, pengunjung, masyarakat sasaran, serta lintas sektor lainnya.

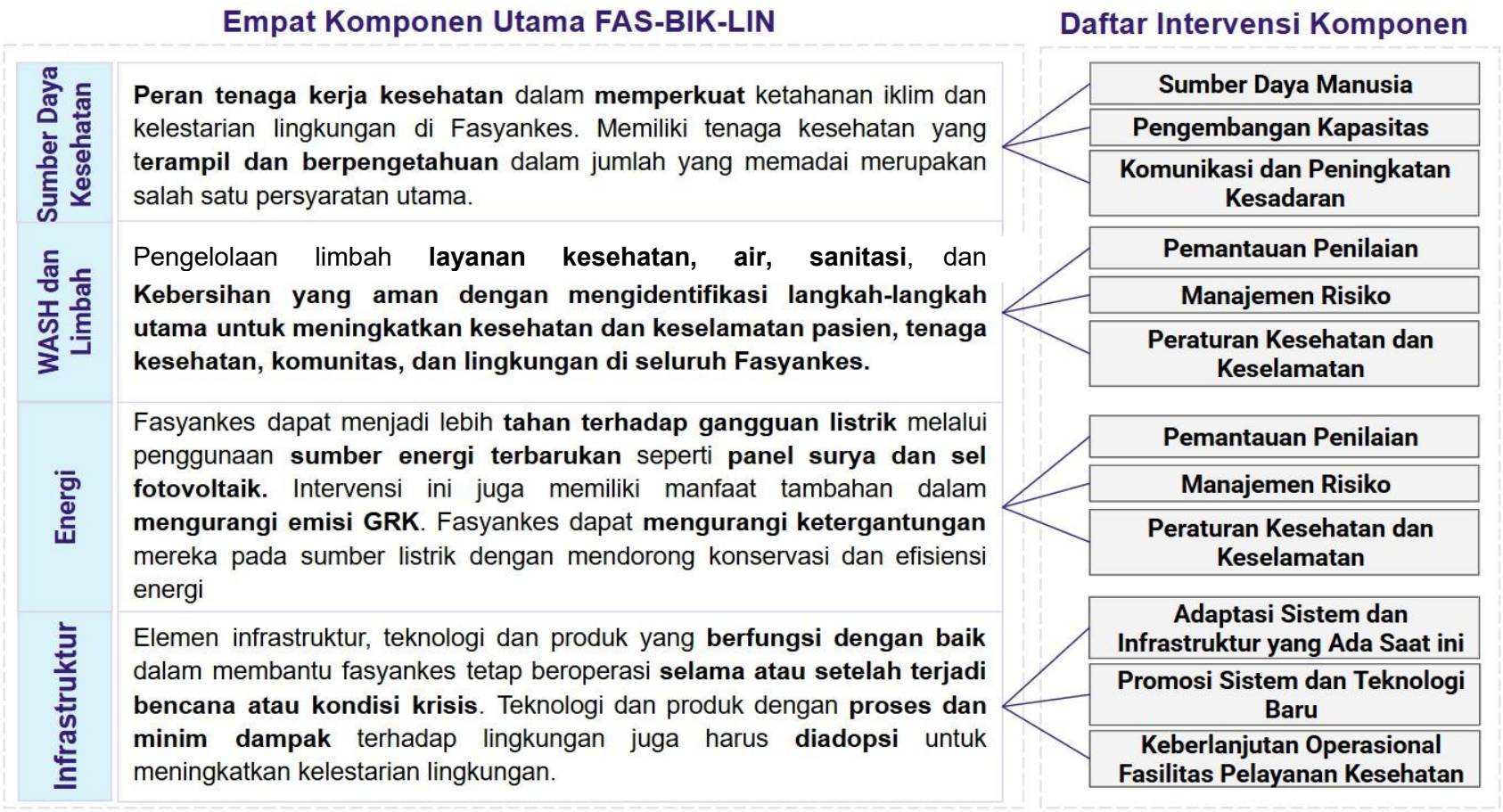
- **Pengelolaan Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH) dan limbah layanan kesehatan :** Pengelolaan air, sanitasi dan limbah layanan kesehatan yang berkelanjutan dan aman;

Tujuan dari pelaksanaan Komponen ini yaitu :

1. **Pemantauan dan Penilaian:** Penyediaan informasi terkait air, sanitasi, penggunaan bahan kimia, dan pengelolaan limbah layanan kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ketahanan iklim dan keberlanjutan lingkungan guna mendorong tindakan nyata.
2. **Manajemen Risiko**: Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola risiko air, sanitasi, bahan kimia, dan limbah medis terhadap tenaga kesehatan, pasien, dan masyarakat yang dilayani, dengan memasukkan penilaian ketahanan iklim dan keberlanjutan lingkungan dalam respons terhadap bahaya serta dalam mengidentifikasi dan mengurangi paparan dan kerentanan.
3. **Peraturan Kesehatan dan Keselamatan**: Penerapan regulasi terkait air, sanitasi, keamanan bahan kimia, dan limbah pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan variabilitas dan perubahan iklim serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

- **Energi** : Layanan energi berkelanjutan;
  Tujuan dari pelaksanaan Komponen ini yaitu :
  1. **Pemantauan dan Penilaian**: Penyediaan Informasi terkait energi terbarukan/energi alternatif untuk mendorong pengambilan tindakan yang tepat.
  2. **Manajemen Risiko**: Penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola risiko terkait energi terhadap tenaga kesehatan, pasien, dan masyarakat yang dilayani, dengan memasukkan penilaian ketahanan iklim dan keberlanjutan lingkungan
  3. **Peraturan Kesehatan dan Keselamatan**: Penerapan regulasi terkait penggunaan dan akses energi dilakukan dengan memperhatikan variabilitas dan perubahan iklim serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

- **Infrastruktur, Teknologi dan Produk:** Infrastruktur dan teknologi yang tepat, termasuk semua operasi yang memungkinkan berfungsinya fasilitas kesehatan secara efisien.
  Tujuan dari pelaksanaan Komponen ini yaitu :
  1. **Adaptasi Sistem dan Infrastruktur yang Ada**: Penerapan regulasi bangunan dalam pembangunan maupun renovasi fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan untuk memastikan ketahanan terhadap iklim dan keberlanjutan lingkungan.
  2. **Promosi Sistem dan Teknologi Baru**: Mengadopsi teknologi dan proses baru yang mampu mendukung ketahanan iklim, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan mutu layanan kesehatan.
  3. **Keberlanjutan Operasional Fasilitas Kesehatan**: Mengadopsi dan melakukan pengadaan teknologi, proses, dan produk yang memiliki dampak lingkungan rendah guna meningkatkan ketahanan terhadap iklim dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

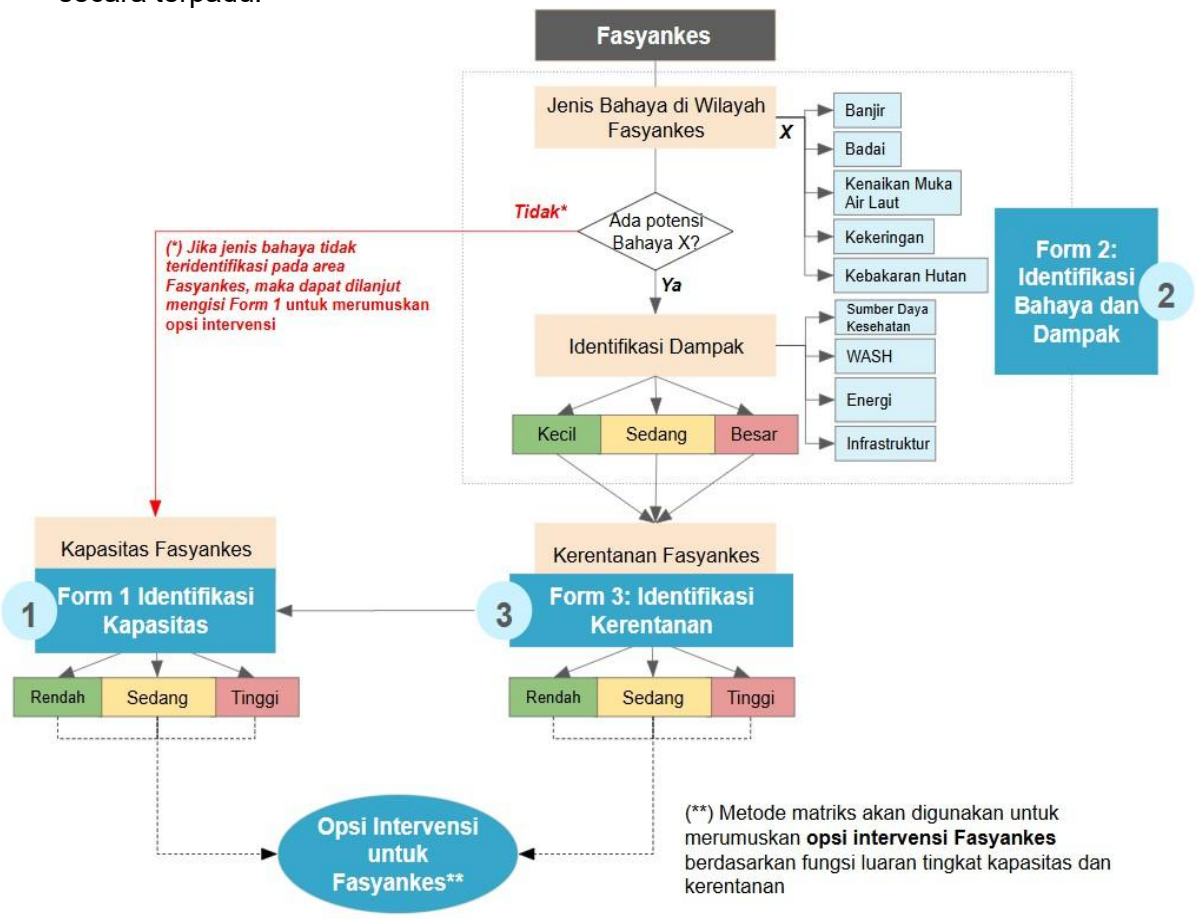


Gambar 3.4. Komponen Penyusun Instrumen Penilaian

3.4 INSTRUMEN PENILAIAN

Fasyankes berperan penting dalam melindungi kesehatan masyarakat, terutama di tengah tantangan perubahan iklim. Untuk memastikan layanan tetap optimal, evaluasi terhadap Fasyankes tidak hanya didasarkan pada kelengkapan pelayanan medis, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi terhadap risiko iklim dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Penilaian Fasyankes berketahanan iklim dilakukan melalui instrumen atau formulir khusus yang disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan fasilitas dalam menghadapi perubahan iklim, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan guna mendukung kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan secara terpadu.



Gambar 3.5. Kerangka kerja formulir penilaian

Tahapan penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim, meliputi:

- **Tahap pertama** (Identifikasi Kapasitas) : mengukur sejauh mana kapasitas fasilitas kesehatan dalam menghadapi bahaya yang telah diidentifikasi (Form 1).
- **Tahap kedua** (Identifikasi Bahaya dan Dampak) : mengidentifikasi jenis bahaya lingkungan yang berpotensi terjadi di wilayah Fasyankes. Jika suatu jenis bahaya teridentifikasi, Fasyankes kemudian menilai dampaknya yang dikategorikan sebagai kecil, sedang, atau besar. Jika tidak ada bahaya yang diidentifikasi, proses dapat langsung dilanjutkan ke tahap ketiga (Form 2).
- **Tahap ketiga** (Identifikasi Kerentanan) : untuk menilai tingkat kerentanan Fasyankes terhadap dampak yang telah diidentifikasi sebelumnya (Form 3)

3.4.1 Formulir Identifikasi Kapasitas

Target: Menilai kapasitas Fasyankes dalam membangun ketahanan iklim dan lestari lingkungan. Selain itu, formulir ini juga menekankan pentingnya pelatihan, kesadaran, dan pemberdayaan tenaga kesehatan dalam mendukung upaya ini.

Hasil: Informasi baseline terkait kondisi Fasyankes dari berbagai aspek, termasuk sumber daya kesehatan, infrastruktur, WASH, dan limbah layanan kesehatan, serta energi. Hasil penilaian dikategorikan dalam tingkat capaian fasilitas kesehatan, yaitu rendah, sedang, atau tinggi.

3.4.2 Formulir Identifikasi Bahaya dan Dampak

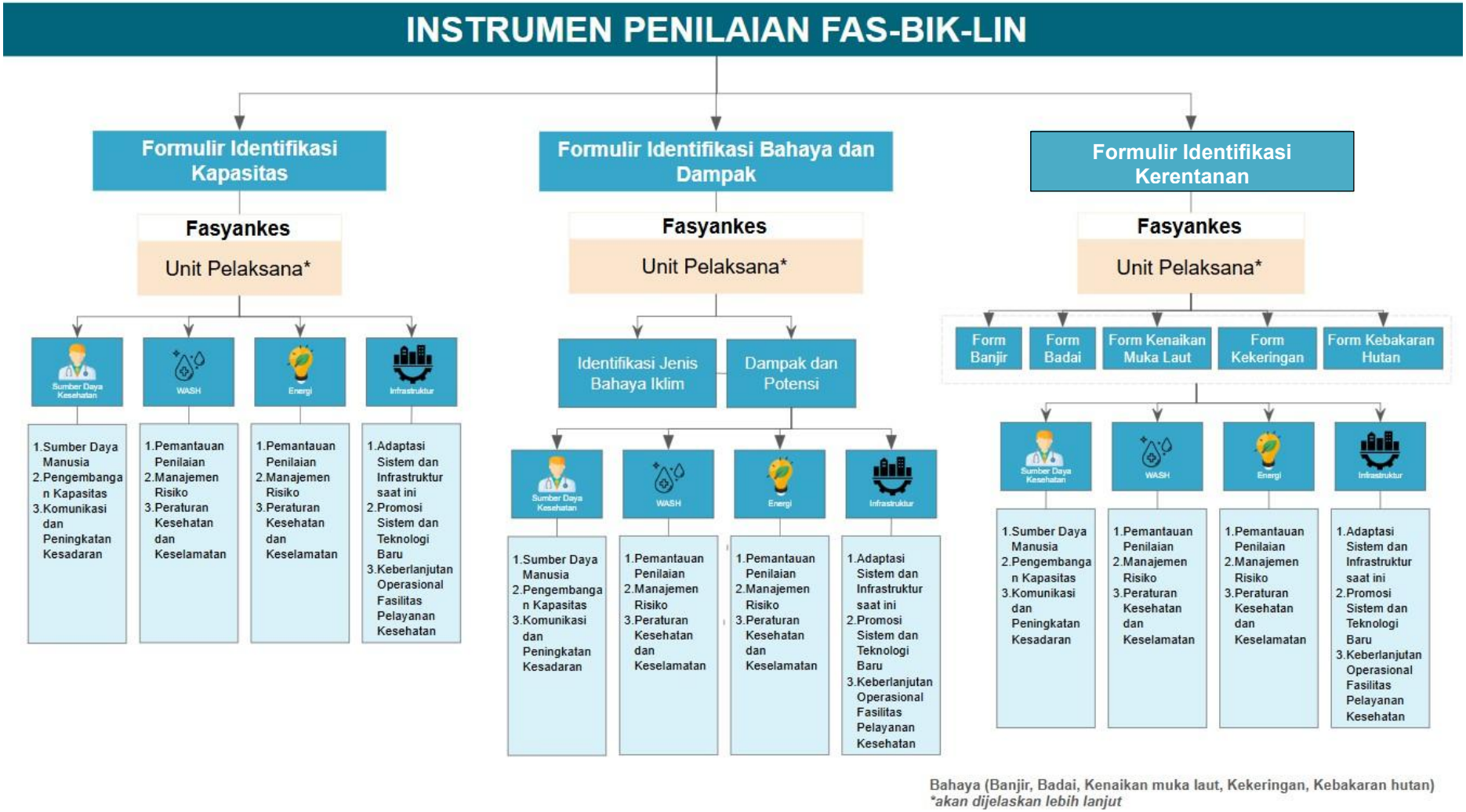
Target: Mengidentifikasi bahaya, potensi, serta dampak yang dihasilkan oleh perubahan iklim berdasarkan lokasi Fasyankes. Formulir ini juga bertujuan mengevaluasi dampak perubahan iklim terhadap Fasyankes dengan menggunakan model matriks risiko yang mengelompokkan bahaya berdasarkan tingkat keparahan dampaknya (besar, sedang, kecil).

Hasil: Peta bahaya dan potensi dampak yang mencakup jenis bahaya iklim di setiap lokasi fasilitas kesehatan. Hasil ini menggambarkan hubungan antara bahaya yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan terhadap sumber daya kesehatan, infrastruktur, WASH, dan energi. Tingkat dampak dinilai dalam kategori besar, sedang, atau kecil.

3.4.3 Formulir Identifikasi Kerentanan

Target: Menilai kerentanan saat ini pada Fasyankes dalam menghadapi bahaya yang teridentifikasi.

Hasil: Pemetaan kerentanan dan tingkat risiko fasilitas kesehatan terhadap bahaya iklim yang mencakup infrastruktur, sumber daya kesehatan, WASH, dan energi. Formulir ini memberikan data untuk memperkuat ketahanan fasilitas kesehatan dengan kategori kerentanan: tinggi, sedang, atau rendah.



3.4.3.1 **Gambar 3.6.** Komponen Instrumen Penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim.

3.5 SKEMA PENGISIAN INSTRUMEN PENILAIAN

3.5.1 Skema Pelaksanaan Pengisian Formulir Penilaian oleh Fasyankes

Penilaian terhadap ketahanan dan keberlanjutan fasilitas kesehatan dalam menghadapi dampak perubahan iklim memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terstruktur. Proses penilaian dimulai dengan pengumpulan data yang komprehensif, yang mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, sistem kesehatan, kapasitas tenaga medis, serta kerentanannya terhadap potensi risiko yang disebabkan oleh perubahan iklim, seperti bencana alam, penyakit terkait iklim, dan kondisi cuaca ekstrem. Pengisian instrumen penilaian yang tepat dan akurat sangat penting untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana fasilitas kesehatan dapat bertahan dan beradaptasi terhadap tantangan tersebut. Penilaian ini tidak hanya untuk mengidentifikasi kerentanannya, tetapi juga untuk memetakan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat. Pengisian penilaian dilakukan secara digital melalui aplikasi SIKELIM (Tabel 4.2). Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi pengumpulan data secara terstruktur dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), baik Puskesmas maupun Rumah Sakit.

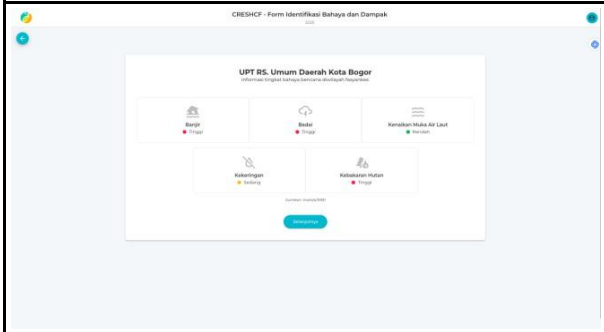
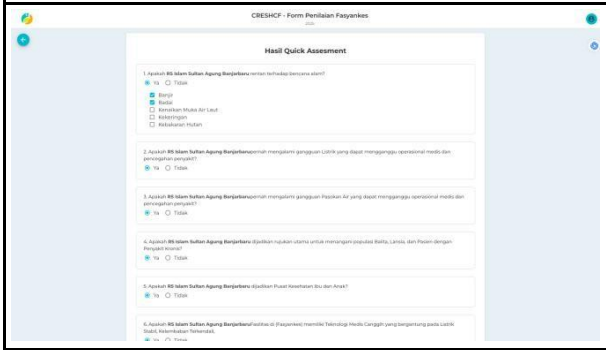
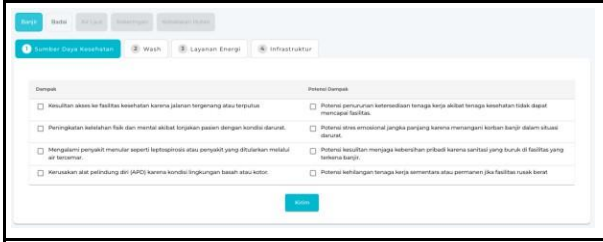
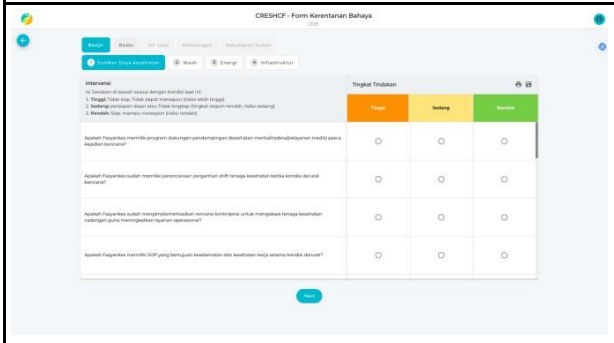
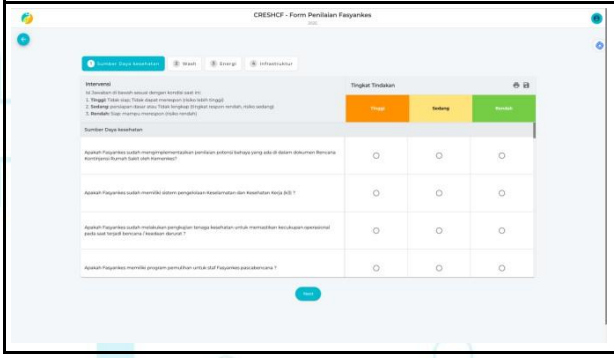
Setiap Fasyankes wajib mengisi tiga formulir utama, yaitu

1. Formulir Identifikasi Kapasitas,
2. Formulir Identifikasi Bahaya dan Dampak,
3. Formulir Identifikasi Kerentanan.

Pengisian dilakukan secara kolektif oleh Tim Pelaksana Fasyankes Berketahanan Iklim di Fasyankes. Data yang dimasukkan mencakup jawaban sesuai dengan kondisi di Fasyankes. SIKELIM secara otomatis mengintegrasikan data tersebut untuk dianalisis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta oleh Kementerian Kesehatan guna mendukung validasi, pemantauan, dan perencanaan program peningkatan ketahanan iklim sektor kesehatan secara nasional.

Tabel 3.2. Tampilan pengisian instrumen FAS-BIK-LIN pada aplikasi SIKELIM

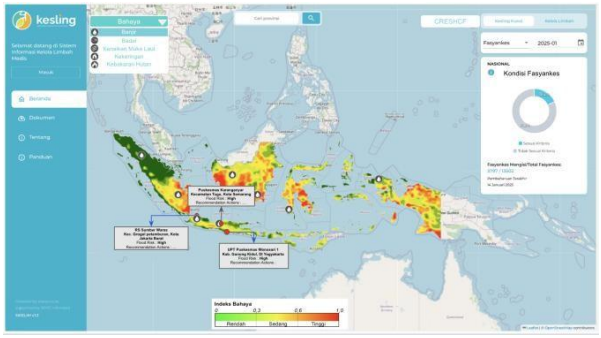
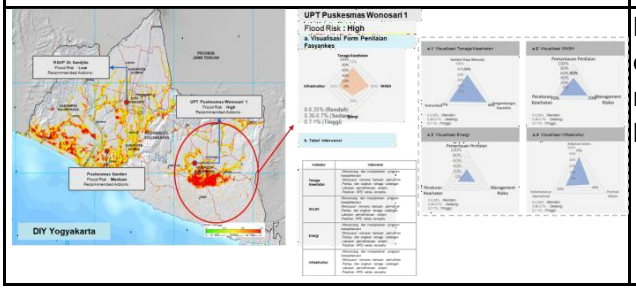
Tampilan Pada SIKELIM	Tahapan
	Tampilan awal pada aplikasi SIKELIM untuk pengisian penilaian FAS-BIK-LIN. Fasyankes akan diarahkan ke dashboard utama yang menampilkan menu navigasi untuk tiga formulir yang tersedia.
	Pada pilihan formulir FAS-BIK-LIN utama, selanjutnya fasyankes akan diarahkan pada pengisian 1. Formulir Identifikasi Bahaya dan Dampak, 2. Formulir Identifikasi Kerentanan Fasyankes, dan 3. Formulir Identifikasi Kapasitas Fasyankes.

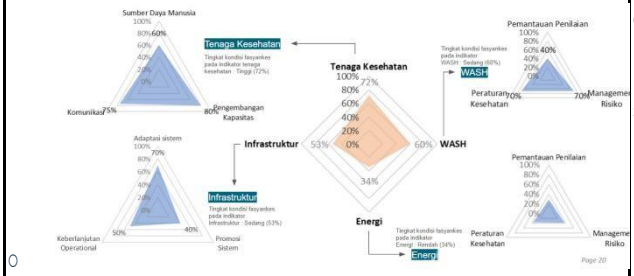
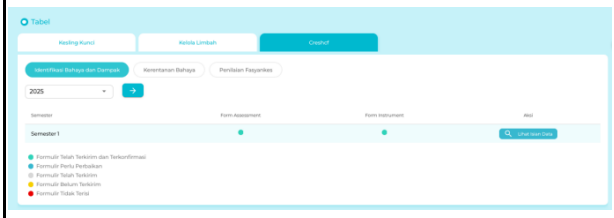
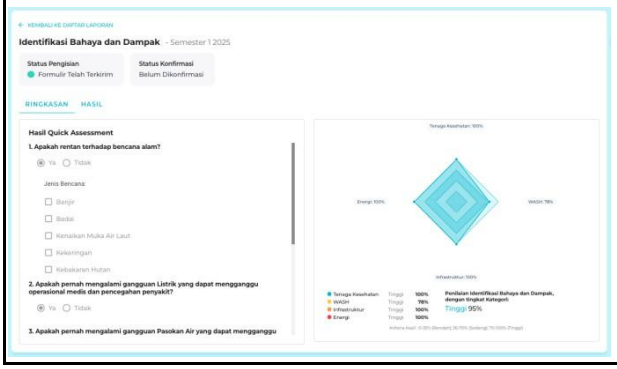
Tampilan Pada SIKELIM	Tahapan
	Masing-masing formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian, status progres (belum diisi, sedang diisi, atau selesai).
	Pada tampilan ini, fasyankes akan mendapatkan informasi risiko bencana yang datanya diintegrasikan dengan INARISK BNPB (https://inarisk.bnpb.go.id/). Fungsinya adalah untuk menginformasikan status risiko bencana dilokasi tempat fasyankes.
	Pada tampilan ini fasyankes akan mengisi pertanyaan umum mengenai profil fasyankes.
	Pada tampilan ini fasyankes akan mengisi formulir FAS-BIK-LIN : Form Identifikasi Bahaya dan Dampak yang terdiri dari 12 pertanyaan di setiap bahaya
	Pada tampilan ini fasyankes akan mengisi formulir FAS-BIK-LIN : Form Identifikasi Kerentanan Bahaya yang terdiri dari : a. Pertanyaan umum : 51 Pertanyaan, b. Pertanyaan khusus : 68 Pertanyaan (banjir 14, badai 10 pertanyaan, kenaikan muka laut 14, kekeringan 14, dan kebakaran hutan 16)
	Pada tampilan ini fasyankes akan mengisi formulir FAS-BIK-LIN : Form Identifikasi Kapasitas Fasyankes yang terdiri dari 46 pertanyaan

Setelah melakukan penilaian data di atas, maka akan keluar visualisasi hasil (Tabel 3.3), berupa informasi berikut

a. Peta informasi risiko iklim
b. Grafik hasil penilaian pada komponen sumber daya kesehatan, infrastuktur, WASH, dan energi pada Fasyankes
c. Status pada masing-masing Fasyankes terkait kapasitas, kerentanan, dan potensi bahaya
d. Tabel rekomendasi intervensi tindak lanjut dari hasil penilaian

Tabel 3.3. Visualisasi hasil penilaian FAS-BIK-LIN pada aplikasi SIKELIM

Tampilan Pada SIKELIM	Penjelasan
	Hasil penilaian FAS-BIK-LIN akan memberikan informasi risiko, kapasitas dan dampak perubahan iklim yang ada diwilayah dan pernah dialami oleh Fasyankes.
	Masing-masing hasil isian formulir akan diilustrasikan dalam *Petal Chart* yang menampilkan presentasi setiap isian komponen.

Tampilan Pada SIKELIM	Penjelasan
  	Berdasarkan tingkat kesiapan yang dihasilkan dari instrumen penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim, setiap Fasyankes akan dikategorikan dalam salah satu dari tiga tingkat kesiapan berikut: 1. **Tingkat Tinggi** → Fasyankes memiliki ketahanan iklim yang baik dan dapat dijadikan model bagi fasilitas lain. 2. **Tingkat Sedang** → Fasyankes sudah memiliki beberapa inisiatif ketahanan iklim, tetapi masih memerlukan penguatan di beberapa aspek. 3. **Tingkat Rendah** → Fasyankes memiliki banyak kelemahan dalam ketahanan iklim dan memerlukan intervensi segera. Untuk setiap tingkat kesiapan, akan diberikan rekomendasi **aksi yang harus dilakukan**, baik dalam bentuk perbaikan internal maupun dukungan eksternal dari Dinas Kesehatan dan lembaga terkait.

Pemanfaatan hasil penilaian ini penting untuk merancang strategi adaptasi yang efektif, memperbaiki kapasitas infrastruktur, dan meningkatkan kesiapan tenaga medis dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

3.5.2 Skema Perhitungan Instrumen Penilaian

a. Formulir 1 - Identifikasi Kapasitas Fasyankes

Identifikasi kapasitas fasyankes dilakukan berdasarkan sejumlah indikator utama, yakni sumber daya kesehatan, WASH dan Limbah layanan kesehatan, energi, serta infrastruktur, yang secara keseluruhan terdiri dari 46 elemen penilaian. Elemen-elemen ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat penilaian, yaitu Tingkat 1, Tingkat 2, dan Tingkat 3, yang merepresentasikan hierarki kesiapsiagaan mulai dari skala internal hingga eksternal pelayanan kesehatan. Penilaian dilakukan dengan menilai tiga aspek utama, yaitu **sistem dan prosedur internal**, **kapasitas sumber daya manusia**, dan **dukungan sarana eksternal.**

Penilaian dilakukan dengan menggunakan tiga tingkat skoring:

- **Pertanyaan Tingkat 1 (Bobot 3)**, yang mencakup aspek internal penting seperti infrastruktur dasar dan sistem pemulihan.
- **Pertanyaan Tingkat 2 (Bobot 2)**, yang menghubungkan sistem internal dengan pelayanan langsung, seperti pelatihan tenaga medis dan koordinasi.
- **Pertanyaan Tingkat 3 (Bobot 1)**, yang meliputi dukungan eksternal seperti transportasi dan edukasi masyarakat.

Setiap elemen dari ketiga tingkat ini dinilai berdasarkan tiga kategori kesiapan aksi: **Rendah (1)**, **Sedang (2)**, dan **Tinggi (3)**. Skor total diperoleh dengan menjumlahkan skor untuk setiap tingkat dan mengalikan dengan bobot yang sesuai. Dengan pendekatan ini, penilaian kapasitas fasyankes menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Tabel 3.4. Tabel skoring perhitungan formulir identifikasi kapasitas Fasyankes

Kategori Pertanyaan (a)	Jumlah Pertanyaan (b)	Kriteria Jawaban (c)	Bobot (d)	Skor Akhir (x)
Tingkat 1	24	Tinggi = 3 Sedang = 2 Rendah = 1	3	$X_{t1} = b*c_t*d$ $X_{s1} = b*c_s*d$ $X_{r1} = b*c_r*d$
Tingkat 2	9	Tinggi = 3 Sedang = 2 Rendah = 1	2	$X_{t2} = b*c_t*d$ $X_{s2} = b*c_s*d$ $X_{r2} = b*c_r*d$
Tingkat 3	13	Tinggi = 3 Sedang = 2 Rendah = 1	1	$X_{t3} = b*c_t*d$ $X_{s3} = b*c_s*d$ $X_{r3} = b*c_r*d$

b. Formulir 2 - Identifikasi Bahaya dan Dampak

Bagian ini mengukur dampak bahaya yang dialami fasyankes akibat perubahan iklim, seperti banjir, badai/angin puting beliung, kenaikan muka laut, kekeringan, dan kebakaran hutan.

Cara Skoring:

- **Daftar isian Tingkat 1 (Dampak Besar, Bobot 3)**: Gangguan besar yang memengaruhi hampir seluruh kapasitas fasyankes.
- **Daftar isian Tingkat 2 (Dampak Sedang, Bobot 2)**: Gangguan sedang yang memengaruhi sebagian fungsi fasyankes.
- **Daftar isian Tingkat 3 (Dampak Kecil, Bobot 1)**: Gangguan ringan yang tidak menghambat layanan utama.

Skor dihitung dengan cara yang sama seperti formulir pertama, setiap elemen dari ketiga tingkat ini dinilai berdasarkan tiga kategori kesiapan aksi: **Kecil (1), Sedang (2), dan Besar (3)** dan menghitung jumlah pertanyaan yang masuk dalam setiap kategori dan mengalikan dengan bobot yang sesuai.

Tabel 3.5 Tabel skoring perhitungan identifikasi Bahaya dan Dampak

Kategori Pertanyaan (a)	Jumlah isian terceklis (b)	Kriteria Jawaban (c)	Skor Akhir (x)
Tingkat 1	n	Besar = 3	$X_{b1} = b*c_t$
Tingkat 2	n	Sedang = 2	$X_{s2} = b*c_s$
Tingkat 3	n	Kecil = 1	$X_{k3} = b*c_r$

n = jumlah isian terceklis pada satu kategori pertanyaan (sesuai jumlah dampak yang dirasakan fasyankes)

c. **Formulir 3 - Identifikasi Kerentanan terhadap Bahaya**
Penilaian ini mengukur kerentanan fasyankes terhadap berbagai bahaya akibat perubahan iklim seperti banjir, badai/angin puting beliung, kenaikan muka laut, kekeringan, dan kebakaran hutan.

Cara Skoring:

- **Pertanyaan Tingkat 1 (Bobot 3)**: Pertanyaan yang menggambarkan kondisi dasar dan kerentanan umum fasyankes. - Pertanyaan Umum
- **Pertanyaan Tingkat 2 (Bobot 2)**: Pertanyaan teknis yang menggali kondisi lebih rinci dan spesifik terkait bahaya. - Pertanyaan Khusus

Skor dihitung dengan cara yang sama dengan formulir pertama, setiap elemen dari ketiga tingkat ini dinilai berdasarkan tiga kategori kesiapan aksi:

- **Rendah (3),**
- **Sedang (2),**
- **Tinggi (1)**

Tiga kategori ini mengklasifikasikan pertanyaan ke dalam kategori tingkat 1 dan tingkat 2, kemudian mengalikannya dengan bobot. Penjelasan spesifik terkait perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 3.6 Tabel skoring perhitungan identifikasi kerentanan

Kategori Pertanyaan (a)	Jumlah Pertanyaan (b)	Kriteria Jawaban (c)	Bobot (d)	Skor Akhir (x)
Tingkat 1	51	Tinggi = 1 Sedang = 2 Rendah = 3	3	$X_{t1} = b*c_t*d$ $X_{s1} = b*c_s*d$ $X_{r1} = b*c_r*d$
Tingkat 2	68	Tinggi = 1 Sedang = 2 Rendah = 3	2	$X_{t2} = b*c_t*d$ $X_{s2} = b*c_s*d$ $X_{r2} = b*c_r*d$

3.6 PENYUSUNAN REKOMENDASI INTERVENSI

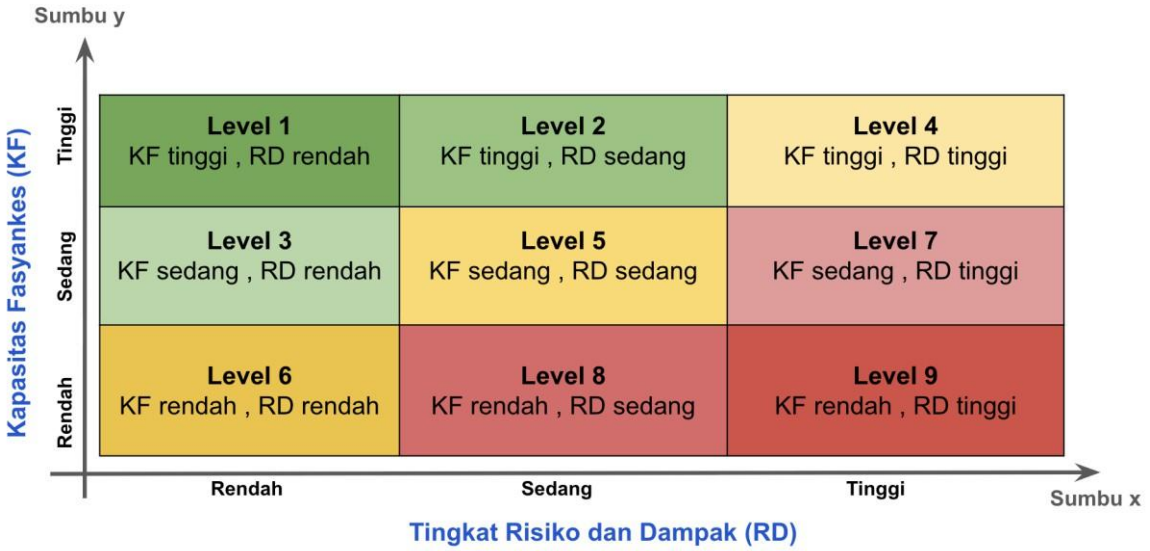
Membangun fasilitas kesehatan kesehatan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan lestari lingkungan memerlukan rencana aksi yang komprehensif. Rencana ini mencakup berbagai langkah strategis yang disusun secara kolaboratif dengan mempertimbangkan kondisi spesifik setiap Fasyankes fasilitas kesehatan serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasinya.

Penilaian Fasyankes telah dilakukan pada bagaian 4.3. Masing-masing pertanyaan dan formulir memiliki bobot yang digunakan untuk menentukan status level Fasyankes pada aspek kapasitas, respons terhadap bahaya dan dampak, serta kondisi kerentanan. Status tersebut kemudian menjadi dasar penentuan status akhir fasyankes dalam penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim.

3.6.1 Rekomendasi Strategi Intervensi

Rekomendasi strategi dirancang dengan mengelaborasi hasil penilaian hasil penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim (formulir 1, 2, 3). Pengembangan strategi dilakukan dengan pendekatan matriks **(Gambar 4.4).** Tingkat Kapasitas Fasyankes (Sumbu Y) dihasilkan dari penilaian Formulir 1 (Form Kapasitas Fasyankes). Sumbu Y memberikan

intervensi berdasarkan tingkat kapasitas Fasyankes dalam menghadapi perubahan iklim termasuk pemberdayaan sumber daya kesehatan (SDM) serta pengelolaan infrastruktur, energi, dan WASH. Sementara Tingkat Risiko dan Dampak Sumbu X dihasilkan dari pengisian Formulir 2 (Form Identifikasi Bahaya dan Dampak) dan Formulir 3 (Form Identitfikasi Kerentanan terhadap Bahaya). Sumbu X menunjukkan seberapa besar potensi bahaya yang mungkin timbul (seperti banjir, kekeringan, suhu ekstrem), serta dampaknya pada Fasyankes. Rekomendasi intervensi diilustrasikan pada Gambar 3.7



Gambar 3.7. Matriks status akhir Fasyankes berdasarkan hasil penilaian formulir 1, 2, dan 3

Hasil penilaian pada Bagian 3.2 akan menempatkan Fasyankes pada matriks tingkat (level) 1 hingga 9 sebagai status akhir Fasyankes. Masing-masing level diberikan rekomendasi strategi yang dirincikan pada **Tabel 3.7.** Rekomendasi strategi intervensi diarahkan untuk mencapai posisi ideal Fasyankes pada matriks berwarna hijau (level 1). Pada posisi hijau, Fasyankes dianggap sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapai potensi bahaya dan gangguan iklim. Strategi kemudian digunakan sebagai dasar merumuskan rekomendasi intervensi terperinci setiap komponen yang akan dijelaskan pada bagian 3.6.2.

Tabel 3.7 Strategi Intervensi berdasarkan Status Fasyankes

Level	Definisi Operasional	Strategi Intervensi	Contoh Kondisi Fasyankes
1 KF tinggi , RD rendah	Fasyankes memiliki kapasitas tinggi dan hanya menghadapi tekanan lingkungan yang rendah, cocok untuk percontohan ketahanan iklim	Pemeliharaan kapasitas Fasyankes untuk mencegah peningkatan risiko *(contoh: pelatihan reguler SDM, pemeliharaan rutin infrastruktur dan WASH, penyediaan energi berkelanjutan, dan replikasi praktik baik)*	RS Tipe B di kota besar dengan sistem energi cadangan terintegrasi, IPAL berfungsi, SDM terlatih menghadapi bencana, dan tidak berada di zona rawan banjir
2 KF tinggi , RD sedang	Fasyankes memiliki kapasitas baik, tapi menghadapi tantangan lingkungan yang mulai kompleks	Penguatan adaptasi lokal dengan memperkuat ketahanan terhadap potensi risiko iklim yang berkembang *(contoh: Pembaruan SOP, penguatan manajemen WASH dan cadangan energi)*	Puskesmas rawat inap di pinggir kota dengan fasilitas lengkap tapi mulai terdampak banjir musiman atau suhu ekstrem
3 KF sedang, RD rendah	Fasyankes memiliki tantangan utama pada kapasitas internal yang belum maksimal, walau tekanan lingkungan masih rendah.	Peningkatan kapasitas internal SDM dan pelayanan dasar Fasyankes *(contoh: Pelatihan SDM, aktivasi IPAL, pasokan air bersih, dan penambahan cadangan energi minimum)*	Puskesmas pedesaan yang belum memiliki sistem energi cadangan atau pengelolaan limbah, tapi lokasinya aman dari risiko iklim
4 KF tinggi, RD tinggi	Fasyankes sudah memiliki kapasitas tinggi, namun berada dalam kondisi lingkungan yang sangat rentan terhadap dampak iklim.	Meningkatkan perlindungan terhadap bencana agar kapasitas yang tinggi tidak terganggu oleh tekanan lingkungan ekstrem *(contoh: renovasi fisik bangunan, meningkatkan sistem evakuasi, proteksi IPAL dan cadangan energi dari gangguan cuaca dan iklim)*	RSUD di daerah pesisir yang kerap terdampak rob dan angin kencang, tapi memiliki SDM dan infrastruktur yang kuat
5 KF sedang, RD sedang	Fasyankes dengan kapasitas dan risiko pada tingkat sedang	Memperkuat sistem di Fasyankes secara menyeluruh dan bertahap untuk menurunkan risiko *(contoh: peningkatan simultan pada SDM, infrastruktur, WASH, dan energi)*	Puskesmas di pinggiran kota dengan sistem IPAL semiaktif, air terbatas saat musim kemarau, dan pasokan listrik tidak stabil.

Level	Definisi Operasional	Strategi Intervensi	Contoh Kondisi Fasyankes
6 KF rendah, RD rendah	Fasyankes memiliki kapasitas rendah, tapi masih diuntungkan oleh tekanan lingkungan yang belum signifikan.	Meningkatkan kapasitas dasar sebelum risiko meningkat *(contoh: pelatihan rutin SDM, pemeliharaan infrastruktur dasar, integrasi IPAL skala kecil dan energi cadangan)*	Puskesmas di kota kecil dengan sistem IPAL semiaktif, air terbatas saat musim kemarau, dan pasokan listrik tidak stabil.
7 KF sedang, RD tinggi	Fasyankes masih memiliki kapasitas menengah, namun sangat rentan karena tekanan risiko tinggi yang dapat melampaui kemampuan tanggapnya.	Meningkatkan respons cepat untuk mencegah gangguan layanan saat bencana *(contoh: Penyediaan logistik darurat, evakuasi SDM, proteksi fasilitas esensial (laboratorium, ruang bersalin))*	Puskesmas di daerah lereng dengan akses jalan rawan longsor, SDM terbatas, dan IPAL tidak memadai.
8 KF rendah, RD sedang	Fasyankes berada dalam kondisi kapasitas lemah dan tekanan lingkungan sedang, sehingga rentan terhadap gangguan operasional berulang.	Melakukan rehabilitasi layanan dasar dan meminimalkan risiko gangguan iklim yang meningkat atau berulang *(contoh: pelatihan dasar untuk kesiapsiagaan dan peningkatan layanan dasar)*	Puskesmas di wilayah satelit perkotaan padat penduduk dengan sanitasi buruk, SDM minim, dan kerap terjadi gangguan layanan akibat listrik.
9 KF rendah, RD tinggi	Fasyankes menghadapi situasi paling kritis, dengan kapasitas rendah dan tekanan risiko tinggi yang dapat menyebabkan layanan dasar terhenti saat krisis atau bencana	Intervensi darurat (cepat dan tepat) dengan dukungan lintas sektor (vertikal dan horizontal) *(contoh: pemulihan total fasilitas, pasokan air dan energi darurat, pendampingan teknis intensif, relokasi jika perlu)*	Puskesmas rawat inap di daerah rawan banjir tahunan dengan IPAL rusak, tanpa energi cadangan, dan SDM tidak siap menghadapi bencana.

3.6.2 Rekomendasi Intervensi Aksi

Rekomendasi intervensi aksi dikembangkan sesuai dengan status akhir fasyankes terhadap kapasitas dan tingkat risiko dampaknya. Rekomendasi dirancang untuk membantu berbagai pihak dalam mengidentifikasi aksi strategis untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan fasilitas kesehatan. Masing-masing level status Fasyankes akan memperoleh 12 rekomendasi intervensi aksi yang terdiri dari komponen berikut:

1. **Sumber Daya Kesehatan**, dalam bentuk aksi: Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kapasitas, Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran
2. **WASH dan Limbah layanan kesehatan**, dalam bentuk aksi : Pemantauan dan Penilaian, Manajemen Risiko, Peraturan Kesehatan dan Keselamatan
3. **Energi,** dalam bentuk aksi: Pemantauan dan Penilaian, Manajemen Risiko, Peraturan Kesehatan dan Keselamatan
4. **Infrastruktur**, dalam bentuk aksi: Adaptasi Sistem dan Infrastruktur Eksisting, Promosi Sistem dan Teknologi Baru, Keberlanjutan Operasional Fasyankes

Rekomendasi intervensi dirincikan menjadi komponen, bentuk atau jenis intervensi, rekomendasi aksi, pihak terlibat, indikatif waktu pelaksanaan dan potensi kebutuhan biaya. Kriteria pengembangan rekomendasi intervensi aksi dijelaskan pada **Tabel 3.8**. Selanjutnya rincian rekomendasi aksi disajikan pada **Tabel 3.9.**

Tabel 3.8 Kriteria dan tahapan pengembangan rekomendasi intervensi aksi

Kolom	Kriteria Pengembangan Komponen Intervensi
A	**Startegi Intervensi** berdasarkan status akhir Fasyankes untuk meningkatkan kapasitas dan meminimalisir risiko dampak
B	**Komponen Intervensi** yang difokuskan untuk Sumber Daya Kesehatan, WASH dan Limbah layanan kesehatan, Energi, Infrastruktur. Bagian ini merujuk pada komponen Panduan WHO
C	**Jenis/Bentuk intervensi** merupakan kelompok jenis kegiatan dari komponen intervensi berdasarkan panduan WHO, masing-masing komponen terdiri dari tigas jenis/bentuk intervensi aksi
D	Rekomendasi aksi didasarkan pada klaster warna status akhir Fasyankes, meliputi: • **klaster hijau (Level 1 - 3) :** Intervensi bersifat preventif fan promotif untuk pemeliharaan kapasitas, dominan aksi *soft intervention* (non-fisik) • **klaster kuning (Level 4 - 6) :** Intervensi struktural dan non-struktural *(hard and soft intervention)* untuk penyesuaian terhadap tantangan lingkungan yang berkembang • **klaster merah (level 7 - 9) :** Fokus pada intervensi dengan respon cepat, darurat, dan pemulihan minimum. Penekanan pada mobilisasi sumber daya eksternal, relawan, atau sistem darurat
E	Unit pada Fasyankes yang bertanggung jawab dan melaksanakan intervensi
F	Penentuan jangka waktu pelaksanaan aksi mempertimbangkan kriteria berikut: **Jangka Pendek (1 - 2 tahun):** • Dapat segera dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia saat ini. • Tidak memerlukan proses perencanaan atau persiapan teknis kompleks. • Berdampak langsung merespons bahaya iklim di wilayah Fasyankes • Fokus pada perbaikan cepat, penyadartahuan, atau respons awal, serta penyediaan SOP dan panduan. **Jangka Menengah (3 - 5 tahun):** • Membutuhkan proses perencanaan, koordinasi lintas sektor, atau uji coba. • Efek intervensi baru akan terlihat setelah beberapa tahun. • Biaya sedang hingga tinggi. • Fokus pada penguatan kelembagaan, kolaborasi, sistem pemantauan, atau infrastruktur skala sedang.

Kolom	Kriteria Pengembangan Komponen Intervensi
	Jangka Panjang (>5 tahun): • Memerlukan investasi besar, perencanaan lintas dokumen kebijakan (RPJMD, RTRW, Renstras Dinas Kesehatan atau lintas sektor). • Terkait dengan transformasi sistemik atau struktural. • Dampaknya baru akan terlihat dalam waktu lama. • Melibatkan teknologi, perencanaan ruang, atau kolaborasi multi-aktor skala besar. • Fokus pada pemeliharaan, peningkatan, dan penggunakan energi bersih
G	Indikatif kebutuhan anggaran untuk melaksanakan intervensi. Kategori biaya mempertimbangkan kriteria berikut: **Biaya rendah** • Kegiatan non-fisik *(soft intervensi)* atau dapat dilakukan dengan peralatan ringan • Dapat dilaksanakan cepat dan dengan sumber daya yang tersedia di Fasyankes • Dapat dilakukan dengan anggaran rutin yang sudah tersedia **Biaya sedang** • Kombinasi intervensi fisik dan non-fisik *(mix soft and hard intervention)* • Memerlukan konsultan, kontraktor lokal, atau pengadaan peralatan sedang • Melibatkan koordinasi dengan pihak luar atau teknis tertentu **Biaya tinggi** • Umumnya diperlukan untuk intervensi fisik *(hard intervention)* • Memerlukan perizinan, integrasi sistem, atau dasar hukum untuk pelaksanaan • Memerlukan koordinasi lintas sektor di luar Fasyankes Biaya secara kuantitatif mungkin berbeda tergantung jenis Fasyankes dan lokasi Fasyankes. Kategorisasi biaya ini bersifat indikatif yang perlu dilakukan analisis dan persiapan lebih lanjut dengan konteks lokal dan lokasi Fasyankes.

Tabel 3.9. Rincian Intervensi Aksi berdasarkan Strategi pada masing-masing Status Fasyankes

(A) Strategi	(B) Komponen Intervensi	(C) Jenis / Bentuk Intervensi	(D) Rekomendasi aksi	(E) Penanggung Jawab / Pelaksana	(F) Indikatif Pelaksanaan	(G) Indikatif Pembiayaan
Level 1: KF tinggi , RD rendah						
Pemeliharaan kapasitas Fasyankes untuk mencegah peningkatan risiko	**Sumber Daya Kesehatan**	Sumber Daya Manusia	1.1. Identifikasi dan pemetaan SDM terlatih tanggap iklim dan darurat bencana di Fasyankes	Unit SDM / Kepegawaian	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Pengembangan Kapasitas	1.2. Pelatihan lanjutan untuk *green hospital, green procurement,* dan sistem layanan berkelanjutan	Unit Diklat / SDM	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran	1.3. Kampanye internal tentang efisiensi energi dan adaptasi iklim	Unit Humas / Promosi Kesehatan	Jangka Pendek	Biaya Rendah
	WASH dan Limbah layanan kesehatan	Pemantauan dan Penilaian	1.4. Audit berkala kualitas air bersih dan fungsi IPAL di lingkungan fasyankes	Unit K3 / Sanitasi	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	1.5. Penyusunan SOP penanganan limbah layanan kesehatan saat bencana atau gangguan layanan	Unit Sanitasi / K3	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	1.6. Peninjauan ulang peraturan internal tentang standar kebersihan, IPAL, dan sanitasi lingkungan	Unit Mutu / K3	Jangka Menengah	Biaya Sedang
	Energi	Pemantauan dan Penilaian	1.7. Monitoring penggunaan energi harian dan audit beban listrik di tiap unit layanan	Unit Umum / Sarpras	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	1.8. Penyusunan rencana kontinjensi energi saat gangguan listrik (genset, UPS, inverter)	Unit Umum / Sarpras / K3	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	1.9. Evaluasi ulang sistem kelistrikan dan kelayakan proteksi instalasi terhadap bahaya kebakaran	Unit Umum / Sarpras / K3	Jangka Menengah	Biaya Sedang
	Infrastruktur	Adaptasi sistem dan infrastruktur eksisting	1.10. Pemeliharaan rutin fisik bangunan utama dan saluran drainase	Unit Sarana dan Prasarana / Infrastruktur (MFK)	Jangka Pendek	Biaya Rendah

(A) Strategi	(B) Komponen Intervensi	(C) Jenis / Bentuk Intervensi	(D) Rekomendasi aksi	(E) Penanggung Jawab / Pelaksana	(F) Indikatif Pelaksanaan	(G) Indikatif Pembiayaan
		Promosi sistem dan teknologi baru	1.11. Perencanaan penggunaan material bangunan ramah iklim untuk renovasi mendatang	Unit Sarpras / Perencana dan Anggaran / Infrastrtuktur (MFK)	Jangka Panjang	Biaya Tinggi
		Keberlanjutan operasional Fasyankes	1.12. Penyusunan rencana jangka panjang keberlanjutan fasilitas menghadapi perubahan iklim	Tim Manajemen Fasyankes	Jangka Panjang	Biaya Tinggi
2 - KF tinggi , RD sedang						
Penguatan adaptasi lokal dengan memperkuat ketahanan terhadap potensi risiko iklim yang berkembang	**Sumber Daya Kesehatan**	Sumber Daya Manusia	2.1. Penugasan ulang SDM kunci ke unit rawan iklim dan penguatan shift krisis	Unit SDM/Kepegawaian/ Manajemen Mutu	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Pengembangan Kapasitas	2.2. Pelatihan simulasi bencana iklim untuk seluruh staf dan penyusunan jadwal berkala	Unit Diklat / Manajemen Mutu	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran	2.3. Penyebarluasan materi komunikasi risiko iklim berbasis lokal kepada staf dan pengunjung	Unit Promosi Kesehatan/ Humas	Jangka Pendek	Biaya Rendah
	WASH dan Limbah layanan kesehatan	Pemantauan dan Penilaian	2.4. Peningkatan frekuensi inspeksi sanitasi dan IPAL saat musim hujan dan panas ekstrem	Unit Sanitasi/K3/ Manajemen Risiko	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	2.5. Peningkatan kapasitas tampung limbah dengan antisipasi limpasan saat banjir lokal	Unit Sarpras/K3/ Manajemen Risiko	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	2.6. Penyusunan regulasi internal tanggap gangguan sanitasi akibat gangguan iklim	Unit K3/Manajemen Mutu	Jangka Menengah	Biaya Sedang
	Energi	Pemantauan dan Penilaian	2.7. Audit ketersediaan cadangan energi dan evaluasi beban puncak saat cuaca ekstrem	Unit Umum /Teknologi	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	2.8. Penguatan kapasitas baterai cadangan untuk mempertahankan operasional ruang kritis	Unit Teknologi/Sarpras/ MFK (Infrastrtuktur)	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	2.9. Revisi SOP kelistrikan untuk memasukkan respon darurat terhadap gangguan iklim	Unit Teknologi/K3 / Manajemen Risiko	Jangka Menengah	Biaya Sedang

(A) Strategi	(B) Komponen Intervensi	(C) Jenis / Bentuk Intervensi	(D) Rekomendasi aksi	(E) Penanggung Jawab / Pelaksana	(F) Indikatif Pelaksanaan	(G) Indikatif Pembiayaan
	Infrastruktur	Adaptasi sistem dan infrastruktur eksisting	2.10. Pemasangan talang air tambahan dan perbaikan elevasi pintu ruang pelayanan	Unit Sarpras/ Perencanaan	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Promosi sistem dan teknologi baru	2.11. Pilot proyek penggunaan atap reflektif atau ventilasi alami tahan panas	Unit Sarpras/ Perencanaan	Jangka Panjang	Biaya Tinggi
		Keberlanjutan operasional Fasyankes	2.12. Integrasi risiko iklim dalam rencana kerja tahunan dan sistem manajemen mutu	Tim Manajemen Fasyankes	Jangka Menengah	Biaya Sedang
Level 3 - KF sedang, RD rendah						
Peningkatan kapasitas internal SDM dan pelayanan dasar Fasyankes	**Sumber Daya Kesehatan**	Sumber Daya Manusia	3.1. Pemetaan kebutuhan tenaga fungsional dan non-fungsional untuk layanan dasar	Unit SDM/Kepegawaian	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Pengembangan Kapasitas	3.2. Pelatihan dasar kesiapsiagaan darurat untuk seluruh petugas medis dan non-medis	Unit Diklat/SDM	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran	3.3. Sosialisasi internal tentang prosedur dasar respons terhadap gangguan layanan	Unit Promosi Kesehatan/ Humas	Jangka Pendek	Biaya Rendah
	WASH dan Limbah layanan kesehatan	Pemantauan dan Penilaian	3.4. Pengecekan kualitas air bersih dan kondisi IPAL secara manual setiap minggu	Unit Sanitasi/K3/Sarpras	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	3.5. Pembangunan IPAL sederhana atau sumur resapan sebagai sistem minimum pengolahan limbah	Unit Sanitasi /K3/Sarpras	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	3.6. Penyusunan SOP dasar untuk pemakaian air bersih dan pengelolaan limbah harian	Unit K3/Sanitasi	Jangka Pendek	Biaya Rendah
	Energi	Pemantauan dan Penilaian	3.7. Pencatatan manual konsumsi energi harian dan jam nyala listrik	Unit Sarpras/Umum	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	3.8. Penyediaan genset atau inverter portable untuk ruang pelayanan kritis	Unit Sarpras/Umum	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	3.9. Pembuatan protokol pemadaman listrik dan alur evakuasi pasien saat listrik padam	Unit K3/Sarpras/Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Pendek	Biaya Rendah

(A) Strategi	(B) Komponen Intervensi	(C) Jenis / Bentuk Intervensi	(D) Rekomendasi aksi	(E) Penanggung Jawab / Pelaksana	(F) Indikatif Pelaksanaan	(G) Indikatif Pembiayaan
	Infrastruktur	Adaptasi sistem dan infrastruktur eksisting	3.10. Perbaikan ringan atap bocor, keretakan tembok, dan jalur air hujan	Unit Sarpras/Perencana dan Anggaran/ Infrastrtuktur (MFK)	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Promosi sistem dan teknologi baru	3.11 Pemasangan ventilasi silang alami untuk sirkulasi ruang tunggu dan rawat inap	Unit Sarpras/Perencana dan Anggaran/ Infrastrtuktur (MFK)	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Keberlanjutan operasional Fasyankes	3.11. Pembuatan rencana pengembangan infrastruktur dasar 3–5 tahun ke depan	Tim Manajemen Fasyankes	Jangka Menengah	Biaya Sedang
Level 4 - KF tinggi, RD tinggi						
Meningkatkan perlindungan terhadap bencana agar kapasitas yang tinggi tidak terganggu oleh tekanan lingkungan ekstrem	**Sumber Daya Kesehatan**	Sumber Daya Manusia	4.1. Pemetaan SDM kritis dan pengaturan shift darurat untuk menghadapi risiko iklim tinggi	Unit SDM/Kepegawaian	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Pengembangan Kapasitas	4.2. Pelatihan intensif untuk kesiapsiagaan bencana iklim bagi petugas medis dan manajerial	Unit Diklat/SDM	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran	4.3. Simulasi komunikasi krisis dan peringatan dini bagi seluruh staf dan pengunjung	Unit Promosi Kesehatan/ Humas	Jangka Menengah	Biaya Sedang
	WASH dan Limbah layanan kesehatan	Pemantauan dan Penilaian	4.4. Peningkatan frekuensi inspeksi IPAL dan sanitasi pada musim ekstrem	Unit Sanitasi/K3	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	4.5. Pembangunan dinding pelindung atau tanggul ringan di sekitar fasilitas sanitasi	Unit Sarpras/K3	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	4.6. Penguatan regulasi internal tentang sanitasi tanggap darurat terhadap banjir atau angin kencang	Unit K3/Mutu	Jangka Menengah	Biaya Sedang
	Energi	Pemantauan dan Penilaian	4.7. Monitoring otomatis sistem energi dan notifikasi dini gangguan pasokan listrik	Unit Teknologi/Umum/ Sarpras	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Manajemen Risiko	4.8. Pemasangan pelindung panel energi (PLTS, inverter) terhadap kerusakan akibat angin atau air	Unit Teknologi/Umum/ Sarpras	Jangka Menengah	Biaya Tinggi

(A) Strategi	(B) Komponen Intervensi	(C) Jenis / Bentuk Intervensi	(D) Rekomendasi aksi	(E) Penanggung Jawab / Pelaksana	(F) Indikatif Pelaksanaan	(G) Indikatif Pembiayaan
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	4.9. Penerapan SOP tanggap darurat untuk pemadaman listrik pada layanan intensif	Unit Teknologi/K3/Sarpras	Jangka Pendek	Biaya Rendah
	Infrastruktur	Adaptasi sistem dan infrastruktur eksisting	4.10. Reinforsement struktur bangunan rawan bocor dan rob dengan material tahan cuaca	Unit Sarpras/Perencana dan Anggaran/ Infrastrtuktur (MFK)	Jangka Menengah	Biaya Tinggi
		Promosi sistem dan teknologi baru	4.11. Penerapan teknologi peringatan dini untuk genangan dan angin kencang di area sekitar fasyankes	Unit Sarpras/Keamanan/ Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Panjang	Biaya Tinggi
		Keberlanjutan operasional Fasyankes	4.12. Integrasi mitigasi risiko iklim dalam rencana manajemen fasilitas tahunan	Tim Manajemen Fasyankes	Jangka Menengah	Biaya Sedang
Level 5 - KF sedang, RD sedang						
Memperkuat sistem di Fasyankes secara menyeluruh dan bertahap untuk menurunkan risiko	**Sumber Daya Kesehatan**	Sumber Daya Manusia	5.1. Evaluasi distribusi SDM di seluruh unit dan redistribusi sesuai kebutuhan kritis	Unit SDM/Kepegawaian	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Pengembangan Kapasitas	5.2. Pelatihan terpadu tanggap iklim untuk tim lintas fungsi (medis, teknis, manajemen)	Unit Diklat/Manajemen	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran	5.3. Penerapan sistem informasi internal tentang peringatan dini cuaca dan panduan tindakan cepat	Unit Humas/Promkes/ Teknologi	Jangka Menengah	Biaya Sedang
	WASH dan Limbah layanan kesehatan	Pemantauan dan Penilaian	5.4. Penjadwalan inspeksi berkala sanitasi dan pemantauan kualitas air real-time dengan sensor sederhana	Unit Sanitasi/Teknologi	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Manajemen Risiko	5.5. Peningkatan kapasitas IPAL dan perbaikan saluran air untuk menghadapi hujan intensitas tinggi	Unit Sarpras/K3	Jangka Menengah	Biaya Tinggi
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	5.6. Pembaruan SOP pengelolaan limbah saat gangguan operasional akibat perubahan iklim	Unit Mutu/K3	Jangka Menengah	Biaya Sedang
	Energi	Pemantauan dan Penilaian	5.7. Audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan dan kapasitas cadangan	Unit Teknologi/Umum/ Sarpras	Jangka Pendek	Biaya Rendah

(A) Strategi	(B) Komponen Intervensi	(C) Jenis / Bentuk Intervensi	(D) Rekomendasi aksi	(E) Penanggung Jawab / Pelaksana	(F) Indikatif Pelaksanaan	(G) Indikatif Pembiayaan
		Manajemen Risiko	5.8. Penguatan sistem kelistrikan ruang rawat intensif dengan sistem backup ganda	Unit Teknologi/Umum/ Sarpras	Jangka Menengah	Biaya Tinggi
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	5.9. Integrasi protokol energi darurat dalam peraturan operasional fasyankes	Unit K3/Tim Tanggap Darurat Bencana/Tim Manajemen	Jangka Menengah	Biaya Sedang
	Infrastruktur	Adaptasi sistem dan infrastruktur eksisting	5.10. Rehabilitasi atap, saluran air, dan area layanan yang rusak secara bertahap	Unit Sarpras/Umum	Jangka Menengah	Biaya Tinggi
		Promosi sistem dan teknologi baru	5.11. Penerapan pilot proyek sistem ventilasi dan penerangan alami yang tahan iklim	Unit Sarpras/Perencana dan Anggaran/ Infrastrtuktur (MFK)	Jangka Panjang	Biaya Tinggi
		Keberlanjutan operasional Fasyankes	5.12. Pengintegrasian risiko iklim dalam rencana kerja lima tahunan fasyankes	Tim Manajemen Fasyankes	Jangka Panjang	Biaya Sedang
Level 6 - KF rendah, RD rendah						
Meningkatkan kapasitas dasar sebelum risiko meningkat	**Sumber Daya Kesehatan**	Sumber Daya Manusia	6.1. Pemetaan kapasitas SDM minimum untuk operasional dasar dan prioritas pelatihan	Unit SDM/Kepegawaian	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Pengembangan Kapasitas	6.2. Pelatihan dasar manajemen risiko dan evakuasi untuk staf terbatas	Unit Diklat/SDM	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran	6.3. Pengadaan materi komunikasi risiko iklim dalam bentuk poster dan leaflet sederhana	Unit Promkes/Humas	Jangka Pendek	Biaya Rendah
	WASH dan Limbah layanan kesehatan	Pemantauan dan Penilaian	6.4. Pemeriksaan manual ketersediaan air bersih dan sistem limbah sekali seminggu	Unit Sanitasi/K3/ Kesehatan Lingkungan	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	6.5. Pemasangan bak penampung air hujan dan IPAL darurat portabel sebagai solusi awal	Unit Sarpras/Sanitasi	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	6.6. Penyusunan pedoman pengelolaan sanitasi minimal berbasis sumber daya yang ada	Unit Mutu/K3	Jangka Pendek	Biaya Rendah

(A) Strategi	(B) Komponen Intervensi	(C) Jenis / Bentuk Intervensi	(D) Rekomendasi aksi	(E) Penanggung Jawab / Pelaksana	(F) Indikatif Pelaksanaan	(G) Indikatif Pembiayaan
	Energi	Pemantauan dan Penilaian	6.7. Pencatatan manual waktu nyala listrik dan waktu padam sebagai dasar perencanaan energi darurat	Unit Teknologi/Umum/ Sarpras	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	6.8. Pengadaan genset kecil atau panel surya portabel untuk ruang prioritas	Unit Sarpras/Teknologi/ Perencana dan Anggaran	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	6.9. Penyusunan panduan teknis penggunaan sumber energi alternatif di fasyankes	Unit Teknologi/K3	Jangka Menengah	Biaya Sedang
	Infrastruktur	Adaptasi sistem dan infrastruktur eksisting	6.10. Rehabilitasi ringan fasilitas dasar seperti toilet, atap, dan ruang tunggu	Unit Sarpras/Teknologi/ Perencana dan Anggaran	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Promosi sistem dan teknologi baru	6.11. Pemasangan ventilasi alami sederhana untuk mengurangi ketergantungan listrik	Unit Sarpras/Teknologi/ Perencana dan Anggaran	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Keberlanjutan operasional Fasyankes	6.12. Penyusunan rencana penguatan fasilitas secara bertahap sesuai skala prioritas	Tim Manajemen Fasyankes/K3	Jangka Menengah	Biaya Sedang
Level 7 - KF sedang, RD tinggi						
Meningkatkan respons cepat untuk mencegah gangguan layanan saat bencana	**Sumber Daya Kesehatan**	Sumber Daya Manusia	7.1. Penempatan SDM cadangan untuk unit layanan rawan gangguan saat bencana	Unit SDM/Kepegawaian	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Pengembangan Kapasitas	7.2. Pelatihan darurat tentang evakuasi dan pengelolaan krisis untuk seluruh staf	Unit Diklat/SDM	Jangka Pendek	Biaya Sedang
		Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran	7.3. Simulasi komunikasi krisis dan peringatan dini bagi seluruh staf dan pengunjung secara rutin pada area dengan risiko tinggi	Unit Promkes/Humas/K3	Jangka Pendek	Biaya Sedang
	WASH dan Limbah layanan kesehatan	Pemantauan dan Penilaian	7.4. Pemantauan harian kualitas air bersih dan kondisi IPAL selama musim ekstrem	Unit Sanitasi/K3/ Kesehatan Lingkungan	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	7.5. Penyediaan fasilitas sanitasi darurat seperti toilet portabel dan sistem IPAL mobile	Unit Sarpras/Sanitasi	Jangka Menengah	Biaya Tinggi

(A) Strategi	(B) Komponen Intervensi	(C) Jenis / Bentuk Intervensi	(D) Rekomendasi aksi	(E) Penanggung Jawab / Pelaksana	(F) Indikatif Pelaksanaan	(G) Indikatif Pembiayaan
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	7.6. Revisi SOP limbah untuk kondisi bencana dan skenario pemulihan cepat	Unit Sanitasi / K3 / Kesehatan Lingkungan	Jangka Menengah	Biaya Sedang
	Energi	Pemantauan dan Penilaian	7.7. Inspeksi mingguan terhadap kesiapan sistem cadangan listrik dan bahan bakar	Unit Teknologi / Umum / Sarpras	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	7.8. Distribusi kit energi darurat (genset mini, UPS, solar charger) ke ruang rawan gangguan	Unit Sarpras / Teknologi / Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Menengah	Biaya Tinggi
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	7.9. Penerapan protokol pemadaman dan alur pengalihan layanan saat krisis listrik	Unit Teknologi / K3 / Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Pendek	Biaya Sedang
	Infrastruktur	Adaptasi sistem dan infrastruktur eksisting	7.10. Penguatan bangunan prioritas dengan material tahan cuaca ekstrem	Unit Sarpras / MFK (Infrastruktur)	Jangka Menengah	Biaya Tinggi
		Promosi sistem dan teknologi baru	7.11. Pemasangan sistem deteksi dini bencana lokal (banjir, longsor, gempa ringan)	Unit Sarpras / MFK (Infrastruktur) / K3	Jangka Panjang	Biaya Tinggi
		Keberlanjutan operasional Fasyankes	7.12. Rencana evakuasi dan alih fungsi ruang layanan saat terjadi gangguan ekstrem	Tim Manajemen Fasyankes / Tim Tanggap Darurat Bencana / Sarpras	Jangka Pendek	Biaya Sedang
Level 8 - KF rendah, RD sedang						
Melakukan rehabilitasi layanan dasar dan meminimalkan risiko gangguan iklim yang meningkat atau berulang	**Sumber Daya Kesehatan**	Sumber Daya Manusia	8.1. Penambahan personel relawan terlatih untuk membantu operasional dasar saat krisis	Unit SDM / Kepegawaian	Jangka Pendek	Biaya Sedang
		Pengembangan Kapasitas	8.2. Pelatihan dasar tanggap darurat untuk semua staf, termasuk petugas non-medis	Unit Diklat / SDM / Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran	8.3. Penyebaran panduan sederhana kesiapsiagaan iklim ke seluruh staf dan pasien	Unit Promkes / Humas	Jangka Pendek	Biaya Rendah

(A) Strategi	(B) Komponen Intervensi	(C) Jenis / Bentuk Intervensi	(D) Rekomendasi aksi	(E) Penanggung Jawab / Pelaksana	(F) Indikatif Pelaksanaan	(G) Indikatif Pembiayaan
	WASH dan Limbah layanan kesehatan	Pemantauan dan Penilaian	8.4. Pemeriksaan harian ketersediaan air dan pengelolaan limbah secara manual	Unit Sanitasi/K3/Sarpras/ Kesehatan Lingkungan	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	8.5. Distribusi air bersih dan toilet darurat melalui kerja sama dengan pihak luar	Unit Sarpras/Sanitasi	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	8.6. Revisi SOP operasional sanitasi untuk diterapkan pada situasi keterbatasan fasilitas	Unit Mutu/K3/Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Pendek	Biaya Rendah
	Energi	Pemantauan dan Penilaian	8.7. Pendataan mingguan pemakaian listrik dan identifikasi ruang prioritas layanan	Unit Teknologi/Sarpras/ Umum	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	8.8. Pengadaan sumber energi skala kecil berbasis komunitas (solar panel, genset mini)	Unit Teknologi/Sarpras/ Umum	Jangka Menengah	Biaya Sedang
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	8.9. Penyusunan panduan rotasi penggunaan listrik untuk menjaga layanan esensial tetap berjalan	Unit K3/Teknologi	Jangka Menengah	Biaya Sedang
	Infrastruktur	Adaptasi sistem dan infrastruktur eksisting	8.10. Perbaikan ringan fasilitas layanan inti agar dapat tetap difungsikan saat darurat	Unit Sarpras/Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Pendek	Biaya Sedang
		Promosi sistem dan teknologi baru	8.11. Pemanfaatan struktur semi permanen (tenda, kontainer) untuk perluasan layanan darurat	Unit Sarpras/Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Menengah	Biaya Tinggi
		Keberlanjutan operasional Fasyankes	8.12. Pembuatan rencana pemulihan bertahap pasca krisis yang mempertimbangkan prioritas layanan	Tim Manajemen Fasyankes/Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Menengah	Biaya Sedang
Level 9 - KF rendah, RD tinggi						
Intervensi darurat (cepat dan tepat) dengan dukungan lintas	**Sumber Daya Kesehatan**	Sumber Daya Manusia	2.1. Penugasan SDM bantuan dari fasyankes lain atau relawan dan penguatan logistik SDM darurat	Unit SDM/Manajemen Krisis	Jangka Pendek	Biaya Sedang
		Pengembangan Kapasitas	2.2. Pelatihan darurat dan pendampingan teknis dari instansi luar untuk seluruh staf	Unit Diklat/SDM/Relawan/ Manajemen Krisis	Jangka Pendek	Biaya Sedang

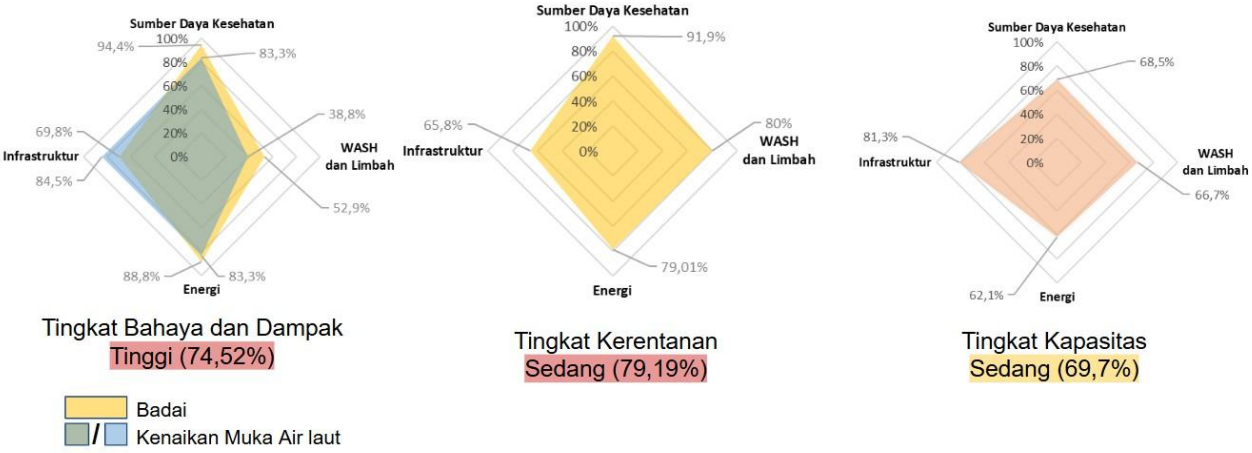
(A) Strategi	(B) Komponen Intervensi	(C) Jenis / Bentuk Intervensi	(D) Rekomendasi aksi	(E) Penanggung Jawab / Pelaksana	(F) Indikatif Pelaksanaan	(G) Indikatif Pembiayaan
sektor (vertikal dan horizontal)		Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran	2.3. Penyebaran pesan darurat lintas media informasi (pengeras suara, pesan teks, spanduk krisis)	Unit Humas/Promkes/ Manajemen Krisis	Jangka Pendek	Biaya Rendah
	WASH dan Limbah layanan kesehatan	Pemantauan dan Penilaian	2.4. Inspeksi lapangan harian dan pencatatan manual kondisi sanitasi secara visual	Unit Sanitasi/K3/ Kesehatan Lingkungan	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	2.5. Pengadaan WASH darurat seperti toilet mobile, tangki air bersih, dan desinfeksi cepat	Unit Sarpras/Sanitasi/ Kesehatan Lingkungan	Jangka Pendek	Biaya Tinggi
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	2.6. Penerapan prosedur darurat limbah untuk layanan minimal selama masa krisis	Unit K3/Mutu/Kesehatan Lingkungan/Manajemen Krisis	Jangka Pendek	Biaya Sedang
	Energi	Pemantauan dan Penilaian	2.7. Pencatatan kondisi suplai energi per 4 jam dan laporan ke tim krisis	Unit Teknologi/K3/ Manajemen Krisis	Jangka Pendek	Biaya Rendah
		Manajemen Risiko	2.8. Penyediaan cadangan energi besar-besaran melalui koordinasi lintas sektor	Unit Sarpras/Teknologi/ Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Pendek	Biaya Tinggi
		Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	2.9. Protokol rotasi layanan berbasis daya cadangan untuk menghindari penghentian layanan dasar Fasyankes	Unit K3/Manajemen Risiko/Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Pendek	Biaya Sedang
	Infrastruktur	Adaptasi sistem dan infrastruktur eksisting	2.10. Perbaikan cepat kerusakan krusial pada bangunan layanan dan jalur akses	Unit Sarpras/Umum/K3	Jangka Pendek	Biaya Tinggi
		Promosi sistem dan teknologi baru	2.11. Penggunaan shelter darurat atau relokasi layanan prioritas ke lokasi aman	Unit Sarpras/Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Pendek	Biaya Tinggi
		Keberlanjutan operasional Fasyankes	2.12. Rencana pemulihan penuh pasca-krisis dan penguatan kelembagaan lintas sektor	Tim Manajemen Fasyankes/Tim Tanggap Darurat Bencana/ Manajemen Krisis	Jangka Menengah	Biaya Sedang

3.6.3 Contoh Hasil Penilaian Fasyankes dan Rekomendasi Intervensinya

Nama Fasyankes : RSUD Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta

Gambaran Umum : RSUD Kepulauan Seribu merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan tingkat kabupaten yang melayani wilayah kepulauan di utara Jakarta. Terletak di kawasan dengan akses logistik terbatas dan tergantung pada transportasi laut. Fasyankes ini menghadapi tantangan besar saat terjadi cuaca ekstrem seperti gelombang tinggi dan badai.

Hasil Penilaian



Tingkat Bahaya dan Dampak
Tinggi (74,52%)

Tingkat Kerentanan
Sedang (79,19%)

Tingkat Kapasitas
Sedang (69,7%)

- Tingkat Bahaya dan Dampak : 74,52% (tinggi)
- Tingkat Kerentanan : 79,19% (tinggi)
- Tingkat Kapasitas : 69,7% (sedang)
- Status Akhir Fasyankes : Kapasitas sedang dengan risiko tinggi Level 7 (kluster merah)

Rekomendasi Strategi

Meningkatkan kapasitas respons cepat untuk mencegah gangguan layanan saat bencana

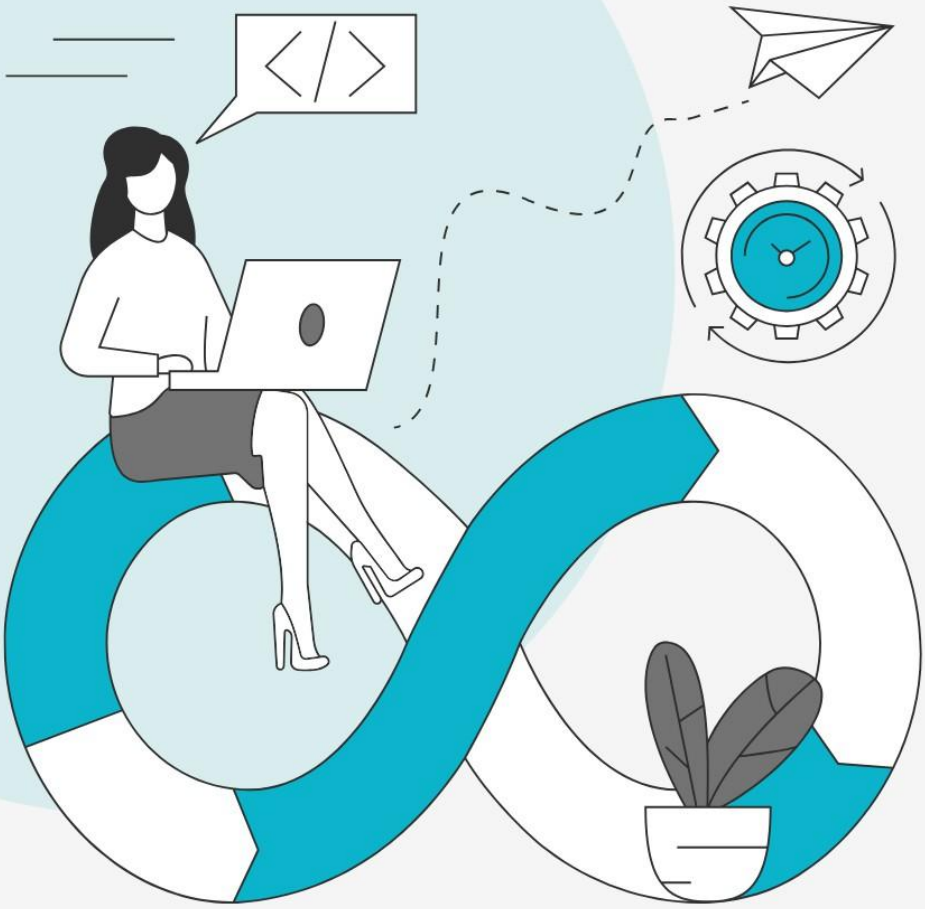
Rekomendasi Intervensi Aksi

Komponen Intervensi	Jenis / Bentuk Intervensi	Rekomendasi aksi	Penanggung Jawab / Pelaksana	Indikatif Pelaksanaan	Indikatif Pembiayaan
Sumber Daya Kesehatan	Sumber Daya Manusia	7.1. Penempatan SDM cadangan untuk unit layanan rawan gangguan saat bencana	Unit SDM/ Kepegawaian	Jangka Pendek	Biaya Rendah
	Pengembangan Kapasitas	7.2. Pelatihan darurat tentang evakuasi dan pengelolaan krisis untuk seluruh staf	Unit Diklat/SDM	Jangka Pendek	Biaya Sedang
	Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran	7.3. Simulasi komunikasi krisis dan peringatan dini bagi seluruh staf dan pengunjung secara rutin pada area dengan risiko tinggi	Unit Promkes/ Humas/K3	Jangka Pendek	Biaya Sedang

Komponen Intervensi	Jenis / Bentuk Intervensi	Rekomendasi aksi	Penanggung Jawab / Pelaksana	Indikatif Pelaksanaan	Indikatif Pembiayaan
WASH dan Limbah layanan kesehatan	Pemantauan dan Penilaian	7.4. Pemantauan harian kualitas air bersih dan kondisi IPAL selama musim ekstrem	Unit Sanitasi/K3/ Kesehatan Lingkungan	Jangka Pendek	Biaya Rendah
	Manajemen Risiko	7.5. Penyediaan fasilitas sanitasi darurat seperti toilet portabel dan sistem IPAL mobile	Unit Sarpras/ Sanitasi	Jangka Menengah	Biaya Tinggi
	Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	7.6. Revisi SOP sanitas dan limbah untuk kondisi bencana dan skenario pemulihan cepat	Unit Sanitasi/K3/ Kesehatan Lingkungan	Jangka Menengah	Biaya Sedang
Energi	Pemantauan dan Penilaian	7.7. Inspeksi mingguan terhadap kesiapan sistem cadangan listrik dan bahan bakar	Unit Teknologi/ Umum/Sarpras	Jangka Pendek	Biaya Rendah
	Manajemen Risiko	7.8. Distribusi kit energi darurat (genset mini, UPS, solar charger) ke ruang rawan gangguan	Unit Sarpras/ Teknologi/Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Menengah	Biaya Tinggi
	Peraturan Kesehatan dan Keselamatan	7.9. Penerapan protokol pemadaman dan alur pengalihan layanan saat krisis listrik	Unit Teknologi/ K3/Tim Tanggap Darurat Bencana	Jangka Pendek	Biaya Sedang
Infrastruktur	Adaptasi sistem dan infrastruktur eksisting	7.10. Penguatan bangunan prioritas dengan material tahan cuaca ekstrem	Unit Sarpras/MFK (Infrastruktur)	Jangka Menengah	Biaya Tinggi
	Promosi sistem dan teknologi baru	7.11. Pemasangan sistem deteksi dini bencana lokal (banjir, longsor, gempa ringan)	Unit Sarpras/MFK (Infrastruktur)/ K3	Jangka Panjang	Biaya Tinggi
	Keberlanjutan operasional Fasyankes	7.12. Rencana evakuasi dan alih fungsi ruang layanan saat terjadi gangguan ekstrem	Tim Manajemen Fasyankes/Tim Tanggap Darurat Bencana/Sarpras	Jangka Pendek	Biaya Sedang

Catatan Implementasi:

Daftar strategi dan intervensi aksi yang diberikan bersifat rekomendasi. Implementasi di lapangan perlu disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing fasyankes, termasuk sumber daya yang tersedia, kapasitas kelembagaan, serta prioritas daerah. Kesesuaian rekomendasi sangat bergantung pada keakuratan data dan informasi yang diisi dalam proses penilaian.



BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

> Dalam memastikan hasil penilaian ditindaklanjuti dan program berjalan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut mencakup verifikasi lapangan, pelaporan berkala, hingga pengukuran indikator penilaian. Fasyankes dalam proses implementasi didampingi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Luaran dari pengisian instrumen dapat dilakukan untuk menyusun kebijakan dan program perbaikan, sehingga Fasyankes dapat mengimplementasikan fasilitas yang berketahanan iklim dan lestari lingkungan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dalam kerangka pelaksanaan penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim dilakukan untuk memastikan proses penilaian terhadap kapasitas adaptif dan ketahanan lingkungan fasyankes dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Penilaian ini menjadi dasar untuk tidak hanya mengetahui posisi dan capaian masing-masing fasyankes, tetapi juga untuk mendorong perbaikan intervensi berbasis data, mengidentifikasi kesenjangan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang tangguh terhadap perubahan iklim. Penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim dilakukan melalui instrumen yang terintegrasi dalam aplikasi digital SIKELIM.

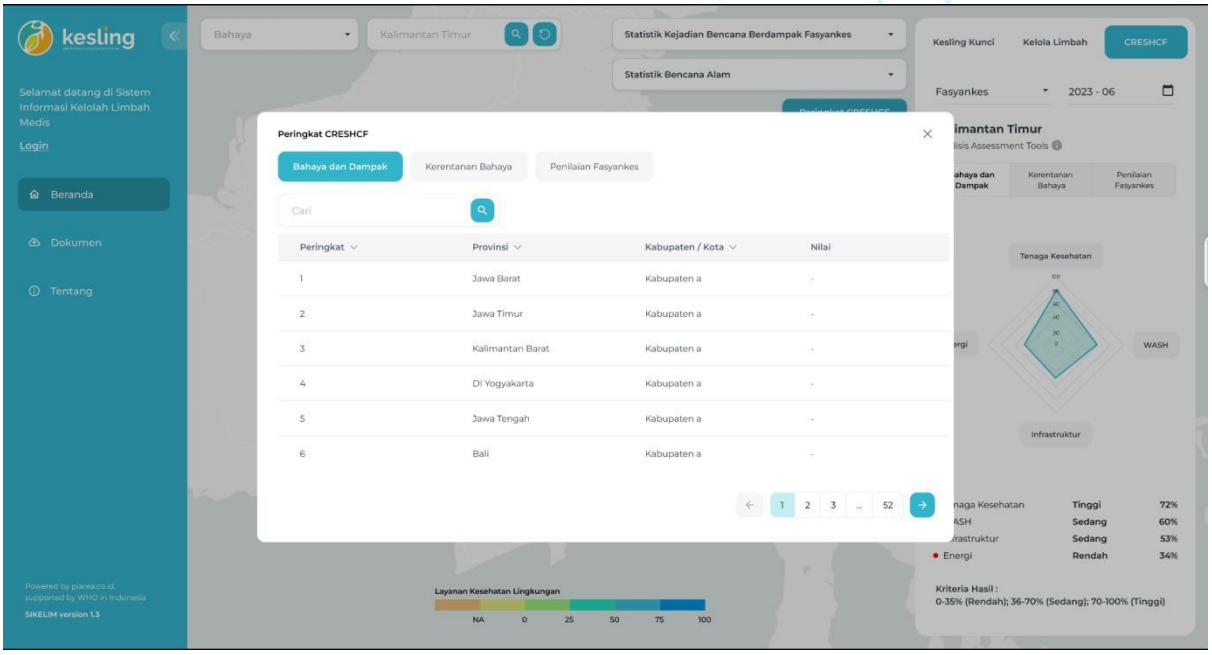
Hasil dari penilaian ini tidak hanya direkam, tetapi juga ditampilkan secara visual dalam bentuk **peringkat** di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Tampilan ini memungkinkan pemangku kepentingan di setiap tingkat untuk melakukan perbandingan capaian, mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, serta menetapkan prioritas intervensi dan dukungan teknis. Dengan sistem ini, pemantauan menjadi bagian penting dari mekanisme umpan balik untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Proses pemantauan dan evaluasi melibatkan tiga tingkatan pemerintahan utama: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan di tingkat nasional. Masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan kualitas data, kelancaran implementasi, dan efektivitas intervensi.

Panduan lebih lengkap mengenai tata cara pengisian instrumen, pemantauan dan evalusi, penilaian Fasyankes berketahanan iklim melalui aplikasi SIKELIM akan dituangkan dalam panduan teknis petunjuk pengisian yang dapat diakses pada tautan https://sikelim.kemkes.go.id/ . Petunjuk teknis tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen panduan ini.

Tabel 4.1 Tabel peran dinas kesehatan dan Kemenkes dalam pemantauan dan evaluasi Fasyankes Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan

Instansi	Deskripsi	Peran dan Tugas
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Sebagai pelaksana teknis di tingkat paling dekat dengan fasyankes, Dinas Kesehatan kabupaten/kota berperan sentral dalam operasionalisasi penilaian dan pemantauan langsung terhadap fasilitas kesehatan.	1. Pendampingan kepada Fasyankes untuk melakukan penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim sesuai instrumen 2. Memastikan Fasyankes mengisi instrumen penilaian dalam aplikasi SIKELIM 3. Melaksanakan monitoring berkala terhadap indikator perubahan dan intervensi adaptasi yang sudah dilakukan. 4. Mengolah dan menganalisis hasil penilaian sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan dan strategi adaptasi lokal. 5. Memberikan umpan balik langsung kepada fasyankes untuk perbaikan teknis, manajerial, maupun operasional, terutama pada Fasyankes yang peringkatnya rendah 6. Menyusun laporan capaian dan mengintegrasikannya ke dalam rencana program daerah.

Instansi	Deskripsi	Peran dan Tugas
		7. Memberikan dukungan pendanaan dan bimbingan teknis kepada fasyankes untuk meningkatkan kapasitas layanan.
Dinas Kesehatan Provinsi	Sebagai penghubung antara kabupaten/kota dengan pemerintah pusat, Dinas Kesehatan Provinsi bertanggung jawab memastikan konsistensi kualitas pelaksanaan dan pelaporan di wilayahnya, serta mendukung peningkatan kapasitas di daerah.	1. Mengompilasi dan memverifikasi hasil penilaian dari seluruh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. 2. Memberikan umpan balik langsung kepada fasyankes untuk perbaikan teknis, manajerial, maupun operasional, terutama pada Kabupaten/Kota yang peringkatnya rendah. 3. Melakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi tren capaian, gap wilayah, dan wilayah prioritas. 4. Mendorong sinkronisasi hasil penilaian dengan perencanaan pembangunan kesehatan provinsi. 5. Menyediakan dukungan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada daerah dengan capaian rendah. 6. Menjadi fasilitator forum koordinasi dan pembelajaran antar daerah, serta menyampaikan laporan berkala ke tingkat nasional.
Kementerian Kesehatan	Sebagai pembina teknis dan regulator utama, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa program Fasyankes berketahanan iklim berjalan sesuai kebijakan nasional serta mendukung integrasi hasilnya ke dalam strategi nasional adaptasi perubahan iklim di sektor kesehatan.	1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan nasional serta panduan teknis terkait penilaian dan intervensi Penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim. 2. Mengelola dan memutakhirkan aplikasi digital SIKELIM sebagai sistem pemantauan nasional. 3. Melakukan evaluasi nasional atas capaian provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pelaporan ke mitra lintas sektor. 4. Memberikan umpan balik kepada daerah dan Fasyankes untuk perbaikan teknis, manajerial, maupun operasional berdasarkan peringkat hasil penilaian. 5. Menyusun rekomendasi kebijakan nasional dan dukungan sumber daya berdasarkan data hasil pemantauan. 6. Mendorong integrasi data Penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim ke dalam dokumen kebijakan nasional seperti RPJMN, RENSTRA Kesehatan, dan dokumen adaptasi iklim nasional.



Gambar 4.1 Contoh tampilan peringkat Fasyankes yang sudah melakukan penilaian dan dapat digunakan lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Provinsi untuk Pemantauan dan Evaluasi



REFERENSI

REFERENSI

BAPPENAS. 2014. *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 204p.

BAPPENAS. 2021. *Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim*.

BNPB. 2024. Definisi Bencana. [https://bnpb.go.id/definisi-bencana]. Diakses pada tanggal 16 Desember 2024. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

IPCC. 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield,O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

IPCC. 2022. The 6th Assessment Report: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Chapter 7: Health, Wellbeing, and the Changing Structure of Communities.

Kemenkes. 2001. Panduan penanggulangan masalah kesehatan akibat kedaruratan kompleks: Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK).

Kemenkes. 2020. *Rencana Adaptasi Nasional Kesehatan*.

Kemenkes. 2021a. *Penelitian Berbasis Bukti Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Kesehatan di Indonesia: Data dan Informasi. Badan Penelitian dan Penembangan Kesehatan.*

Kemenkes. 2021b. *Laporan Kinerja Kegiatan Kesehatan Lingkungan Tahun 2021.*

Kemenkes. 2021c. *Data dan Informasi Dampak Perubahan Iklim Sektor Kesehatan Berbasis Bukti di Indonesia.* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Kemenkes. 2021d. Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Data Riset Kesehatan Dasar.

KLHK. 2019. *Indonesia Climate Outlooks.*

KLHK. 2020. *Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC) Adaptasi Perubahan Iklim.* Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

KLHK. 2021. *Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC) pada Aspek Adaptasi*.

KLHK. 2022. Indonesia's Adaptation Communication. Available: https://unfccc.int/sites/default/files/ACR/2022-11/221119%20Indonesia%20Adaptation%20Communication.pdf

Ministry of Health and Medical Services. 2020. Guidelines For Climate-Resilient And Environmentally Sustainable Health Care Facilities In Fiji

WHO. 2009. *Global Health Risk: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks*. WHO Library Cataloguing in Publication Data.

WHO. 2015. *Operational Framework for Building Climate Resilient Health System*. Available: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/849464/retrieve

WHO. 2019. *World Health Statistics 2019: Monitoring Health for The SDGs*. 6(1). World Health Organization.

WHO. 2020. Guidance for Climate-Resilient and Environmentally Sustainable Health-Care Facilities.

WMO. 2020. Event Types of Hazards and Extreme Events. World Meteorological Organization (WMO).

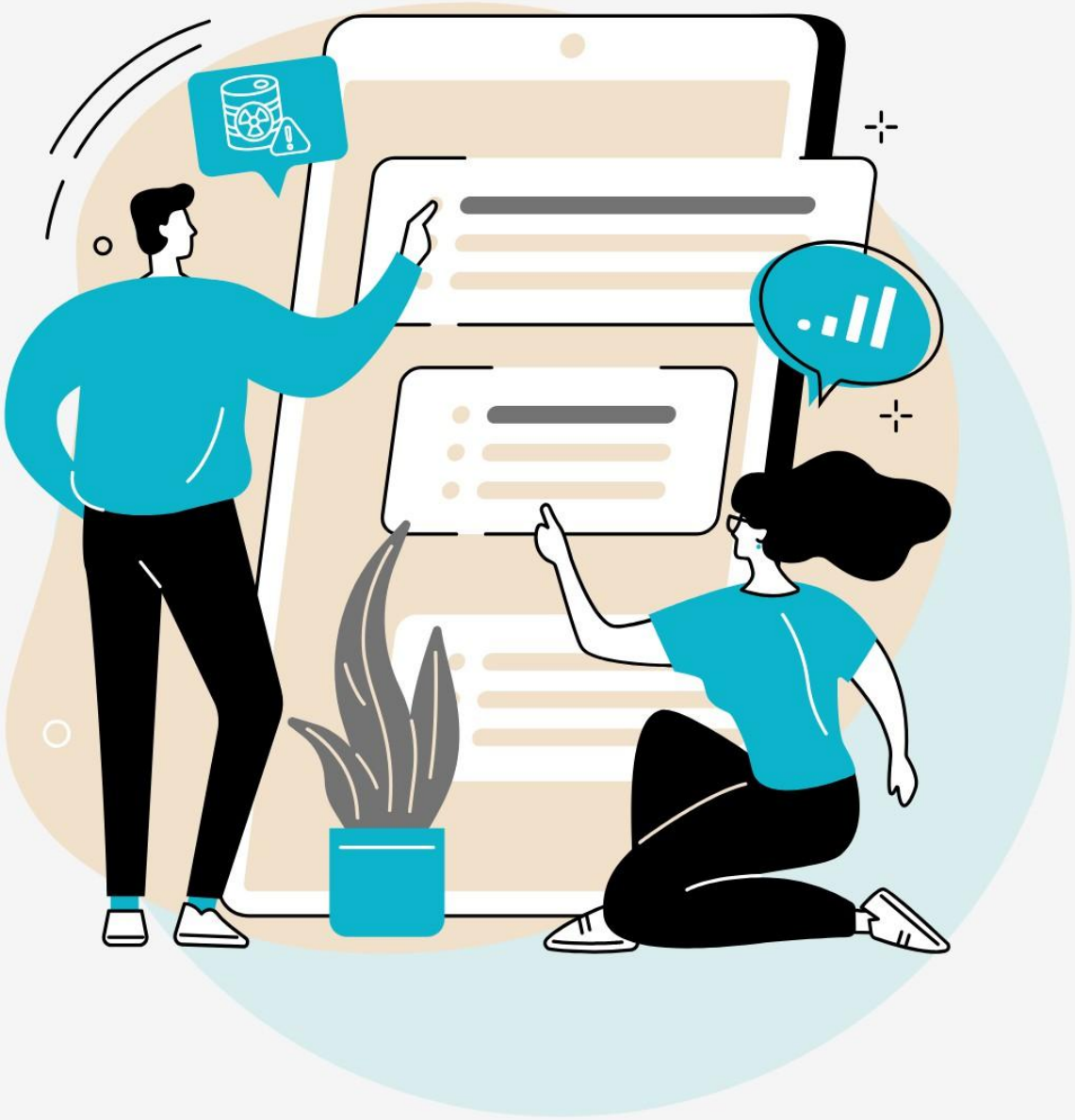
WHO. 2021. Checklist to Assess Vulnerabilities in Health Care Facilities in the Context of Climate Change

WHO. 2021. Climate change and health: vulnerability and adaptation assessment. available https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1376931/retrieve

WHO. 2022. Measuring the Climate Resilience of Health System. Available: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/354542/9789240048102-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

WHO. 2023. Development of health adaptation strategy through conducting vulnerability and adaptation assessment (VAA) and Piloting of healthy climate resilient village.

WHO. *Alliance for Transformative Action on Climate and Health: Commitments COP26 Health Programme*. Accessed February 07, 2025. https://www.who.int/initiatives/alliance-for-transformative-action-on-climate-and-health/commitments.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Skoring dan Perhitungan Nilai Instrumen Penilaian Fasyankes Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan

1. Skoring Formulir 1 - Identifikasi Kapasitas Fasyankes

Penilaian kapasitas Fasyankes dilakukan berdasarkan sejumlah indikator utama, yakni sumber daya kesehatan, WASH dan limbah layanan kesehatan, energi, serta infrastruktur, yang secara keseluruhan terdiri dari 46 elemen penilaian[5]. Elemen-elemen ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat penilaian, yaitu Tingkat 1, Tingkat 2, dan Tingkat 3, yang merepresentasikan hierarki kesiapsiagaan mulai dari skala internal hingga eksternal pelayanan kesehatan.

- Tingkat 1 mencakup aspek sistem dan prosedur internal Fasyankes, yang meliputi keberadaan protokol, kesiapan infrastruktur dasar, sistem pemulihan, serta akses terhadap sistem penunjang lainnya. Tingkat ini merefleksikan kesiapsiagaan internal dan infrastruktur dasar yang esensial bagi operasional fasyankes. Dalam sistem penilaian, Tingkat 1 diberi bobot tertinggi yaitu 3, karena perannya krusial dalam menjamin keberlangsungan pelayanan dasar saat terjadi gangguan atau bencana.
- Tingkat 2 merujuk pada kapasitas sumber daya manusia dan mekanisme koordinasi internal, termasuk pelatihan tenaga kesehatan, pembentukan tim tanggap darurat, dan penguatan jejaring koordinasi lintas unit. Tingkat ini merupakan penghubung kesiapan sistem dengan pelaksana layanan. Dalam penilaian diberikan bobot 2.
- Tingkat 3 fokus pada dukungan sarana dan pelayanan kepada masyarakat, seperti sistem transportasi dan evakuasi, kegiatan edukasi masyarakat, logistik, serta dukungan eksternal lain. Meskipun perannya penting dalam konteks respon bencana yang melibatkan masyarakat luas, tingkat ini diberi bobot 1 dalam sistem penilaian, mengingat fungsinya lebih sebagai ekstensi dari kesiapsiagaan internal fasyankes.

Tabel skoring perhitungan formulir identifikasi kapasitas Fasyankes

Kategori Pertanyaan (a)	Jumlah Pertanyaan (b)	Kriteria Jawaban (c)	Bobot (d)	Skor Akhir (x)
Tingkat 1	24	Tinggi = 3 Sedang = 2 Rendah = 1	3	$X_{t1} = b*c_t*d$ $X_{s1} = b*c_s*d$ $X_{r1} = b*c_r*d$
Tingkat 2	9	Tinggi = 3 Sedang = 2 Rendah = 1	2	$X_{t2} = b*c_t*d$ $X_{s2} = b*c_s*d$ $X_{r2} = b*c_r*d$
Tingkat 3	13	Tinggi = 3 Sedang = 2 Rendah = 1	1	$X_{t3} = b*c_t*d$ $X_{s3} = b*c_s*d$ $X_{r3} = b*c_r*d$

Setiap elemen dari ketiga tingkat tersebut dievaluasi berdasarkan kategori kesiapan aksi, yang terdiri dari tiga kriteria utama: rendah, sedang, dan tinggi. Kategori *rendah* menunjukkan bahwa aksi belum atau tidak dilaksanakan; *sedang* mengindikasikan bahwa aksi sedang dalam proses implementasi; dan *tinggi* berarti bahwa aksi telah sepenuhnya diimplementasikan. Nilai masing-masing kategori diberi skor 1 (rendah), 2 (sedang), dan 3 (tinggi). Dengan pendekatan ini, penilaian kapasitas fasyankes tidak hanya mempertimbangkan jumlah aksi yang telah dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kepentingan tiap elemen berdasarkan hirarki

5 Spesifik tingkat pada masing-masing pertanyaan dapat diakses pada link ini

kesiapsiagaan. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih proporsional dan strategis dalam merumuskan intervensi peningkatan kapasitas fasyankes, baik dalam kondisi normal maupun darurat.

Langkah perhitungan kapasitas fasyankes sebagai berikut:

a. Klasifikasikan soal berdasarkan tingkat

Misal :

- T1 : jumlah soal tingkat 1
- T2 : jumlah soal tingkat 2
- T3 : jumlah soal tingkat 3

$$T1 + T2 + T3 = 46 \sim Jumlah\ pertanyaan\ kapasitas\ fasyankes$$

b. Hitung skor aktual (S) berdasarkan kategori aksi

Skor tiap elemen :

- Rendah : 1
- Sedang : 2
- Tinggi : 3

Misal :

$S1 = \sum_{i=1}^{T1} Ai\ ; S2 = \sum_{i=1}^{T1} Ai\ ; S3 = \sum_{i=1}^{T1} Ai$

dengan A ∈ {1,2,3}

c. Hitung skor berbobot (W)

$$W1 = S1\ x\ 3$$
$$W2 = S2\ x\ 2$$
$$W3 = S3\ x\ 1$$
$$Wtotal = W1 + W2 + W3$$

d. Hitung nilai maksimum total (M)

$$M1 = T1\ x\ 3\ \text{x}\ 3$$
$$M2 = T2\ x\ 3\ x\ 2$$
$$M3 = T3\ x\ 3\ x\ 1$$
$$M\ total = M1 + M2 + M3$$

e. Rumus Skor Akhir (Persentase)

$$Skor\ Akhir\ (\%) = \left(\frac{Wtotal}{Mtotal}\right) x\ 100$$

Contoh perhitungan :

Pembagian soal : $T1 = 24;\ T2 = 9;\ T3 = 13$

$$T1 + T2 + T3 = 46$$

Skor Aktual :

- $S1 = (5\ x\ 1) + (12x2) + (7x3) = 5 + 24 + 21 = 50$
- $S2 = (2\ x\ 1) + (4x2) + (3x3) = 2 + 8 + 9 = 19$
- $S3 = (4\ x\ 1) + (5x2) + (4x3) = 4 + 10 + 12 = 26$

selanjutnya dihitung

$$W1 = S1\ x\ 3 = 50\ x\ 3 = 150$$
$$W2 = S2\ x\ 2 = 19\ x\ 2 = 38$$
$$W3 = S3\ x\ 1 = 26\ x\ 1 = 26$$
$$Wtotal = W1 + W2 + W3 = 150 + 38 + 26 = 214$$

$$M1 = T1\,x\,3\,x\,3 = 24\,x\,3\,x\,3 = 216$$
$$M2 = T2\,x\,3\,x\,2 = 9\,x\,3\,x\,2 = 54$$
$$M3 = T3\,x\,3\,x\,1 = 13\,x\,3\,x\,1 = 39$$
$$Mtotal = M1 + M2 + M3 = 216 + 54 + 39 = 39$$

$$Skor\ Akhir\ (\%) = \left(\frac{Wtotal}{Mtotal}\right) x\ 100 = \left(\frac{214}{309}\right) x\ 100 \approx 69{,}26\% \approx \textbf{Sedang}$$

Kategorisasi :

0 - 35 %	Rendah
36% - 70%	Sedang
70% - 100%	Tinggi

2. Skoring Formulir 2 - Identifikasi Bahaya dan Dampak

Penilaian dampak akibat bahaya pada fasyankes dilakukan berdasarkan sejumlah indikator utama, yakni sumber daya kesehatan, WASH dan limbah, energi, serta infrastruktur, yang secara keseluruhan terdiri dari 3 elemen penilaian (Dampak Besar, Sedang, dan Rendah). Elemen-elemen ini dibobotkan ke dalam tiga tingkat penilaian, yaitu Tingkat 1 - Dampak Besar, Tingkat 2 - Dampak Sedang, dan Tingkat 3 - Dampak Kecil, yang merepresentasikan tingkat dampak yang dirasakan fasyankes akibat bahaya perubahan iklim.

- Tingkat 1 – Dampak Besar (Bobot 3), menunjukkan kondisi ketika keempat komponen utama yaitu sumber daya kesehatan, WASH, energi, dan infrastruktur yang mengalami gangguan berat secara bersamaan atau dominan, sehingga fasyankes kehilangan sebagian besar kapasitasnya dalam memberikan layanan.
- Tingkat 2 – Dampak Sedang (Bobot 2), mencerminkan gangguan pada satu atau beberapa komponen dengan tingkat keparahan sedang, yang memengaruhi sebagian fungsi fasyankes namun masih memungkinkan layanan tetap berjalan dengan penyesuaian operasional.
- Tingkat 3 – Dampak Kecil (Bobot 1), menggambarkan gangguan ringan pada komponen yang bersifat terbatas dan tidak secara signifikan menghambat fungsi layanan fasyankes secara keseluruhan.

Tabel skoring perhitungan identifikasi bahaya dan dampak

Kategori Pertanyaan (a)	Jumlah isian terceklis (b)	Kriteria Jawaban (c)	Skor Akhir (x)
Tingkat 1	n	Besar = 3	$X_{b1} = b*c_t$
Tingkat 2	n	Sedang = 2	$X_{s2} = b*c_s$
Tingkat 3	n	Kecil = 1	$X_{k3} = b*c_r$

n = jumlah isian terceklis pada satu kategori pertanyaan (sesuai jumlah dampak yang dirasakan fasyankes.

Perhitungan penilaian dampak fasyankes sebagai berikut:

$$Tingkat\ Dampak = (JB \div TB \times 33.33\%) + (JS \div TS \times 33.33\%) + (JK \div TK \times 33.33\%)$$

Keterangan :
JB : Jumlah pertanyaan terceklis pada kategori ‘Besar’
JS : Jumlah pertanyaan terceklis pada kategori ‘Sedang’
JK : Jumlah pertanyaan terceklis pada kategori ‘Kecil’

TB : Total pertanyaan pada kategori 'Besar'
TS : Total pertanyaan pada kategori 'Sedang'
TK : Total pertanyaan pada kategori 'Kecil'

Kategorisasi :

0 - 35 %	Kecil
36% - 70%	Sedang
70% - 100%	Besar

3. Skoring Formulir 3 - Identifikasi Kerentanan

Identifikasi kerentanan fasyankes terhadap bahaya dilakukan berdasarkan empat komponen utama, yaitu sumber daya manusia, sanitasi dan pengelolaan limbah layanan fasyankes (WASH), energi, dan infrastruktur di lima bahaya akibat perubahan iklim yaitu Banjir, Badai/Angin Puting Beliung, Kenaikan Muka Laut, Kekeringan, dan Kebakaran Hutan. Setiap komponen dinilai melalui dua tingkat pertanyaan, yakni Tingkat 1 yang terdiri dari pertanyaan umum berbobot lebih besar (bobot 3) untuk menggambarkan kondisi dasar dan tingkat kerentanan umum fasyankes, serta Tingkat 2 yang mencakup pertanyaan khusus berbobot lebih kecil (bobot 2) untuk menggali aspek teknis atau rinci dari masing- masing komponen di setiap bahaya. Skema ini memungkinkan penilaian kerentanan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan baik gambaran makro maupun detail kondisi teknis pada fasyankes.

Tabel skoring perhitungan identifikasi kerentanan

Kategori Pertanyaan (a)	Jumlah Pertanyaan (b)	Kriteria Jawaban (c)	Bobot (d)	Skor Akhir (x)
Tingkat 1	51	Tinggi = 1 Sedang = 2 Rendah = 3	3	$X_{t1} = b*c_t*d$ $X_{s1} = b*c_s*d$ $X_{r1} = b*c_r*d$
Tingkat 2	68	Tinggi = 1 Sedang = 2 Rendah = 3	2	$X_{t2} = b*c_t*d$ $X_{s2} = b*c_s*d$ $X_{r2} = b*c_r*d$

Langkah perhitungan kerentanan fasyankes sebagai berikut:

a. Klasifikasikan soal berdasarkan tingkat

Misal :

- T1 : jumlah soal tingkat 1
- T2x : jumlah soal tingkat 2 pada bahaya x

$$T1 + T2x = Y \sim Jumlah\ pertanyaan\ kapasitas\ fasyankes$$

Jumlah pertanyaan kerentanan terhadap fasyankes di tiap bahaya

Bahaya (x)	Jumlah Soal Tingkat 1	Jumlah Soal Tingkat 2	Total Jumlah pertanyaan (Y)
Banjir	51	14	65
Badai/ Angin Puting Beliung		10	61
Kenaikan Muka Laut		14	65
Kekeringan		14	65
Kebakaran Hutan		16	67

b. Hitung skor aktual (S) berdasarkan kategori aksi

Skor tiap elemen :

- Rendah : 3
- Sedang : 2
- Tinggi : 1

Misal :

$S1 = \sum_{i=1}^{T1} Ai$; $S2 = \sum_{j=1}^{T2} Aj$

dengan A ∈ {1,2,3}

c. Hitung skor berbobot (W)

$$W1 = S1 \, x \, 3$$
$$W2 = S2 \, x \, 2$$
$$Wtotal = W1 + W2$$

d. Hitung nilai maksimum total (M)

$$M1 = T1 \, x \, 3 \, x \, 3$$
$$M2 = T2 \, x \, 3 \, x \, 2$$
$$Mtotal = M1 + M2$$

e. Rumus Skor Akhir (Persentase)

$$Skor\ Akhir\ (\%) = \left(\frac{Wtotal}{Mtotal}\right) x\ 100$$

Contoh perhitungan :

Pembagian soal (Banjir): $T1 = 51$; $T2banjir = 14$

$$T1 + T2 = 65$$

Skor Aktual :

- $S1 = (10 \, x \, 1) + (31x2) + (10x3) = 10 + 62 + 30 = 102$
- $S2 = (7 \, x \, 1) + (5x2) + (2x3) = 7 + 10 + 6 = 23$
-

$$W1 = S1 \, x \, 3 = 102 \, x \, 3 = 306$$
$$W2 = S2 \, x \, 2 = 23 \, x \, 2 = 46$$
$$Wtotal = W1 + W2 = 306 + 46 = 352$$

$$M1 = T1 \, x \, 3 \, x \, 3 = 51 \, x \, 3 \, x \, 3 = 459$$
$$M2 = T2 \, x \, 3 \, x \, 2 = 14 \, x \, 3 \, x \, 2 = 84$$
$$Mtotal - banjir = M1 + M2 = 459 + 84 = 543$$

$Skor\ Akhir\ (\%) = \left(\frac{Wtotal}{Mtotal}\right) x\ 100 = \left(\frac{325}{543}\right) x\ 100 \approx 59{,}85\% \approx$ **Sedang**

Kategorisasi :

0 - 35 %	Tinggi
36% - 70%	Sedang
70% - 100%	Rendah

4. Skoring Tingkat Risiko

Tingkat risiko merupakan kombinasi antara formulir identifikasi dampak dan formulir identifikasi kerentanan terhadap bahaya.

Langkah perhitungan tingkat risiko pada fasyankes sebagai berikut (*Studi kasus RSUD Kepulauan Seribu*) :

1. Kompilasi skor penilaian formulir bahaya dampak dan kerentanan

$$Skor\ penilaian\ Dampak = \frac{Nilai\ Dampak\ bahaya\ a\ +\ Nilai\ Dampak\ bahaya\ b + \dots}{Jumlah\ Bahaya}$$

$$Skor\ penilaian\ Kerentanan = \frac{Nilai\ Kerentanan\ bahaya\ a\ +\ Nilai\ Kerentanan\ bahaya\ b + \dots}{Jumlah\ Bahaya}$$

Misal, RSUD Kepulauan Seribu memiliki bahaya Banjir dan Badai/Angin Puting Beliung :

$$Skor\ penilaian\ Dampak = \frac{76{,}54\% + 72{,}51\%}{2} = 74{,}52\% \approx Tinggi$$

$$Skor\ penilaian\ Kerentanan = \frac{71{,}62\% + 63{,}73\%}{2} = 67{,}67\% \approx Sedang$$

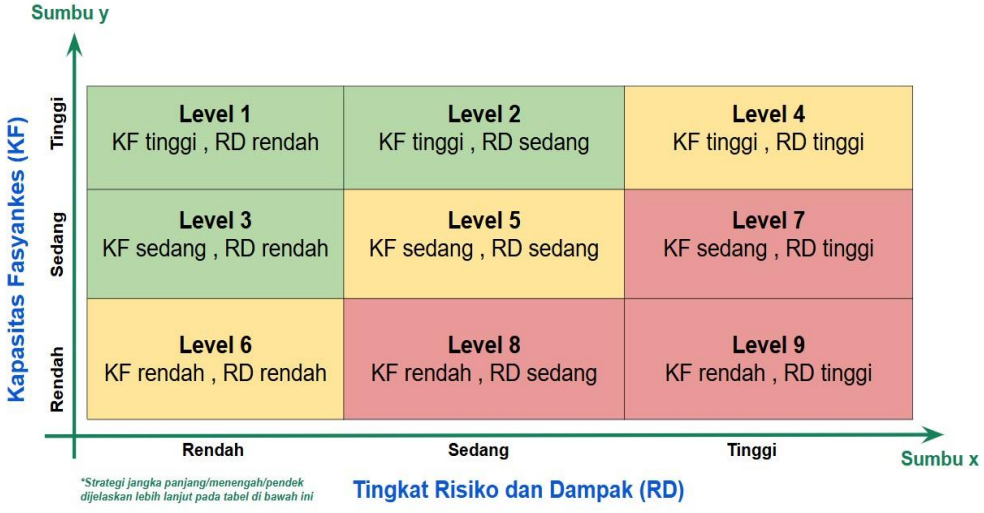
2. Perhitungan skor tingkat risiko

$$Skor\ tingkat\ risiko = \frac{Skor\ Penilaian\ Dampak + Skor\ Penilaian\ Kerentanan}{2}$$

Misal, RSUD Kepulauan Seribu :

$$Skor\ tingkat\ risiko = \frac{74{,}52\% + 67{,}67\%}{2} = 71{,}1\% \approx Tinggi$$

dengan tingkat risiko tinggi dan kapasitas sedang , maka status akhir RSUD Kepulauan Seribu berada pada matriks Level 7 (kluster merah)



Matriks status akhir Fasyankes berdasarkan hasil penilaian formulir 1, 2, dan 3

LAMPIRAN 2. Format Surat Keputusan (SK)

KOP SURAT

KEPUTUSAN PIMPINAN (Kepala Puskesmas/Rumah Sakit)
DI……..

Nomor : ……

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN PENILAIAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERKETAHANAN IKLIM DAN LESTARI LINGKUNGAN (FAS-BIK-LIN)

DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS …. DI DESA/KELURAHAN ….KECAMATAN ….
KABUPATEN/KOTA …. PROVINSI … TAHUN……

Menimbang :

1. Bahwa perubahan iklim berdampak terhadap sistem kesehatan, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan perlu dinilai ketahanannya terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungannya;
2. Bahwa untuk melaksanakan penilaian fasilitas pelayanan kesehatan berketahanan iklim dan lestari lingkungan (FAS-BIK-LIN), perlu dibentuk tim kerja pelaksana di tingkat Fasyankes;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas tentang Tim Kerja Pelaksanaan Penilaian FAS-BIK-LIN.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya;
6. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor KS.02.03/Menkes/1234/2021 tentang komitmen dan dukungan Indonesia terhadap inisiatif Kesehatan pada Perubahan Iklim
7. xx (regulasi daerah yang mungkin relevan)
8. xx (regulasi daerah yang mungkin relevan)

Memperhatikan :

1. Pedoman Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan (FAS-BIK-LIN) oleh Kementerian Kesehatan RI

2. Hasil rapat koordinasi internal Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Nama Daerah) pada tanggal (tanggal rapat)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS/RUMAH SAKIT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN PENILAIAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERKETAHANAN IKLIM DAN LESTARI LINGKUNGAN (FAS-BIK-LIN) DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS … KELURAHAN…. KECAMATAN…. KABUPATEN/KOTA…. TAHUN….**

Kesatu :

1. Membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berketahanan Iklim dan Lestari Lingkungan (FAS-BIK-LIN) Kabupaten/Kota (Nama Daerah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
2. Tim kerja bertanggung jawab atas pengisian instrumen penilaian pada aplikasi SIKELIM sesuai dengan prosedur yang berlaku; melakukan pengumpulan data pendukung terhadap penilaian instrumen penilaian FAS-BIK-LIN; menyusun laporan hasil penilaian dan rekomendasi tindak lanjut; melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota [Nama Daerah].

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ……. (Kab/Kota)

Pada Tanggal : ……. (diisi tanggal sama atau setelah rapat pembentukan tim kerja, jangan sebelum tanggal rapat)

Kepala Puskesmas/Rumah Sakit

Ttd & Stempel Basah Kepala Puskesmas/Rumah Sakit

(nama lengkap)
NIP …….

Lampiran 1 :

Keputusan Kepala Puskesmas/Rumah Sakit Nomor : ……
Tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berketahanan Iklim Dan Lestari Lingkungan (FAS-BIK-LIN) Di Rumah Sakit/Puskesmas … Kelurahan…. Kecamatan…. Kabupaten/Kota…. Tahun….

SUSUNAN DAFTAR TIM KERJA PELAKSANAAN
PENILAIAN FAS-BIK-LIN DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS … TAHUN …

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit
1	*dr.xxx*	*Ketua*	*Unit Manajemen Risiko*
2	…	*Wakil Ketua*	…
3	….	*Anggota*	…
4			
dst.			

LAMPIRAN 3. Formulir / Instrumen Penilaian FAS-BIK-LIN

1. Formulir 1 Identifikasi Kapasitas Fasyankes

Kategori Pertanyaan	Deskripsi	Skor
Pertanyaan Tingkat 1	Mencakup aspek internal penting seperti infrastruktur dasar dan sistem pemulihan.	3
Pertanyaan Tingkat 2	Menghubungkan sistem internal dengan pelayanan langsung, seperti pelatihan tenaga medis dan koordinasi	2
Pertanyaan Tingkat 3	Meliputi dukungan eksternal seperti transportasi dan edukasi masyarakat.	1

No.	Pertanyaan	Skor	Definisi Operasional[6]	Tingkat Aksi 1 (rendah) : Tidak/belum dilaksanakan 2 (sedang) : Dalam proses implementasi 3 (tinggi) : Implementasi selesai			Usulan contoh dokumen pendukung / Observasi	Unit
				Rendah	Sedang	Tinggi		
SUMBER DAYA KESEHATAN								
1	Apakah fasyankes sudah memiliki prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?	3	Prosedur K3 di fasyankes mencakup komitmen menjaga keselamatan dan kesehatan tenaga kesehatan, pasien, dan pengunjung; identifikasi bahaya; manajemen risiko dan mitigasi terhadap potensi bahaya (termasuk sarana transportasi dan evakuasi darurat, Tim Reaksi Cepat atau Tim Tanggap Darurat saat darurat iklim, program penyuluhan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, serta prosedur relokasi peralatan medis saat bencana).	☐	☐	☐	SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fasilitas Kesehatan yang mengacu pada Permenkes No. 66 Tahun 2016 tentang K3 di Fasyankes; Panduan MFK	Tim tanggap darurat bencana, Tim HDP
2	Apakah tersedia sarana transportasi dan evakuasi darurat untuk merespon keadaan darurat selama atau setelah kejadian darurat di fasyankes ?	1	Ketersediaan moda transportasi dan sistem evakuasi terorganisir selama atau setelah bencana, mencakup kendaraan layak pakai, petugas terlatih, rute evakuasi jelas, dan prosedur standar untuk evakuasi aman dan cepat bagi pasien, staf, dan pengunjung. Ketersediaan ambulans, kendaraan evakuasi, SOP, rute, dan petugas terlatih untuk evakuasi aman saat bencana.	☐	☐	☐	Dokumen rencana pengurangan risiko bencana untuk tenaga kesehatan	Manajemen Risiko Fasyankes, Sarana transportasi, MFK

[6] Kementerian Kesehatan RI. (2022). Pedoman Manajemen Risiko Keselamatan Pasien di fasyankes.

3	Apakah fasyankes memiliki program pemulihan bagi staf setelah terjadi bencana?	3	Upaya yang dilakukan oleh fasyankes untuk membantu staf memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pascabencana melalui penyediaan layanan seperti konseling psikologis gratis, tempat tinggal sementara, bantuan kesehatan, dukungan logistik atau keuangan, serta adanya kebijakan atau prosedur tertulis yang mengatur pemulihan staf. Program dianggap ada apabila fasyankes memiliki paling tidak satu dari komponen tersebut secara formal / telah dilaksanakan dalam praktik.	☐	☐	☐	Dokumen kebijakan atau SOP dukungan pemulihan bagi staf. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019	SDM K3
4	Apakah fasyankes dapat mengakses sistem peringatan dini terkait bahaya perubahan iklim yang sudah ada ?	3	kemampuan fasyankes dapat mengakses sistem peringatan dini yang tersedia secara resmi di tingkat lokal, regional, atau nasional. Sistem ini mencakup peringatan terkait bahaya perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan kenaikan muka air laut. Informasi yang diperoleh dari BMKG, BNPB atau lembaga resmi lainnya.	☐	☐	☐	SOP Merespon Sistem Peringatan DIni; Buku Pedoman Sistem Peringatan Dini Bencana Alam; sesuai dengan Pedoman BNPB tentang Sistem Peringatan Dini dalam Pengurangan Risiko Bencana	Tanggap Darurat Bencana - pencegahan Tim siaga bencana Manajemen data dan informasi
5	Apakah fasyankes memiliki program edukasi / penyuluhan untuk masyarakat/pasien tentang penyakit yang dipengaruhi perubahan iklim ?	1	Fasyankes melakukan edukasi tentang penyakit seperti DBD, diare, dan ISPA akibat perubahan iklim.	☐	☐	☐	Program Edukasi Pencegahan Penyakit Akibat Perubahan Iklim di Puskesmas; mengacu pada Pedoman Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Sanitarian Hukmas & PPI Promkes
6	Apakah fasyankes telah melaksanakan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang mencakup manajemen risiko bencana terkait iklim, termasuk pencegahan dan pengendalian infeksi saat bencana iklim, serta mengembangkan rencana pengamanan kualitas air dan sanitasi yang tahan terhadap bencana iklim?	3	Pelatihan mencakup penanganan bencana iklim yang mencakup manajemen risiko	☐	☐	☐	Mengacu pada kurikulum pelatihan pengelolaan kesehatan lingkungan pada situasi bencana kemenkes	Tanggap Darurat Bencana - pencegahan IPS&S manajemen dan kesling
7	Apakah tersedia media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di fasyankes untuk tenaga kesehatan, pasien, pengunjung, dan masyarakat terkait risiko	3	Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di fasyankes merujuk pada berbagai media (pamflet, sosial media, dan Whatsapp) yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai risiko kesehatan yang disebabkan oleh perubahan iklim kepada tenaga kesehatan, pasien, pengunjung, dan masyarakat.	☐	☐	☐	Kampanye edukasi, leaflet, media sosial, laporan kegiatan; contoh edukasi : https://unair.ac.id/infografik-dampak-perubahan-iklim-bagi-kesehatan/	Humas, promkes

	kesehatan akibat perubahan iklim?							
8	Apakah tenaga kesehatan dilibatkan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat pada program Desa/Kelurahan Sehat Iklim (untuk Puskesmas), atau dalam program terkait pengunjung di Rumah Sakit?	2	Rencana Kerja Masyarakat disusun oleh masyarakat untuk pembangunan kesehatan berbasis adaptasi iklim. Tenaga kesehatan wajib terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Dokumen harus mencakup masalah kesehatan, kegiatan, sumber daya, dan strategi.	☐	☐	☐	Surat tugas, dan bukti keterlibatan dalam keanggotaan komite,	Humas, promkes
9	Apakah fasyankes secara rutin meningkatkan kualitas SDM terkait penanganan bencana?	2	Fasyankes rutin (6 bulan sekali atau sekali setahun) melakukan pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Pelatihan mencakup simulasi, penanganan korban, dan prosedur darurat. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan seluruh staf menghadapi bencana.	☐	☐	☐	SOP manajemen air, laporan audit konsumsi air, SOP Pengadaan dan Distribusi Peralatan Pengolahan Air Darurat; Pedoman RS aman bencana, dan mengacu pada Permenkes 2/23	Sanitarian IPSRS Bangunan Tim siaga bencana MFK (tanggap darurat bencana)
10	Apakah tenaga kesehatan mendapatkan KIE atau pelatihan terkait produk dan pengadaan ramah lingkungan (green procurement) di fasyankes ?	2	Pelatihan ini memberi pengetahuan tentang produk ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya. Contoh : Pembelian produk dengan label ramah lingkungan (eco-label), produk hemat energi seperti lampu LED dan AC berstandar efisiensi energi.	☐	☐	☐	Program Pelatihan Lingkungan Hidup dan Pengadaan yang Berkelanjutan di Fasyankes, sesuai dengan Pedoman Kemenkes tentang Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan dan *Green Hospital*	IPSRS, Kesling
11	Apakah tenaga kesehatan mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan Limbah B3 dan limbah medis ?	3	Pelatihan tentang pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan limbah medis meningkatkan pemahaman dan keterampilan penanganan limbah berbahaya sesuai standar. Fasyankes rutin melakukan sesi pelatihan kepada tenaga kesehatan. Materi mencakup prosedur keselamatan dan kebijakan terkait, serta Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.	☐	☐	☐	SOP manajemen limbah medis dan bahan kimia, mengacu pada Permenkes No. 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Fasyankes dan Kemenkes	Sanitarian Instalasi K3 Sanitasi Sanitasi-IPS&S kesling
WASH dan Limbah layanan kesehatan								
12	Apakah fasyankes telah melaksanakan pengawasan secara berkala menggunakan formulir Kesling Kunci dan Kesling Plus, pada SIKELIM ?	3	Pengawasan berkala dilakukan menggunakan formulir Kesling Kunci dan Kesling Plus. Tujuan pengawasan adalah memastikan standar kesehatan lingkungan fasyankes terpenuhi. Pengisian formulir wajib dilakukan secara rutin oleh petugas terkait. Kesling kunci dan Kesling Plus tersedia di sistem SIKELIM.	☐	☐	☐	SOP pemantauan; hasil audit kepatuhan; Sistem Pemantauan Kepatuhan terhadap Standar Nasional Fasilitas Air dan Sanitasi di Fasyankes, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan	Sanitasi-IPS&S kesling

							Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air	
13	Apakah fasyankes sudah mengembangkan rencana konservasi air ?	1	Rencana konservasi air di fasyankes merujuk pada upaya sistematis dan terencana untuk mengurangi konsumsi air dan meningkatkan efisiensi penggunaannya melalui berbagai metode. Metode mencakup biopori, pemanenan air hujan, dan pengelolaan limbah cair.	☐	☐	☐	SOP efisiensi air; Program Penghematan dan Pengelolaan Penggunaan Air secara Efisien di Fasyankes, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Air di Rumah Sakit	Sanitasi-IPS&S
14	Apakah fasyankes sudah menerapkan dokumen rencana penanggulangan bencana terkait iklim yang mencakup aspek WASH ?	1	Dokumen ini memuat rencana tanggap darurat terkait perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Fasyankes mengintegrasikan aspek WASH (air, sanitasi, dan kebersihan) dalam rencana. Tujuan dokumen adalah menjamin ketersediaan layanan selama bencana.	☐	☐	☐	Dokumen rencana risiko WASH berbasis iklim, laporan pelaksanaan; Dokumen pelatihan fasilitator STBM pada situasi Bencana	Manajemen Risiko Fasyankes Instalasi K3 Sanitasi Sanitasi-IPS&S kesling
15	Apakah fasyankes mengelola limbah medis dengan aman selama keadaan darurat/bencana?	1	Fasyankes memiliki kebijakan jelas pengelolaan limbah medis dalam situasi darurat. Ketersediaan APD, pelatihan, dan prosedur darurat wajib dipastikan. Hal ini untuk mencegah infeksi dan polusi lingkungan saat bencana.	☐	☐	☐	SOP manajemen limbah darurat, https://bapelkesjabar.diklat.id/wp-content/uploads/2019/09/MI.2-Pengelolaan-Limbah-Medis-dalam-Situasi-Darurat-FIX.pdf	Sanitarian Sanitasi-IPS&S
16	Apakah fasyankes sudah melakukan surveilans penyakit yang diakibatkan oleh kualitas air dan sanitasi yang buruk ?	3	Fasyankes memantau dan melaporkan penyakit akibat kondisi air dan sanitasi buruk. Pemantauan dilakukan periodik oleh petugas surveilans. Data digunakan untuk tindakan lanjut oleh instansi kesehatan terkait.	☐	☐	☐	Sistem surveilans penyakit berbasis air, laporan kasus penyakit mengacu pada pedoman SKDR Penyakit KLB	Tim rekam medis PPI & Sanitasi Epid
17	Apakah fasyankes telah melakukan pelatihan terkait pengurangan limbah (3R)?	3	Pelatihan bertujuan meningkatkan keterampilan staf dalam reduce, reuse, dan recycle limbah. Kegiatan mencakup materi pengurangan limbah medis dan daur ulang. Penilaian dilihat dari frekuensi, partisipasi, dan materi yang diajarkan.	☐	☐	☐	Modul pelatihan; Program Pengurangan Limbah dan Pelatihan Pengelolaan Limbah di Fasyankes untuk Semua Staf, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Limbah dari Kemenkes	Sanitarian
18	Apakah fasyankes telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik ?	1	Fasyankes menerapkan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan bahan ramah lingkungan. Edukasi kepada staf dan pasien wajib dilakukan. Implementasi diukur dari kebijakan, aktivitas, dan hasil yang tercapai.	☐	☐	☐	Program Pengurangan Penggunaan Air Kemasan Plastik dan Penyediaan Dispenser Air di Fasyankes	kesling
19	Apakah fasyankes dapat mengakses sistem peringatan dini (Early Warning Sistem) terkait infeksi atau penyakit akibat iklim ?	3	Fasyankes dapat mengakses peringatan dini terkait infeksi atau penyakit akibat iklim yang dapat bersumber dari lembaga resmi, Kementerian Kesehatan dan BMKG	☐	☐	☐	Sistem Pemantauan dan Pelaporan Penyakit Akibat Perubahan Iklim sesuai dengan Sistem Surveilans KLB dan dan SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini	PPI Epid

							dan Respon) dari Kemenkes; Mengacu pada permenkes NOMOR 949/MENKES/SK/VIII/2004	
ENERGI								
20	apakah fasyankes telah menilai kebutuhan energi alternatif atau terbarukan dalam keadaan normal ataupun darurat?	1	Fasyankes menilai kebutuhan energi alternatif seperti surya, angin, atau biomassa. Penilaian mencakup identifikasi sumber energi cadangan untuk kondisi darurat. Contoh Kebutuhan Energi Alternatif atau Terbarukan: Dalam kondisi normal, Fasyankes menggunakan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari, mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik utama. Dalam keadaan darurat, seperti ketika terjadi pemadaman listrik akibat bencana alam, fasyankes dapat menggunakan generator tenaga angin atau panel surya portabel untuk memastikan kontinuitas layanan medis yang vital, seperti penerangan ruang pelayanan atau alat medis yang membutuhkan listrik.	☐	☐	☐	Pemetaan Potensi Energi Terbarukan di Indonesia untuk Perencanaan Transisi Energi yang Lebih Tepat (IESR)	IPS
21	Apakah generator cadangan (misalnya genset) diperiksa secara rutin meskipun jarang digunakan?	2	Fasyankes rutin memeriksa kondisi fisik dan fungsi genset. Pelayanan meliputi pengujian, penggantian suku cadang, dan perawatan mekanik.	☐	☐	☐	Catatan pemeliharaan genset di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit	IPS
22	Apakah fasyankes sudah menggunakan energi terbarukan (seperti tenaga surya) untuk sebagian fasilitas?	1	Fasyankes perlu mengadopsi energi terbarukan di sebagian fasilitas, seperti panel surya, energi angin (turbin kecil untuk wilayah yang berangin), biomassa (mengolah limbah organik menjadi energi listrik) dan mikrohidro (untuk wilayah dengan aliran air yang memadai). Evaluasi kendala implementasi SDM, sarpras, dan anggaran wajib dilakukan.	☐	☐	☐	Dokumen rencana manajemen energi	Manajemen Fasilitas dan Instruktur IPS&S kesling MFK, sarpras
23	Apakah fasyankes telah menilai cadangan energi (misalnya genset) agar dapat bertahan dalam keadaan darurat seperti cuaca ekstrem ?	3	Fasyankes menilai kapasitas dan keandalan sumber energi cadangan seperti genset, UPS, atau panel surya. Evaluasi mencakup kapasitas daya, durasi operasi, dan kesiapan saat darurat. Tujuannya menjaga operasional layanan penting selama bencana.	☐	☐	☐	Dokumen rencana manajemen energi	Manajemen Fasilitas dan Instruktur IPS&S kesling MFK, sarpras

24	Apakah fasyankes sudah memiliki mekanisme rencana untuk mengelola pasokan energi (jika terjadi pemadaman listrik atau kegagalan sistem) ?	3	Fasyankes memiliki dokumen kebijakan atau prosedur tertulis antisipasi gangguan energi. Dokumen ini mencakup sistem cadangan seperti genset, panel surya, dan UPS. Penilaian dilakukan berdasar ketersediaan, implementasi, dan keberfungsian sistem.	☐	☐	☐	Dokumen rencana manajemen energi, laporan simulasi skenario kegagalan	IPS&S MFK, sarpras
25	Apakah fasyankes memiliki sistem penyaring udara untuk menjaga kualitas udara ?	3	Fasyankes memiliki sistem penyaring udara seperti HEPA filter atau UV purifier. Alat ini digunakan di ruang kritis seperti ICU dan ruang operasi.	☐	☐	☐	Pedoman pengendalian pencemaran udara dalam ruang mengacu Permenkes No. 1077 / 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah	IPS&S
26	Apakah sistem energi di fasyankes mencukupi kebutuhan saat keadaan darurat (seperti penggunaan AC saat cuaca ekstrem) ?	2	Fasyankes menjamin kecukupan energi listrik minimal 24 jam saat bencana. Energi ini dibutuhkan untuk AC, alat medis, pencahayaan, dan komunikasi. Penilaian mencakup ketersediaan dan kapasitas energi utama dan cadangan.	☐	☐	☐	Laporan ketahanan sistem selama simulasi atau peristiwa cuaca ekstrem	IPS kesling
27	apakah fasyankes memiliki alat penstabil tegangan (stabilizer atau UPS) untuk melindungi peralatan dari gangguan listrik?	3	Fasyankes memasang stabilizer atau UPS untuk melindungi peralatan dari gangguan listrik. Alat proteksi ini wajib aktif di ruang layanan utama seperti IGD dan ICU. Tujuannya mencegah kerusakan alat akibat lonjakan atau pemadaman listrik.	☐	☐	☐	Laporan ketahanan sistem selama simulasi atau peristiwa cuaca ekstrem	IPS&S
28	Apakah fasyankes memiliki sumber energi cadangan yang memadai jika sumber energi utama tidak dapat digunakan ?	3	Fasyankes memiliki genset, panel surya, atau sumber energi cadangan lain yang dapat menopang layanan kritis minimal 24 jam. Sumber cadangan wajib rutin diuji dan dalam kondisi baik. Ketersediaan bahan bakar atau sistem pendukung juga wajib terjamin.	☐	☐	☐	Dokumen rencana manajemen energi	Manajemen Fasilitas dan Instruktur IPS&S
29	Apakah tenaga kesehatan sudah mendapatkan pelatihan atau peningkatan kapasitas terkait penggunaan energi di fasyankes, termasuk cara menghitung emisi gas rumah kaca?	1	Tenaga kesehatan mengikuti pelatihan terkait akses energi andal, efisiensi, dan perhitungan emisi GRK. Pelatihan dapat berupa workshop, seminar, atau bimbingan teknis dalam 2 tahun terakhir. Bukti pelatihan berupa sertifikat atau laporan kegiatan.	☐	☐	☐	Bahan / Materi pembelajaran / Bukti dokumentasi mengikuti pelatihan	IPS&S
30	Apakah fasyankes memprioritaskan penggunaan energi hemat seperti lampu LED, cahaya alami, AC hemat energi, dan sebagainya?	2	Fasyankes menerapkan teknologi hemat energi seperti lampu LED, AC efisien, dan desain pencahayaan alami. Implementasi dilihat dari bukti kebijakan, perencanaan, dan aktivitas nyata. Tujuan utama adalah mengurangi konsumsi energi.	☐	☐	☐	Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional	IPS

31	Apakah fasyankes sudah mengembangkan sistem konservasi energi dengan intensif (seperti pengoptimalan penggunaan lampu hemat energi, mematikan saklar lampu saat tidak digunakan, atau mencabut kabel listrik yang tidak digunakan)?	2	Fasyankes memiliki kebijakan, prosedur, dan praktik teknis yang diterapkan secara rutin dan terstruktur oleh fasyankes untuk mengurangi konsumsi energi secara efisien. Ini mencakup upaya seperti penggunaan lampu hemat energi (misalnya LED), penerapan kebiasaan operasional seperti mematikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan, mencabut kabel listrik yang tidak aktif, serta adanya sistem monitoring atau panduan internal terkait efisiensi energi. Penilaian dilakukan berdasarkan keberadaan kebijakan, frekuensi pelaksanaan, keterlibatan staf, serta bukti dokumentasi atau implementasi nyata di lingkungan fasyankes.	☐	☐	☐	Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)	IPS
Infrastruktur									
32	Apakah fasyankes menjalin kemitraan antara masyarakat, dan pemerintah daerah untuk mengurangi kerentanan iklim di masyarakat sekitar* ?	3	Fasyankes menjalin kerja sama atau kemitraan formal maupun informal dengan masyarakat setempat dan otoritas lokal (seperti pemerintah desa, kelurahan, atau kecamatan) dalam upaya mengurangi kerentanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, seperti bencana iklim, penyakit terkait iklim, dan kekurangan air bersih. Kegiatan bisa berupa penyuluhan, pelatihan tanggap darurat, atau program adaptasi. Fasyankes di DTPK juga harus bermitra dengan masyarakat adat.	☐	☐	☐	Pedoman Pelaksanaan Rumah Sakit Hijau" (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.03/MENKES/23/2018)	Humas, Promkes
33	Apakah fasyankes secara berkala memeriksa kondisi bangunan untuk mendeteksi kerusakan struktural ?	3	Fasyankes memeriksa kondisi struktur bangunan minimal sekali setahun. Pemeriksaan meliputi fondasi, dinding, atap, dan elemen struktural lainnya. Tujuannya mendeteksi kerusakan yang bisa membahayakan keselamatan layanan.	☐	☐	☐	Laporan hasil inspeksi bangunan	IPS & SRS K3L
34	Apakah fasyankes melakukan penilaian bahaya iklim untuk pembangunan fasilitas baru ?	3	Fasyankes menilai potensi bahaya iklim seperti banjir/kekeringan pada fasilitas baru (misalnya bangunan baru, fasilitas pelayanan, maupun sarpras baru). Penilaian menggunakan data ilmiah dan teknologi terbaru terkait bahaya iklim (contohnya menyesuaikan desain pondasi bangunan agar lebih tinggi dari elevasi banjir tertinggi yang pernah tercatat.	☐	☐	☐	Pedoman Pelaksanaan Rumah Sakit Hijau" (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.03/MENKES/23/2018)	Sanitarian manajemen fasilitas kesehatan (tangggap darurat bencana)
35	Apakah fasyankes sudah mengalokasikan sumber daya untuk mitigasi dan pencegahan dampak perubahan iklim ?	3	Fasyankes harus menyiapkan anggaran, SDM, fasilitas, dan teknologi untuk mitigasi risiko iklim. Alokasi dana digunakan untuk infrastruktur tahan	☐	☐	☐	Dokumen anggaran dan alokasi sumber daya	Manajemen Fasilitas dan Instruktur PEA

			iklim dan pelatihan staf. Penilaian didasarkan pada dokumen kebijakan dan program yang ada.					manajemen keuangan
36	Apakah fasyankes memiliki rencana pendanaan untuk perbaikan atau peningkatan fasilitas baru (pemeliharaan atau pengembangan sarana prasana yang baru) ?	3	penilaian apakah fasyankes telah memiliki perencanaan yang jelas terkait sumber pendanaan untuk kegiatan perbaikan atau peningkatan fasilitas, termasuk alokasi dana untuk renovasi atau pembangunan baru. Sumber pendanaan yang dimaksud meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non-Fisik, Dana Alokasi Umum, serta Otonomi Khusus (Otsus) yang berlaku di wilayah Papua, Papua Barat, dan Aceh. Perencanaan ini mencakup identifikasi dan pengalokasian sumber dana tersebut, yang digunakan untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas fasilitas kesehatan yang lebih baik.	☐	☐	☐	renstra Rumah Sakit/ Puskesmas periode 2021–2025	PEA Anggaran
37	Apakah bangunan fasyankes dirancang tahan terhadap berbagai risiko perubahan iklim termasuk bencana?	2	penilaian desain bangunan fasyankes yang mencakup struktur, material, dan sistem bangunan yang telah disesuaikan untuk menghadapi potensi perubahan iklim dan bencana alam (seperti banjir, gempa, atau angin kencang).	☐	☐	☐	Dokumen desain bangunan sesuai penilaian risiko lokal	Manajemen Risiko Fasyankes IPS & SRS mutu (manajemen risiko)
38	Apakah bangunan fasyankes menggunakan pendingin ruangan yang cukup/memadai?	1	Fasyankes memastikan ventilasi dan pendingin ruangan memadai menghadapi suhu ekstrem. Sistem harus menjaga suhu dan kualitas udara di ruang perawatan dan administrasi. Penilaian berdasar standar keselamatan dan kesehatan kerja.	☐	☐	☐	Pedoman Adaptasi Bangunan Kesehatan terhadap Perubahan Iklim oleh K.PUPR dan Kemenkes	Manajemen Fasilitas dan Instruktur IPS & SRS kesling
39	Apakah fasyankes memiliki alat komunikasi utama dan cadangan, serta daftar kontak darurat yang diperbarui secara berkala?	3	Fasyankes wajib memiliki alat komunikasi utama (telepon/email/radio) dan cadangan. Daftar kontak darurat harus selalu diperbarui dan valid.	☐	☐	☐	Pedoman Sistem Komunikasi Darurat di Fasilitas Kesehatan oleh BNPB dan Kemenkes	K3 Tim Siaga Bencana & HUKMAS promkes
40	Apakah fasyankes memanfaatkan informasi potensi bahaya di wilayahnya menggunakan Inarisk/Kajian Risiko Bencana?	3	Fasyankes harus rutin menggunakan informasi potensi bahaya dari Inarisk atau kajian risiko bencana. Data digunakan dalam perencanaan kesiapsiagaan dan pengadaan sumber daya. Penilaian berdasar integrasi data dalam rencana dan pelaksanaan.	☐	☐	☐	Laporan Risiko Bencana Daerah (BPBD), Dokumen Kajian Risiko Iklim (KLHK)	Manajemen Risiko Fasyankes Tim Siaga Bencana & HUKMAS mutu (manajemen risiko)
41	Apakah fasyankes memiliki kapasitas ruang gawat darurat yang memadai untuk menangani kondisi darurat akibat bencana terkait iklim?	3	Fasyankes wajib memiliki RGD yang mampu menangani kondisi darurat akibat bencana iklim. Ruang harus dilengkapi alat medis, SDM terlatih, dan SOP darurat. Penilaian berdasarkan fasilitas, SDM, dan kesiapan prosedur.	☐	☐	☐	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (Kemenkes), Data Kapasitas IGD Rumah Sakit	Manajemen Fasilitas dan Instruktur Pelayanan Medik manajemen fasilitas kesehatan

								(tangggap darurat bencana)
42	Apakah fasyankes telah mengidentifikasi sumber air alternatif untuk tetap dapat beroperasi saat darurat (seperti sumur dalam, perusahaan air minum setempat, tangki/tandon air tidak permanen/bisa dipindahkan)? *	3	Fasyankes harus memiliki rencana sumber air alternatif seperti sumur dalam atau tangki air darurat. Infrastruktur dan sistem pendukung harus siap saat sumber utama terganggu. Tujuannya menjamin ketersediaan air selama bencana.	☐	☐	☐	Kajian Sumber Air Alternatif RS, Perjanjian dengan Perusahaan Air Minum	Manajemen Fasilitas dan Instruktur IPS & SRS kesling
43	Apakah gas dan bahan medis kimia di fasyankes disimpan di tempat yang aman dan memiliki ventilasi yang memadai?	1	Penyimpanan gas dan bahan medis kimia dianggap aman jika berada di area terlindung dari kebakaran, paparan bahan berbahaya, dan kerusakan fisik, dilengkapi ventilasi memadai, tanda peringatan, serta prosedur darurat yang jelas.	☐	☐	☐	SOP Penyimpanan Gas Medis dan Bahan Kimia, Audit Keselamatan K3 Rumah Sakit, Dokumen Inspeksi dari Dinas Kesehatan	Manajemen Fasilitas dan Instruktur IPS & SRS , K3 & PPI kesling
44	apakah fasyankes memiliki filter polusi udara untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan?	1	Fasyankes wajib memasang alat penyaring polusi udara seperti HEPA filter di ruang perawatan. Alat harus mengurangi debu, asap, dan mikroorganisme berbahaya. Penilaian berdasar pemasangan, fungsi, dan efektivitas alat.	☐	☐	☐	Dokumen Spesifikasi Teknis Instalasi HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), Laporan Pemeliharaan Sistem Penyaringan Udara, Laporan Audit Kualitas Udara; surat edaran rumah sakit atau surat edaran puskesmas	Manajemen Fasilitas dan Instruktur IPS & SRS MFK
45	Apakah fasyankes terdapat kebijakan yang mendorong staf untuk menggunakan moda transportasi ramah lingkungan ?	1	Fasyankes harus memiliki kebijakan mendorong penggunaan sepeda, kendaraan listrik, atau angkutan umum. Kebijakan dapat mencakup insentif atau fasilitas pendukung. Tujuannya mengurangi dampak lingkungan dari perjalanan dinas.	☐	☐	☐	Surat Edaran fasyankes tentang Penggunaan Transportasi Publik dan Carpooling bagi Tenaga Medis	SDM IPS&S manajemen
46	Apakah di fasyankes menerapkan proses pengadaan sesuai dengan prasyarat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sesuai dengan prasyarat di E-Catalogue?	2	Fasyankes wajib memastikan barang/jasa yang dibeli memenuhi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sesuai E-Catalogue. Proses meliputi pengecekan dan validasi nilai TKDN sebelum pengadaan. Tujuannya mendukung produk dalam negeri sesuai regulasi pemerintah.	☐	☐	☐	Laporan Pengadaan Barang/Jasa dari UMKM lokal oleh rumah sakit/puskesmas	Manajemen Fasilitas dan Instruktur Pelayanan Penunjang & ULP Manajemen keuangan

2. Formulir 2 Identifikasi Bahaya dan Dampaknya

Formulir - 2a Identifikasi Bahaya

Ada / Tidak ada	Jenis Bahaya	Definisi Operasional	Kapan terjadi? Apakah terjadi secara rutin? Jelaskan singkat
•	Banjir	Peristiwa ketika air menenggelamkan atau mengenangi suatu daratan karena volume air yang meningkat (BNPB)	
•	Badai / Puting Beliung	Gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam (BNPB) seperti angin yang sangat kencang	
•	Kenaikan Muka Air Laut	Peningkatan ketinggian permukaan laut relatif terhadap daratan di lokasi tertentu (WHO)	
•	Kekeringan	Ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (BNPB)	
•	Kebakaran Hutan	Suatu keadaan dimana hutan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan (BNPB)	
•	Tidak ada bahaya		

Apakah Fasyankes,												
Tenaga Kesehatan				WASH dan limbah pelayanan kesehatan				Layanan energi				Infrastruktur, teknologi, produk, dan proses			
Dampak		Potensi Dampak		Dampak		Potensi Dampak		Dampak		Potensi Dampak		Dampak		Potensi Dampak	
A. Banjir															
	Kesulitan akses ke fasilitas kesehatan karena jalanan tergenang atau terputus		Potensi penurunan ketersediaan tenaga kerja akibat tenaga kesehatan tidak dapat mencapai fasilitas.		Pencemaran sumber air bersih karena air banjir mencampur limbah medis dan air limbah.		Risiko penyebaran penyakit menular seperti diare dan kolera karena air terkontaminasi.		Kerusakan infrastruktur listrik seperti trafo dan jaringan distribusi yang terendam air.		Risiko gangguan pasokan energi jangka panjang akibat kerusakan fasilitas energi utama.		Kerusakan infrastruktur fisik seperti bangunan, sistem kelistrikan, dan sistem pendinginan yang terendam air.		Potensi risiko kerusakan permanen pada peralatan medis yang menyebabkan biaya perbaikan atau penggantian yang tinggi.
	Peningkatan kelelahan fisik dan mental akibat lonjakan pasien dengan kondisi darurat.		Potensi stres emosional jangka panjang karena menangani korban banjir dalam situasi darurat.		Kerusakan infrastruktur sanitasi seperti tangki septik dan saluran pembuangan.		Risiko penumpukan limbah medis berbahaya karena gangguan pengangkutan limbah.		Pemadaman listrik berkepanjangan akibat kerusakan sistem kelistrikan yang disebabkan banjir.		Risiko ketergantungan pada energi cadangan yang terbatas, menyebabkan gangguan layanan kesehatan.		Kerusakan pada peralatan teknologi medis yang terpapar air, mengurangi efektivitas dan fungsinya.		Risiko kehilangan produk medis yang terkontaminasi atau rusak akibat air banjir.
	Mengalami penyakit menular seperti leptospirosis atau penyakit yang ditularkan melalui air tercemar.		Potensi kesulitan menjaga kebersihan pribadi karena sanitasi yang buruk di fasilitas yang terkena banjir.		Terbatasnya akses air bersih karena sistem distribusi air rusak atau terkontaminasi.		Potensi rusaknya fasilitas penyimpanan limbah yang menyebabkan limbah medis tercecer ke lingkungan.		Gangguan pasokan energi cadangan seperti generator yang rusak atau terendam air.		Potensi kesulitan pemulihan pasokan energi yang membutuhkan waktu lama setelah banjir.		Gangguan proses operasional akibat kebanjiran yang menghalangi mobilitas tenaga kesehatan dan pengiriman produk medis.		Potensi gangguan besar pada proses operasional fasilitas kesehatan akibat akses terbatas dan kerusakan infrastruktur.
	Kerusakan alat pelindung diri (APD) karena kondisi lingkungan		Potensi kehilangan tenaga kerja sementara atau permanen jika		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...

Apakah Fasyankes,												
Tenaga Kesehatan				**WASH dan limbah pelayanan kesehatan**				**Layanan energi**				**Infrastruktur, teknologi, produk, dan proses**			
Dampak		**Potensi Dampak**		**Dampak**		**Potensi Dampak**		**Dampak**		**Potensi Dampak**		**Dampak**		**Potensi Dampak**	
	basah atau kotor.		fasilitas rusak berat												
	Lainnya ...		Lainnya …												
B. Badai / Puting Beliung															
	Cedera fisik akibat tertimpa puing-puing saat badai		Risiko kesehatan mental jangka panjang akibat trauma menangani korban badai.		Kerusakan fasilitas air dan sanitasi, serta pengolahan limbah akibat angin kencang dan hujan deras.		Risiko peningkatan pencemaran air tanah dari limbah layanan kesehatan yang tersebar.		Kerusakan pada jaringan distribusi energi akibat angin kencang yang merobohkan tiang listrik dan kabel.		Risiko pemadaman listrik yang lebih lama akibat kerusakan infrastruktur yang membutuhkan waktu lama untuk perbaikan.		Kerusakan pada struktur bangunan dan atap fasilitas kesehatan akibat angin kencang dan hujan deras.		Potensi risiko kerusakan jangka panjang pada fasilitas yang memperlambat proses pemulihan dan memengaruhi proses layanan.
	Kelelahan ekstrem karena bekerja dalam kondisi darurat dengan sumber daya terbatas.		Potensi pengurangan tenaga kerja akibat cedera atau dampak badai terhadap individu tenaga kesehatan.		Kontaminasi air bersih dari limbah layanan kesehatan yang terbawa oleh banjir akibat badai.		Potensi terhentinya layanan sanitasi karena kerusakan fasilitas pengolahan limbah.		Pemadaman listrik besar-besaran akibat kerusakan infrastruktur dan gangguan sistem.		Potensi keterbatasan energi di fasilitas kesehatan yang bergantung pada pasokan energi eksternal.		Gangguan operasional peralatan medis akibat pemadaman listrik dan kerusakan infrastruktur pendukung.		Risiko gangguan pasokan energi yang menyebabkan ketergantungan pada sumber energi cadangan yang terbatas.
	Gangguan komunikasi dengan tim lain, menambah tekanan saat merespons kebutuhan pasien.		Ketergantungan tinggi pada bantuan eksternal untuk pemulihan fasyankes dan kebutuhan staf.		Gangguan distribusi air bersih ke fasilitas kesehatan akibat putusnya jaringan air.		Risiko gagal mengolah limbah berbahaya akibat gangguan operasional fasilitas.		Gangguan pasokan energi cadangan akibat kerusakan pada generator atau sistem backup.		Potensi penurunan kapasitas energi terbarukan yang terganggu oleh badai, khususnya panel surya dan turbin angin.		Penurunan kualitas produk medis jika terpapar kelembaban tinggi atau kerusakan sistem penyimpanan.		Potensi penurunan kualitas peralatan medis akibat kerusakan dan kegagalan sistem pendukung energi dan teknologi.
	Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya …		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...	

Apakah Fasyankes,												
Tenaga Kesehatan				**WASH dan limbah pelayanan kesehatan**				**Layanan energi**				**Infrastruktur, teknologi, produk, dan proses**			
Dampak		**Potensi Dampak**		**Dampak**		**Potensi Dampak**		**Dampak**		**Potensi Dampak**		**Dampak**		**Potensi Dampak**	
C. Kenaikan Muka Air Laut															
	Gangguan psikologis akibat ancaman kehilangan fasilitas kesehatan di wilayah pesisir.		Paparan risiko kesehatan tambahan dari intrusi air asin yang mencemari air minum.		Intrusi air asin mencemari sumber air baku (air permukaan, air tanah) untuk fasilitas kesehatan.		Potensi peningkatan risiko infeksi penyakit kulit dan gastrointestinal akibat kualitas air buruk.		Kerusakan infrastruktur energi pesisir seperti pembangkit listrik dan jaringan distribusi yang terendam air laut.		Risiko kerusakan fasilitas energi yang menyebabkan pemadaman listrik yang lebih sering dan lama.		Kerusakan pada fasilitas yang terletak di pesisir akibat terendam air laut, merusak bangunan dan infrastruktur vital.		Risiko kerusakan permanen pada fasilitas vital yang tidak dapat dipulihkan akibat terendam air laut.
	Evakuasi mendadak memengaruhi kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan.		Potensi perpindahan atau relokasi tenaga kerja yang menyebabkan kekurangan staf di wilayah tertentu.		Korosi pada infrastruktur sanitasi akibat paparan air asin.		Risiko hilangnya fasilitas sanitasi karena area pesisir terendam air laut.		Gangguan pasokan energi akibat intrusi air asin yang merusak sistem kelistrikan dan peralatan.		Potensi gangguan pasokan energi terbarukan akibat kerusakan pada sistem pembangkit pesisir seperti pembangkit angin dan surya.		Kerusakan pada teknologi dan peralatan medis yang terpapar air asin, yang mempercepat korosi dan kerusakan komponen.		Potensi kerusakan besar pada peralatan medis karena korosi akibat air asin yang dapat menurunkan umur pakai teknologi.
	Kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan di daerah terdampak, memengaruhi kesejahteraan tenaga kesehatan.		Potensi lonjakan kelelahan emosional karena menangani korban dari komunitas pesisir		Gangguan operasional pada pengolahan limbah layanan kesehatan karena sumber air tidak layak.		Potensi tingginya biaya pengadaan air bersih untuk menggantikan air yang telah terkontaminasi.		Keterbatasan akses ke energi cadangan jika fasilitas energi pesisir terancam atau rusak.		Potensi kerusakan jangka panjang pada infrastruktur energi yang membutuhkan investasi besar untuk perbaikan.		Gangguan pasokan bahan baku dan produk medis yang terhambat oleh infrastruktur pelabuhan yang terendam air laut.		Potensi gangguan pada rantai pasokan produk medis yang berasal dari kawasan pesisir yang terpengaruh oleh kenaikan muka laut.
	Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya …		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...

Apakah Fasyankes,												
Tenaga Kesehatan				WASH dan limbah pelayanan kesehatan				Layanan energi				Infrastruktur, teknologi, produk, dan proses			
Dampak		Potensi Dampak		Dampak		Potensi Dampak		Dampak		Potensi Dampak		Dampak		Potensi Dampak	
D. Kekeringan															
	Dehidrasi dan kelelahan panas akibat bekerja dalam kondisi suhu tinggi dan kurangnya air.		Potensi penurunan kesehatan jangka panjang akibat stres panas yang terus menerus.		Kekurangan air untuk sanitasi dan kebersihan di fasilitas kesehatan.		Risiko Peningkatan kasus ISPA dan diare		Gangguan pasokan energi hidroelektrik akibat berkurangnya aliran sungai yang digunakan untuk pembangkit listrik.		Potensi risiko krisis energi jika kapasitas pembangkit hidroelektrik terganggu atau tidak dapat beroperasi.		Kekurangan pasokan air yang menghambat proses sterilisasi alat medis dan kebersihan lingkungan.		Potensi risiko gangguan pada sistem sanitasi dan pembuangan limbah yang dapat mempengaruhi kebersihan fasilitas.
	Gangguan kebersihan pribadi karena terbatasnya air untuk sanitasi.		Potensi penurunan produktivitas kerja akibat kelelahan fisik dan mental		Gangguan pada sistem pengolahan limbah layanan kesehatan akibat kurangnya air		Potensi penyebaran infeksi karena sanitasi yang buruk.		Peningkatan ketergantungan pada energi fosil jika pasokan energi terbarukan terganggu.		Risiko tingginya biaya energi karena peningkatan penggunaan energi fosil akibat kekurangan energi terbarukan.		Gangguan pada pasokan energi terbarukan (misalnya, pembangkit hidroelektrik) yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan medis.		Risiko ketergantungan pada teknologi energi yang lebih mahal seperti energi fosil jika pasokan energi terbarukan berkurang.
	Meningkatnya beban kerja akibat lonjakan pasien dengan penyakit terkait panas, seperti dehidrasi.		Potensi terkena penyakit akibat kekeringan		Penurunan kualitas kebersihan lingkungan di fasilitas kesehatan karena terbatasnya air.		Risiko kerusakan fasilitas air dan sanitasi akibat debit air yang tidak stabil/kering		Kekurangan air untuk pendinginan pembangkit listrik atau generator, mengurangi kapasitas operasional.		Potensi pembatasan pasokan energi untuk sektor-sektor tertentu, termasuk fasilitas kesehatan.		Penurunan kualitas produk medis yang bergantung pada suhu dan kelembaban, misalnya vaksin yang membutuhkan pendinginan yang stabil.		Potensi kerusakan produk medis yang memerlukan lingkungan khusus (misalnya vaksin yang memerlukan suhu rendah) karena gangguan pada sistem pendinginan.<
	Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya …		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...

Apakah Fasyankes,												
Tenaga Kesehatan				**WASH dan limbah pelayanan kesehatan**				**Layanan energi**				**Infrastruktur, teknologi, produk, dan proses**	
Dampak		**Potensi Dampak**		**Dampak**		**Potensi Dampak**		**Dampak**		**Potensi Dampak**		**Dampak**	**Potensi Dampak**
E. Kebakaran Hutan													
	Gangguan pernapasan akibat paparan asap yang berkepanjangan.		Peningkatan risiko kesehatan kronis seperti penyakit paru-paru dan kardiovaskular.		Peningkatan limbah layanan kesehatan yang terkontaminasi asap dan abu dari kebakaran.		Risiko pencemaran sumber air akibat partikel debu dan bahan kimia dari asap kebakaran.		Kerusakan pada jaringan listrik akibat kebakaran yang merusak tiang listrik dan saluran transmisi.		Risiko terjadinya gangguan jangka panjang pada pasokan energi karena kerusakan yang sulit diperbaiki setelah kebakaran.		Kerusakan pada infrastruktur listrik dan jaringan komunikasi akibat kebakaran yang merusak sistem penghubung dan pembangkit energi.		Potensi risiko gangguan pada pengolahan produk medis yang memerlukan kondisi udara dan suhu tertentu untuk menjaga kualitas.
	Beban kerja meningkat karena lonjakan pasien dengan luka bakar atau masalah pernapasan.		Potensi pengurangan tenaga kerja karena tenaga medis terkena dampak fisik dari paparan asap.		Kerusakan fasilitas sanitasi akibat kebakaran di area sekitar fasilitas kesehatan.		Potensi peningkatan biaya pengolahan limbah layanan kesehatan akibat dampak kebakaran.		Pemadaman listrik akibat kebakaran yang merusak pembangkit listrik atau kabel distribusi.		Potensi gangguan besar pada energi terbarukan seperti pembangkit surya dan angin yang terkena dampak kebakaran.		Gangguan pada pengolahan produk medis jika fasilitas terkena dampak asap yang merusak kualitas udara dan bahan baku medis.		Potensi kerusakan jangka panjang pada infrastruktur kesehatan yang mempengaruhi proses operasional dan pelayanan kesehatan.
	Stres emosional akibat kondisi kerja yang berbahaya dan penanganan pasien dalam jumlah besar.		Peningkatan kebutuhan alat pelindung diri yang sulit dipenuhi saat bencana berlangsung.		Lainnya …		Lainnya ...		Gangguan akses ke energi cadangan akibat kebakaran yang merusak fasilitas energi terdekat.		Potensi kerusakan pada fasilitas penyimpanan energi yang dapat menghambat proses pemulihan pasokan energi.		Kerusakan pada peralatan medis dan sistem pendinginan yang terpapar debu atau asap yang mengganggu kinerja peralatan.		Risiko penurunan daya tahan produk medis jika terpapar asap atau partikel berbahaya yang dapat merusak bahan aktifnya.
	Lainnya ...		Lainnya ...						Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...		Lainnya ...

Formulir - 2b Dampak dari Bahaya

A	CHECKLIST DAMPAK TERHADAP KEJADIAN BANJIR					
A.1	TENAGA KESEHATAN					
	TINGKAT DAMPAK					
No.	BESAR		No.	SEDANG	No.	KECIL
1	☐ Kematian atau cedera yang mengancam jiwa atau penyakit (misalnya tenggelam, hipotermia, dan penyakit menular, seperti penyakit diare, leptospirosis, kolera, penyakit yang ditularkan melalui vektor)		1	☐ Cedera, bahaya, atau penyakit serius yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau perawatan medis	1	☐ Cedera ringan pada tenaga kesehatan, tidak memerlukan pelayanan medis segera
2	☐ Tenaga kesehatan tidak dapat datang atau meninggalkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2	☐ Tenaga kesehatan mengalami kesulitan saat tiba di atau meninggalkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2	☐ Kesulitan dalam memberikan pengobatan dan pengobatan yang biasa
3	☐ Kehilangan kapasitas kerja yang besar		3	☐ Pengurangan fungsi tenaga kesehatan	3	☐ Pengurangan layanan primer di rumah bagi masyarakat
4	☐ Penghentian program atau layanan penting		4	☐ Pembatasan penyediaan layanan dan program	4	☐ Keterlambatan penyampaian layanan dan program
5	☐ Kapasitas kinerja tenaga kesehatan yang sangat berkurang sehingga memerlukan dukungan tambahan (lokal, regional atau nasional)		5	☐ Tidak mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada pasien		
6	☐ Dampak terhadap kesehatan mental staf akibat trauma bencana, kehilangan anggota keluarga, teman atau pasien		6	☐ Meningkatnya beban kerja disertai stres		
7	☐ Meningkatnya permintaan layanan kesehatan akibat penyakit menular (penyakit yang ditularkan melalui air, makanan, dan vektor), gigitan hewan (termasuk hewan berbisa), infeksi saluran pernapasan, penyakit zoonosis (penyakit yang ditularkan melalui tikus seperti sindrom paru hantavirus, leptospirosis), penyakit tidak menular, sengatan listrik, dan paparan bahan kimia beracun.		7	☐ Kelebihan kapasitas fasilitas		
8	☐ Meningkatnya beban kerja dan stres tenaga kesehatan		8	☐ Meningkatnya kasus penyakit menular di kalangan tenaga kesehatan akibat pencemaran air dan limbah layanan Kesehatan		

A.2	WASH DAN LIMBAH PELAYANAN KESEHATAN					
	TINGKAT DAMPAK					
No.	BESAR		No.	SEDANG	No.	KECIL
1	☐ Kerusakan pada infrastruktur pasokan dan penyimpanan air		1	☐ Gangguan pasokan air sementara	1	☐ Berkurangnya kapasitas untuk mengakses air minum
2	☐ Gangguan pada sistem pembuangan air limbah dan pembuangan kotoran		2	☐ Berkurangnya kapasitas penyediaan air bersih untuk minum atau memasak	2	☐ Berkurangnya kapasitas penggunaan toilet, kamar mandi, dll.
3	☐ Kontaminasi air		3	☐ Kapasitas yang berkurang untuk menyediakan proses desinfeksi atau sterilisasi	3	☐ Berkurangnya kapasitas penggunaan mesin cuci dan pencuci piring
4	☐ Kekurangan air bersih		4	☐ Kontaminasi silang dari kerusakan pada sistem pembuangan limbah	4	☐ Kapasitas yang berkurang untuk menyediakan layanan kebersihan (lantai, toilet, kamar pasien, ruang gawat darurat)
5	☐ Fasyankes tidak bisa menyediakan layanan kebersihan sehingga mengganggu pelayanan		5	☐ Kualitas air menurun karena kotoran hewan dan limbah masuk ke air permukaan	5	☐ Beban sedimen dan polusi yang besar membuat pengolahan menjadi tidak efektif
6	☐ Kerusakan pada penyimpanan limbah yang menyebabkan kontaminasi lingkungan oleh bahaya biologis dan kimia		6	☐ Berkurangnya kapasitas untuk memelihara sistem pengumpulan dan pengolahan limbah	6	☐ Kemungkinan adanya serangan tikus di sekitar tempat sampah
7	☐ Tempat sampah tajam dan tempat sampah limbah berbahaya yang hilang					
8	☐ Kerusakan pada sumber air darurat					
9	☐ Toilet tidak tersedia					
A.3	ENERGI					
	TINGKAT DAMPAK					
No.	BESAR		No.	SEDANG	No.	KECIL
1	☐ Mati listrik		1	☐ Gangguan pasokan listrik sementara	1	☐ Suhu ruangan menjadi tidak dingin
2	☐ Tidak berfungsinya sistem penyimpanan dingin		2	☐ Kesulitan dalam memberikan layanan perawatan kesehatan kritis (dialisis, terapi oksigen, peralatan diagnosis), yang menyebabkan pasien dievakuasi ke fasilitas kesehatan lain	2	☐ Rusaknya makanan akibat suhu penyimpanan yang tidak sesuai
3	☐ Gangguan dalam penyediaan layanan kesehatan yang membutuhkan listrik seperti dialisis, terapi oksigen, peralatan diagnosis.		3	☐ Berkurangnya kapasitas untuk menyediakan layanan yang membutuhkan listrik (mesin cuci, dll.)	3	☐ Terganggunya aktivitas memanaskan air

4	☐	Rusaknya vaksin, perlengkapan laboratorium,persediaan darah, farmasi, persediaan makanan, dan persediaan medis penting lainnya yang bergantung pada pendingin.	4	☐	Kapasitas yang berkurang untuk menyediakan layanan desinfeksi yang membutuhkan listrik (autoklaf, microwave)			
5	☐	Kerusakan pada generator darurat atau sumber energi lainnya						
6	☐	Gangguan pada pasokan bahan bakar						
7	☐	Terganggunya sistem pemompaan dan pengolahan air yang bergantung pada energi						
A.4	**INFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI, PRODUK DAN PROSES**							
	TINGKAT DAMPAK							
	BESAR			**SEDANG**			**KECIL**	
1	☐	Kerusakan akibat banjir atau kerusakan komponen struktural (seluruh atau sebagian fasilitas)	1	☐	Gangguan pada sistem dan aset komunikasi dan informasi	1	☐	Gangguan layanan yang bersifat lokal dengan kerugian dan kerusakan yang kecil
2	☐	Kerusakan sebagian akibat banjir menyebabkan erosi tanah	2	☐	Kerusakan jalan, mengganggu akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2	☐	Kerusakan atau kehilangan dokumen dan catatan fasilitas pelayanan kesehatan
3	☐	Sistem transportasi terblokir dan stasiun ambulans terendam banjir	3	☐	Kesulitan dalam transportasi pasien karena sistem transportasi yang rusak atau cacat	3	☐	Tidak ada dampak jangka panjang pada lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan eksternal
4	☐	Kerusakan pada akses bangunan	4	☐	Berkurangnya kapasitas penyediaan layanan kesehatan akibat kerusakan dan berkurangnya pasokan	4	☐	Dampak minimal terhadap operasi dan peralatan lokal yang tidak mengganggu pemberian layanan perawatan kesehatan
5	☐	Kerusakan pada ruang mesin	5	☐	Penghentian sementara pemberian layanan	5	☐	Dampak minimal pada rantai pasokan, yang dapat terus mendukung kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan
6	☐	Kerusakan pada peralatan kritis	6	☐	Kerusakan pada penyimpanan catatan medis kertas	6	☐	Kemungkinan jamur, baik di dalam maupun di luar ruangan, memerlukan pembersihan khusus atau peralatan pelindung diri yang penting bagi petugas kebersihan
7	☐	Kerusakan sistem komunikasi dan informasi internal dan eksternal	7	☐	Berkurangnya kapasitas untuk mengakses pasokan klinis dan laboratorium	7	☐	Meningkatnya permintaan untuk menyediakan perlengkapan pembersihan dan disinfeksi
8	☐	Kehilangan atau kerusakan persediaan penting fasilitas pelayanan kesehatan (obat-obatan, peralatan medis, narkotika, perlengkapan laboratorium, darah, farmasi, vaksin)	8	☐	Meningkatnya angka rawat inap yang membutuhkan pasokan medis dan tenaga kesehatan tambahan			

9	☐	Penghentian layanan perawatan kesehatan yang kompleks dan darurat (operasi, perawatan kompleks, perawatan mendesak)	9	☐	Permintaan tinggi untuk layanan pembersihan di semua gedung fasilitas setelah kejadian banjir yang membutuhkan peralatan pelindung diri tambahan			
10	☐	Terganggunya penyediaan dan operasional layanan kesehatan	10	☐	Meningkatnya permintaan biaya perbaikan atau pembelian peralatan dan perangkat medis yang rusak atau hilang, yang dibutuhkan untuk pemulihan jangka pendek			
11	☐	Penghentian layanan atau gangguan layanan dalam jangka waktu yang lama karena kehilangan atau kerusakan	11	☐	Meningkatnya biaya karena diperlukannya perbaikan pasca banjir			
12	☐	Rincian layanan pelayanan kesehatan rutin (seperti rawat jalan, imunisasi, ruang bersalin, apotek, pengobatan penyakit kronis, gigi, dan pelayanan primer lainnya)	12	☐	Meningkatnya biaya perbaikan semua peralatan dan perabotan administrasi yang rusak			
13	☐	Terganggunya diagnosa akibat kerusakan peralatan						
14	☐	Kontaminasi alat, instrumen dan perlengkapan medis						
15	☐	Gangguan rantai pasokan						
16	☐	Dampak jangka panjang terhadap lingkungan membutuhkan bantuan/intervensi eksternal						
17	☐	Kerusakan pada sistem transportasi internal (lift, ramp, koridor)						
18	☐	Meningkatnya biaya langsung dan jangka panjang untuk pemulihan kerusakan						
B	**CHECKLIST DAMPAK TERHADAP KEJADIAN BADAI/ANGIN PUTING BELIUNG**							
B.1	**TENAGA KESEHATAN**							
	TINGKAT DAMPAK							
	BESAR			**SEDANG**			**KECIL**	
1	☐	Kematian, cedera atau penyakit yang mengancam jiwa di kalangan tenaga kesehatan	**1**	☐	Cedera serius, cedera atau penyakit yang menyebabkan rawat inap dan perawatan medis	**1**	☐	Cedera ringan pada petugas kesehatan yang memerlukan perawatan medis minimal atau jangka pendek

2	☐	Hilangnya kapasitas kerja	2	☐	Tenaga kesehatan tidak dapat datang atau berangkat dari fasyankes	2	☐	Kesulitan dalam menyediakan obat-obatan dan layanan primer di rumah kepada masyarakat
3	☐	Penghentian program-program penting atau ketersediaan layanan dengan kemungkinan meluapnya ke lokasi lain	3	☐	Pengurangan fungsi tenaga kesehatan	3	☐	Berkurangnya fungsi petugas kesehatan jika fasilitas kesehatan tidak memiliki rencana untuk merespons kepadatan pasien dan pengunjung
4	☐	Mengurangi kapasitas kinerja tenaga kesehatan secara signifikan; membutuhkan dukungan tambahan (lokal, regional atau nasional)	4	☐	Pembatasan terhadap penyediaan beberapa layanan dan program layanan kesehatan	4	☐	Pengiriman layanan dan penundaan program
5	☐	Meningkatnya risiko bahaya pekerjaan, termasuk penyakit yang ditularkan melalui air, makanan dan vektor, gigitan hewan, sengatan listrik, dan paparan bahan kimia berbahaya	5	☐	Dampak terhadap kesehatan mental akibat trauma bencana mengakibatkan berkurangnya kemampuan dalam memberikan perawatan yang memadai kepada pasien			
6	☐	Meningkatnya permintaan layanan kesehatan untuk penyakit menular (penyakit yang ditularkan melalui air, makanan dan vektor), gigitan hewan (termasuk hewan beracun), penyakit tidak menular, dan paparan bahan kimia beracun, meningkatkan kelebihan dan ketersediaan tenaga kesehatan	6	☐	Meningkatnya penyakit pernapasan akibat badai debu			
7	☐	Meningkatnya beban kerja karena stres						
B.2	**WASH DAN LIMBAH PELAYANAN KESEHATAN**							
	TINGKAT DAMPAK							
	BESAR			**SEDANG**			**KECIL**	
1	☐	Meluapnya air hujan dan sistem penampungan air limbah menyebabkan melampaui kapasitas sistem pengolahan dan distribusi air	1	☐	Meningkatnya infeksi pada tenaga kesehatan akibat kontaminasi air dan limbah layanan kesehatan	1	☐	Berkurangnya akses terhadap air untuk praktik layanan kesehatan
2	☐	Kerusakan parah pada sistem pasokan air dan infrastruktur	2	☐	Berkurangnya kapasitas untuk menyediakan layanan bersih yang efisien (lantai, toilet, ruang pasien, ruang gawat darurat, dan ruangan lain di fasilitas)	2	☐	Berkurangnya kapasitas kebersihan (menyiram toilet, pancuran, dll.)
3	☐	Gangguan parah terhadap air limbah dan sistem pembuangan limbah	3	☐	Berkurangnya kapasitas penyediaan air untuk minum dan memasak	3	☐	Mengurangi kapasitas penggunaan mesin laundry dan pencuci piring
4	☐	Curah hujan yang tinggi berisiko menyebabkan banjir patogen ke dalam sumber air	4	☐	Berkurangnya fungsi sistem sanitasi dan praktik kebersihan (penyiram toilet,	4	☐	Beban sedimen dan polusi yang berat membuat pengolahan menjadi tidak efektif

					pancuran, saluran air limbah, perawatan, cuci tangan, prosedur medis, dll.)			
5	☐	Pencemaran air skala besar	**5**	☐	Sistem pembuangan limbah yang rusak menyebabkan kontaminasi silang	**5**	☐	Peningkatan risiko rusaknya sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah akhir di dalam/di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6	☐	Kekurangan air bersih	**6**	☐	Kemungkinan kerusakan pada sumber air darurat			
7	☐	Tidak ada akses terhadap air minum	**7**	☐	Peningkatan beban nutrisi			
8	☐	Tidak mampu menyediakan sanitasi dan layanan kebersihan	**8**	☐	Kemungkinan meluapnya limbah ke sungai dan sungai jika air permukaan masuk ke tangki septik			
9	☐	Kerusakan pada tempat penyimpanan sampah menyebabkan pencemaran lingkungan dari bahaya biologis dan kimia	**9**	☐	Meningkatnya kemungkinan kontaminasi air tanah akibat infiltrasi polutan (termasuk saat badai debu atau pasir)			
10	☐	Wadah benda tajam dan spesifik tempat sampah biologis dan medis rusak, berpotensi lepas bahan berbahaya						
11	☐	Peningkatan risiko kontaminasi peralatan medis, instrumen dan peralatan, dan medis lainnya persediaan						
B.3	**ENERGI**							
	TINGKAT DAMPAK							
	BESAR			**SEDANG**			**KECIL**	
1	☐	Pemadaman listrik (akibat angin dan petir)	**1**	☐	Kesulitan dalam memberikan layanan kesehatan (seperti dialisis, ruang perawatan intensif, terapi oksigen, radioterapi, ,pencitraan dan peralatan diagnostik), mengakibatkan pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lain.	**1**	☐	Tidak berfungsinya pendingin udara, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi staf dan pasien.
2	☐	Gangguan pelayanan medis akut atau layanan kesehatan lain yang mengandalkan listrik (seperti dialisis, ruang perawatan intensif, terapi oksigen, radioterapi, ruang laboratorium, peralatan radiologi, dan area lainnya)	**2**	☐	Menurunkan kemampuan dalam menyediakan layanan kebersihan yang bergantung pada listrik (seperti laundry).	**2**	☐	Rusaknya makanan akibat suhu penyimpanan yang tidak sesuai

3	☐	Rusaknya vaksin, perlengkapan laboratorium, obat-obatan, nutrisi parenteral persediaan darah, farmasi, persediaan makanan, dan persediaan medis penting lainnya yang bergantung pada pendingin.	3	☐	Menurunkan kemampuan dalam menyediakan layanan desinfeksi yang membutuhkan listrik (autoklaf, microwave)	3	☐	Terganggunya aktivitas memanaskan air
4	☐	Gangguan pada pasokan bahan bakar	4	☐	Penurunan kapasitas listrik menyebabkan rusaknya perbekalan medis dan menurunnya layanan kesehatan.			
5	☐	Kerusakan pada fotovoltaik surya panel atau sumber energi lainnya	5	☐	Kemungkinan kerusakan pada generator darurat atau sumber energi lainnya			
6	☐	Terganggunya sistem pemompaan dan pengolahan air yang bergantung pada energi						
B.4	**INFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI, PRODUK DAN PROSES**							
	TINGKAT DAMPAK							
	BESAR			**SEDANG**			**KECIL**	
1	☐	Kerusakan langsung pada infrastruktur (tangki penyimpanan air, atap) akibat angin kencang	1	☐	Kerusakan struktural pada bangunan	1	☐	Gangguan terlokalisir layanan dengan kerugian kecil dan kerusakan
2	☐	Kegagalan struktural bangunan	2	☐	Kerusakan jalan, penurunan kualitas mengakses	2	☐	Kerusakan atau kehilangan dokumen dan catatan
3	☐	Gangguan akses gedung	3	☐	Sulit untuk mengangkut pasien karena rusak atau cacat sistem transportasi	3	☐	Tidak ada efek yang bertahan lama pada lingkungan eksternal dari fasilitas
4	☐	Kerusakan pada ruang mesin	4	☐	Mengurangi kapasitas pengiriman pelayanan kesehatan karena rusak dan berkurangnya persediaan	4	☐	Dampak minimal terhadap lokal operasi dan peralatan, tanpa kompromi layanan kesehatan pengiriman
5	☐	Kerusakan komunikasi dan sistem informasi dan aset	5	☐	Penghentian sementara layanan pengiriman	5	☐	Dampak minimal pada rantai pasokan
6	☐	Kehilangan atau kerusakan yang penting perbekalan (obat-obatan, perawatan, alat kesehatan, obat-obatan, obat-obatan, vaksin, dll.)	6	☐	Rusaknya kertas rekam medis penyimpanan			
7	☐	Interupsi kompleks dan layanan perawatan kesehatan darurat (pembedahan, perawatan kompleks, mendesak layanan kesehatan, dll.)	7	☐	Mengurangi kapasitas untuk mengakses perlengkapan klinis dan laboratorium			
8	☐	Gangguan pelayanan kesehatan dan operasi	8	☐	Dampak dari tumbangnya pohon fasilitas yang menyebabkan kerusakan untuk membangun infrastruktur dan cedera pada orang			

9	☐	Penghentian layanan atau berkepanjangan gangguan pelayanan karena kehilangan atau kerusakan	9	☐	Peningkatan angka rawat inap memerlukan pasokan medis tambahan dan tenaga kesehatan			
10	☐	Rincian layanan kesehatan rutin layanan (seperti rawat jalan, imunisasi, ruang bersalin, farmasi, obat untuk kronis penyakit, dan penyakit primer lainnya layanan)	10	☐	Meningkatnya biaya karena tinggi permintaan pasokan penting selama dan setelah acara			
11	☐	Gangguan diagnosis karena kerusakan peralatan	11	☐	Peningkatan biaya karena diperlukan investasi keuangan di pemulihan infrastruktur fasilitas (struktural dan nonstruktural),pasca acara			
12	☐	Gangguan rantai pasokan						
13	☐	Efek jangka panjang pada lingkungan, membutuhkan eksternal bantuan/intervensi						
14	☐	Kerusakan transportasi internal sistem (lift, landai, koridor, garasi, dll.)						
15	☐	Meningkatnya permintaan pengobatan untuk menular, kardiovaskular dan penyakit pernapasan						
16	☐	Peningkatan yang kompleks dan darurat pelayanan kesehatan (kompleks pengobatan, wabah, dll.)						
C	**CHECKLIST DAMPAK TERHADAP KENAIKAN MUKA AIR LAUT**							
C.1	**TENAGA KESEHATAN**							
	TINGKAT DAMPAK							
	BESAR			**SEDANG**			**KECIL**	
1	☐	Peningkatan risiko pertumbuhan jamur di dalam ruangan akibat kelembaban berlebih, yang berdampak pada penyakit pernapasan	**1**	☐	Kemungkinan peningkatan risiko penyakit menular bagi tenaga kesehatan akibat kontaminasi air dan limbah layanan kesehatan	**1**	☐	Pengurangan fungsi tenaga kesehatan
2	☐	Tenaga kesehatan tidak dapat datang atau berangkat dari fasyankes	**2**	☐	Salinitas air yang tinggi menyebabkan peningkatan risiko hipertensi pada tenaga kesehatan	**2**	☐	Pengiriman layanan dan penundaan program
3	☐	Hilangnya kapasitas kerja	**3**	☐	Cedera ringan pada petugas kesehatan yang memerlukan perawatan medis jangka pendek	**3**	☐	Cedera ringan pada tenaga kesehatan yang tidak memerlukan penanganan medis segera

4	☐	Meningkatnya permintaan layanan kesehatan akibat penyakit menular dan tidak menular (efek ginjal, penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan) dan cedera (sengatan listrik, paparan bahan kimia)	4	☐	Mengurangi kapasitas kinerja secara signifikan yang memerlukan dukungan tambahan (lokal, regional, atau nasional)			
5	☐	Penghentian beberapa program atau layanan dengan kemungkinan meluapnya pasien ke lokasi lain	5	☐	Pembatasan untuk memberikan layanan dan program perawatan kesehatan			
			6	☐	Meningkatnya beban kerja yang mengakibatkan stres			
C.2	**WASH DAN LIMBAH PELAYANAN KESEHATAN**							
	TINGKAT DAMPAK							
	BESAR			**SEDANG**			**KECIL**	
1	☐	Kerusakan permanen pada sistem infrastruktur air, air limbah dan limbah	1	☐	Intrusi air asin ke dalam sistem penampungan air dan air limbah menyebabkan berkurangnya kapasitas pengolahan dan distribusi air	1	☐	Peningkatan pengelolaan dan perbaikan air dan air limbah akibat genangan atau erosi
2	☐	Meningkatnya intrusi air asin ke dalam akuifer, mengakibatkan peningkatan salinitas cekungan air tanah dan air sumur	2	☐	Terbatasnya akses terhadap air untuk minum dan memasak	2	☐	Kekurangan air bersih
3	☐	Kontaminasi air	3	☐	Mengurangi volume air tawar yang disimpan	3	☐	Kerusakan pada sumber air darurat alternatif
4	☐	Tidak ada akses terhadap air minum	4	☐	Berkurangnya kapasitas untuk menyediakan proses desinfeksi atau sterilisasi dan layanan kebersihan	4	☐	Berkurangnya kapasitas untuk menyediakan layanan pembersihan yang aman (lantai, toilet, ruang pasien, ruang gawat darurat, dan ruangan lain di fasilitas tersebut)
5	☐	Kebocoran dari septic tank, sistem saluran pembuangan dan ketidakstabilan tangki penyimpanan dan pipa	5	☐	Masuknya air permukaan ke dalam tangki septik menyebabkan limpahan limbah ke sungai, sungai dan lautan	5	☐	Mengurangi kapasitas untuk menggunakan mesin laundry dan pencuci piring
6	☐	Peningkatan korosi pada sistem drainase air dan air limbah	6	☐	Risiko hilangnya atau rusaknya wadah benda tajam dan tempat sampah biologis dan medis tertentu	6	☐	Kemungkinan kerusakan pada sumber air darurat
7	☐	Kemungkinan kontaminasi pada peralatan, instrumen dan perlengkapan medis						
8	☐	Risiko pencemaran lingkungan akibat bahaya biologis dan kimia						
9	☐	Hilangnya sistem pemompaan dan pengolahan air						

C.3	ENERGI					
	TINGKAT DAMPAK					
	BESAR		SEDANG		KECIL	
1	☐ Kerusakan pada jalur/kabel listrik menyebabkan pemadaman	1	☐ Gangguan pada pembangkit dan penyaluran listrik	1	☐ Rusaknya vaksin, perlengkapan laboratorium, obat-obatan, nutrisi parenteral persediaan darah, farmasi, persediaan makanan, dan persediaan medis penting lainnya yang bergantung pada pendingin.
2	☐ Matinya Listrik	2	☐ Terganggunya aktivitas memanaskan air	2	☐ Tertundanya penyalaan listrik, sehingga mempengaruhi layanan kesehatan
3	☐ Matinya sistem penyimpanan dingin	3	☐ Kerusakan pada generator darurat atau sumber energi lainnya	3	☐ Menurunkan kemampuan dalam menyediakan layanan kebersihan yang bergantung pada listrik (seperti laundry).
4	☐ Gangguan dalam penyediaan layanan kesehatan yang membutuhkan listrik seperti dialisis, terapi oksigen, peralatan diagnosis.	4	☐ Gangguan dalam penyediaan layanan kesehatan yang membutuhkan listrik seperti dialisis, terapi oksigen, peralatan diagnosis.	4	☐ Suhu ruangan menjadi tidak dingin
5	☐ Terganggunya sistem komunikasi dan informasi baik internal dan eksternal	5	☐ Pasien perlu dipindahkan ke lokasi lain	5	☐ Rusaknya makanan akibat suhu penyimpanan yang tidak sesuai
6	☐ Gangguan pada rantai pasokan bahan bakar	6	☐ Rusaknya vaksin, perlengkapan laboratorium, persediaan darah, farmasi, persediaan makanan, dan persediaan medis penting lainnya yang bergantung pada pendingin.	6	☐ Terganggunya menyediakan layanan desinfeksi yang membutuhkan listrik
C.4	INFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI, PRODUK DAN PROSES					
	TINGKAT DAMPAK					
	BESAR		SEDANG		KECIL	
1	☐ Kerusakan infrastruktur (struktural dan nonstruktural; seluruh atau sebagian fasilitas)	1	☐ Kerusakan infrastruktur (struktural dan nonstruktural; seluruh atau sebagian fasilitas)	1	☐ Gangguan layanan yang terlokalisir dengan kerugian dan kerusakan ringan
2	☐ Runtuhnya bangunan akibat erosi pantai dan korosi material	2	☐ Gangguan sebagian fungsi fasyankes akibat erosi atau korosi pantai	2	☐ Peningkatan biaya pemeliharaan dan perbaikan gedung fasilitas dan asetnya

3	☐	Peningkatan pengolahan air (proses desalinasi)	**3**	☐	Terganggunya rantai makanan akibat intrusi garam pada pertanian	**3**	☐	Kerusakan atau kehilangan dokumen dan rekam medis
4	☐	Peningkatan pemeliharaan dan perbaikan gedung fasilitas	**4**	☐	Kerusakan akses jalan	**4**	☐	Dampak kecil terhadap operasional lokal tanpa mengorbankan layanan kesehatan
5	☐	Fasilitas banjir yang sedang berlangsung saat air pasang	**5**	☐	Kesulitan dalam mengangkut pasien karena sistem transportasi yang rusak atau cacat	**5**	☐	Dampak minimal pada rantai pasokan
6	☐	Sistem transportasi diblokir dan stasiun ambulans kebanjiran	**6**	☐	Berkurangnya kapasitas untuk memberikan layanan kesehatan karena kerusakan dan berkurangnya akses terhadap pasokan klinis, laboratorium, dan medis	**6**	☐	Dampak negatif jangka pendek terhadap lingkungan
7	☐	Akses gedung diblokir	**7**	☐	Penghentian sementara pemberian layanan			
8	☐	Kerusakan peralatan medis penting	**8**	☐	Tingginya permintaan akan jasa pembersihan seluruh bangunan fasilitas, pasca terjadinya banjir			
9	☐	Kerusakan pada perbekalan penting (obat-obatan, perawatan, alat kesehatan, obat-obatan, perbekalan laboratorium, obat-obatan, vaksin, darah, susu, perbekalan nutrisi dan perbekalan penting lainnya) yang memerlukan reposisi segera	**9**	☐	Dampak jangka panjang terhadap lingkungan memerlukan bantuan/intervensi eksternal			
10	☐	Gangguan dalam pelayanan kesehatan yang kompleks dan darurat (pembedahan, perawatan kompleks, perawatan darurat, bank darah, dll.)	**10**	☐	Peningkatan biaya dari proses desalinasi air			
11	☐	Terganggunya penyelenggaraan dan operasional layanan kesehatan, seperti rawat jalan, imunisasi, ruang bersalin, apotek, pengobatan penyakit kronis, dan layanan primer lainnya	**11**	☐	Kemungkinan penggantian bagian gedung fasilitas kesehatan			
12	☐	Penghentian layanan atau gangguan layanan berkepanjangan karena kehilangan atau kerusakan	**12**	☐	Meningkatnya biaya karena tuntutan reposisi semua peralatan dan perangkat medis yang rusak atau hilang			
13	☐	Gangguan rantai pasokan	**13**	☐	Meningkatnya permintaan untuk menyediakan semua perbekalan penting atau kritis yang diperlukan (obat-obatan, perawatan, peralatan medis, obat-obatan, perbekalan laboratorium, obat-obatan,			

					vaksin, susu, nutrisi parenteral dan perbekalan darah, dan perbekalan penting lainnya)			
14	☐	Kerusakan pada sistem akses internal (misalnya elevator, jalur landai, koridor, garasi)	**14**	☐	Peningkatan biaya pemulihan infrastruktur, pasca peristiwa			
15	☐	Peningkatan biaya pemeliharaan gedung						
16	☐	Kerusakan peralatan dan perabotan medis dan administrasi						
D	**CHECKLIST DAMPAK TERHADAP KEKERINGAN**							
D.1	**TENAGA KESEHATAN**							
	TINGKAT DAMPAK							
	BESAR			**SEDANG**			**KECIL**	
1	☐	Meningkatnya ancaman terhadap tenaga kesehatan dari penyakit menular yang berasal dari kontaminasi air dan tempat perkembangbiakan vektor	**1**	☐	Meningkatnya ancaman terhadap tenaga kesehatan mengakibatkan dampak terkait suhu tinggi, kelembapan udara rendah, dan berkurangnya konsumsi air	**1**	☐	Penyakit akibat kekeringan pada petugas kesehatan yang tidak memerlukan penanganan medis segera
2	☐	Meningkatnya ancaman terhadap tenaga kesehatan yang berdampak pada penyakit tidak menular (kardiovaskular, penyakit pernapasan), mulai dari kualitas udara yang buruk dan suhu yang lebih tinggi	**2**	☐	Kemungkinan sakit pada tenaga kesehatan yang memerlukan penanganan medis	**2**	☐	Pengiriman layanan dan penundaan program
3	☐	Penyakit terkait kekeringan pada petugas kesehatan yang memerlukan rawat inap	**3**	☐	Pengurangan fungsi tenaga kesehatan	**3**	☐	Pembatasan untuk memberikan layanan dan program perawatan kesehatan
4	☐	Efek terhadap kesehatan mental staf menyebabkan stres psikologis	**4**	☐	Berkurangnya kapasitas tenaga kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan karena kurangnya kondisi untuk melakukan prosedur dan layanan kebersihan (kebersihan pribadi dan pekerjaan)	**4**	☐	Berkurangnya kapasitas tenaga kesehatan untuk melakukan prosedur kebersihan yang membahayakan keselamatan
5	☐	Gangguan terhadap ketersediaan program atau layanan penting dengan kemungkinan relokasi ke fasilitas lain (kota atau ibu kota)	**5**	☐	Mengurangi produktivitas	**5**	☐	Kemungkinan berkurangnya kapasitas dan kinerja tenaga kesehatan jika terjadi wabah
6	☐	Berkurangnya kapasitas kinerja tenaga kesehatan	**6**	☐	Kemungkinan peningkatan risiko penyakit yang ditularkan melalui debu (demam lembah, meningitis meningokokus), yang			

					menyebabkan pasien harus dirawat di rumah sakit			
7	☐	Meningkatnya permintaan terhadap layanan kesehatan karena penyakit menular yang berhubungan dengan kekeringan (penyakit yang ditularkan melalui air, makanan dan vektor), penyakit kardiovaskular, ginjal dan pernafasan, kanker (kulit, kandung kemih, paru-paru), malnutrisi dan masalah kesehatan mental	7	☐	Peningkatan risiko kematian terkait dengan dampak kekeringan (penyakit jantung paru dan pernafasan), dan meningkatnya permintaan layanan dari staf			
D.2	**WASH DAN LIMBAH PELAYANAN KESEHATAN**							
	TINGKAT DAMPAK							
	BESAR			**SEDANG**			**KECIL**	
1	☐	Gangguan pasokan sistem air	**1**	☐	Ketersediaan air yang tidak mencukupi untuk menyediakan layanan kesehatan	**1**	☐	Berkurangnya ketersediaan air untuk menyediakan layanan kesehatan
2	☐	Kekurangan atau kekurangan air	**2**	☐	Kualitas air rendah	**2**	☐	Berkurangnya kapasitas untuk menjaga kebersihan toilet, kamar mandi, dll
3	☐	Meningkatnya pencemaran air karena konsentrasi polutan akibat rendahnya aliran dan berkurangnya kadar air (arsenik, besi, mangan, fluorida)	**3**	☐	Berkurangnya fungsi sistem sanitasi dan praktik kebersihan (toilet siram, pancuran, saluran air limbah, cuci tangan, prosedur medis)	**3**	☐	Berkurangnya kapasitas untuk mengakses produk pertanian lokal
4	☐	Meningkatnya pencemaran air akibat konsentrasi unsur hara (fosfor) akibat berkurangnya kadar oksigen terlarut akibat suhu yang lebih tinggi, dan berkurangnya arus sehingga meningkatkan aktivitas fitoplankton	**4**	☐	Berkurangnya kapasitas penyediaan layanan kebersihan (lantai, toilet, ruang pasien, dan ruang fasyankes lainnya)	**4**	☐	Kemungkinan peningkatan lokasi perkembangbiakan vektor karena tidak memadainya penyimpanan air di fasilitas atau area sekitarnya
5	☐	Meningkatnya kontaminasi air oleh pertumbuhan sianobakteri karena peningkatan suhu	**5**	☐	Mengurangi kapasitas untuk menyediakan air untuk mesin cuci dan pencuci piring	**5**	☐	Tidak dapat mengikuti nasihat air mendidih
6	☐	Kontaminasi air dari logam	**6**	☐	Berkurangnya kapasitas untuk memberikan layanan kesehatan karena kekurangan air			
7	☐	Meningkatnya salinitas air pada sumber air tanah akibat berkurangnya imbuhan	**7**	☐	Berkurangnya kapasitas akses air minum bagi tenaga kesehatan dan pasien			
8	☐	Tidak ada akses terhadap air minum untuk minum dan memasak	**8**	☐	Mengurangi kapasitas untuk melakukan desinfeksi atau sterilisasi			
9	☐	Kurangnya ketersediaan air untuk mencuci, memasak dan kebersihan mengganggu pemberian layanan kesehatan	**9**	☐	Meningkatnya ketergantungan pada sumber air alternatif yang kurang aman			

10	☐	Kemungkinan kontaminasi peralatan, instrumen dan perlengkapan medis	10	☐	Kurangnya air bersih untuk menyediakan layanan kesehatan yang kompleks			
11	☐	Layanan perawatan kesehatan kompleks dan darurat yang dikompromikan (pembedahan, perawatan darurat)	11	☐	Mengurangi kemanjuran bahan kimia untuk mengolah air			
12	☐	Terganggunya pelayanan kesehatan rutin seperti rawat jalan, imunisasi, ruang bersalin, kedokteran gigi, dan pelayanan primer lainnya						
13	☐	Penghapusan air limbah yang tidak memadai						
14	☐	Meningkatnya angka kerusakan pipa						
D.3	**ENERGI**							
	TINGKAT DAMPAK							
	BESAR			**SEDANG**			**KECIL**	
1	☐	Matinya Listrik	1	☐	Terganggunya aliran listrik	1	☐	Gangguan pada pasokan energi tidak berkelanjutan
2	☐	Terganggunya penggunaan peralatan kesehatan yang memerlukan listrik	2	☐	Gangguan pada pasokan energi tidak berkelanjutan	2	☐	Suhu ruangan menjadi tidak dingin
3	☐	Terganggunya sistem penyimpanan dingin	3	☐	Berkurangnya kapasitas penggunaan peralatan medis dan diagnostik yang memerlukan listrik	3	☐	Rusaknya makanan akibat suhu penyimpanan yang tidak sesuai
4	☐	Terganggunya aktivitas memanaskan air	4	☐	Terganggunya sistem pendingin obat-obatan, vaksin, serta perbekalan kesehatan dan laboratorium	4	☐	Gangguan sistem akses internal (lift, pintu otomatis)
5	☐	Rusaknya vaksin, perlengkapan laboratorium, obat-obatan, dan perlengkapan medis penting lainnya yang bergantung pada pendingin	5	☐	Kesulitan memberikan pelayanan kesehatan kritis seperti cuci darah, pasokan oksigen, peralatan diagnostik, menyebabkan perpindahan pasien ke fasyankes lain (kota atau daerah)			
6	☐	Terganggunya aktivitas memanaskan air	6	☐	Berkurangnya kapasitas untuk menyediakan layanan kebersihan yang membutuhkan listrik (seperti laundry)			
7	☐	Terganggunya rantai pasokan bahan bakar	7	☐	Mengurangi kapasitas untuk menyediakan layanan desinfeksi yang membutuhkan listrik (autoclave, microwave)			

8	☐	Gangguan pemompaan dan pengolahan air yang bergantung pada energi	8	☐	Terganggunya aktivitas memanaskan air			
D.4	**INFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI, PRODUK DAN PROSES**							
	TINGKAT DAMPAK							
	BESAR			**SEDANG**			**KECIL**	
1	☐	Rusaknya peralatan vital akibat pemadaman listrik	1	☐	Berkurangnya kapasitas untuk memberikan layanan kesehatan penting karena kekurangan air	1	☐	Dampak minimal pada peralatan operasi lokal, tanpa dampak pada pemberian layanan kesehatan
2	☐	Gangguan pemberian dan pengoperasian layanan kesehatan	2	☐	Berkurangnya kapasitas untuk memberikan layanan kesehatan dasar	2	☐	Dampak minimal pada rantai pasokan
3	☐	Terganggunya sistem komunikasi dan informasi internal	3	☐	Penghentian sementara pemberian layanan karena kekurangan air	3	☐	Berkurangnya kapasitas untuk menyediakan akses pangan lokal
4	☐	Berkurangnya kapasitas layanan kesehatan rutin seperti rawat jalan, imunisasi, ruang bersalin, layanan gigi, dan layanan primer lainnya (akibat berkurangnya pasokan air)	4	☐	Peningkatan suhu dan penurunan kualitas udara di dalam fasyankes	4	☐	Dampak kecil dari suhu tinggi dan penurunan kualitas udara di dalam fasilitas karena kurangnya AC atau kipas angin listrik atau posisi jendela yang sesuai
5	☐	Gangguan diagnostik karena kerusakan peralatan	5	☐	Tidak ada sistem AC yang berfungsi atau kipas angin listrik atau posisi jendela yang sesuai			
6	☐	Terganggunya rantai pasok air dan makanan	6	☐	Kemungkinan berkurangnya pasokan pangan karena rendahnya akses terhadap produksi pangan			
7	☐	Peningkatan layanan perawatan kesehatan yang kompleks dan darurat (dialisis, perawatan kompleks, wabah, rawat inap kardiovaskular dan pernapasan, dll.)	7	☐	Meningkatnya angka rawat inap memerlukan pasokan medis tambahan dan tenaga kesehatan			
8	☐	Meningkatnya biaya layanan kesehatan untuk mengatasi semua dampak kekeringan	8	☐	Kemungkinan biaya yang lebih tinggi pada fasyankes karena berkurangnya/berkurangnya pasokan makanan dan harga yang lebih tinggi			
9	☐	Menurunnya ketahanan pangan lokal						
10	☐	Terganggunya pasokan pangan lokal						

F	CHECKLIST DAMPAK TERHADAP KEBAKARAN HUTAN								
F.1	TENAGA KESEHATAN								
	TINGKAT DAMPAK								
	BESAR			SEDANG			KECIL		
1	☐	Risiko tinggi penyakit atau kematian akibat penyakit pernapasan dan kardiovaskular kronis	1	☐	Meningkatnya ancaman terhadap kesehatan tenaga kerja yang mengakibatkan cedera fisik atau keracunan akibat polusi udara (asap dan abu, dan dari bahan kimia yang dilepaskan ke udara dari pembakaran bangunan)	1	☐	Cedera ringan pada petugas kesehatan yang tidak memerlukan perawatan medis segera
2	☐	Cedera dan bahaya serius yang mengancam jiwa atau nyawa akibat bangunan yang terbakar dan tidak stabil	2	☐	Meningkatnya dampak penyakit tidak menular (penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan), terutama di kalangan ibu hamil, petugas kesehatan lanjut usia, dan pekerja luar ruangan.	2	☐	Meningkatnya ketidaknyamanan bagi petugas kesehatan dan pasien karena polusi udara dan suhu yang lebih tinggi
3	☐	Meningkatnya risiko penyakit akibat panas, termasuk kelelahan akibat panas, sengatan panas, dan kematian	3	☐	Meningkatnya ancaman paparan debu, abu, dan produk lain selama operasi pembersihan, yang mengakibatkan dampak pada mata, hidung atau iritasi kulit, batuk, dan dampak kesehatan lainnya	3	☐	Meningkatnya ketidaknyamanan bagi petugas kesehatan dan pasien karena polusi udara dan suhu yang lebih tinggi
4	☐	Penyakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau perawatan medis khusus bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan bawaan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik, diabetes, kondisi jantung, dan penyakit kardiovaskular lainnya.	4	☐	Penghentian beberapa program atau ketersediaan layanan	4	☐	Kesulitan atau gangguan dalam pemberian layanan, termasuk layanan perawatan primer di rumah
5	☐	Hilangnya kapasitas kerja akibat asap, abu dan suhu tinggi	5	☐	Kapasitas kinerja tenaga kesehatan berkurang secara signifikan	5	☐	Stres emosional dan kelelahan mental dan fisik
6	☐	Penghentian semua program atau ketersediaan layanan yang mengalir ke lokasi lain	6	☐	Ketersediaan dan kapasitas layanan kesehatan yang berkurang	6	☐	Pengurangan fungsi tenaga kesehatan
7	☐	Meningkatnya permintaan kunjungan medis atau rawat inap karena penyakit paru-paru dan jantung	7	☐	Kekurangan tenaga kesehatan karena berkurangnya atau kurangnya transportasi			
8	☐	Dampak terhadap kesehatan mental staf						
9	☐	Tenaga kesehatan tidak dapat datang atau meninggalkan gedung fasilitas karena ancaman kebakaran						

F.2	WASH DAN LIMBAH LAYANAN KESEHATAN					
	TINGKAT DAMPAK					
	BESAR		SEDANG		KECIL	
1	☐ Degradasi kualitas air di daerah tangkapan air hutan	1	☐ Kemungkinan degradasi instalasi pengolahan air minum	1	☐ Meningkatnya kebutuhan air minum bagi tenaga kesehatan, terutama yang beraktivitas di luar ruangan	
2	☐ Gangguan pada pasokan sistem air	2	☐ Kemungkinan pasokan air tidak aman	2	☐ Perubahan permintaan penggunaan air	
3	☐ Kekurangan air bersih	3	☐ Berkurangnya fungsi sistem sanitasi dan praktik kebersihan	3	☐ Gangguan kecil pada layanan kesehatan	
4	☐ Kemungkinan berhentinya pemompaan air karena pemadaman listrik	4	☐ Berkurangnya kapasitas penggunaan mesin cuci dan pencuci piring			
5	☐ Meningkatnya permintaan air menyebabkan kekurangan air	5	☐ Berkurangnya kapasitas akses air untuk minum dan memasak			
6	☐ Kontaminasi air (dari abu kebakaran hutan, bangkai hewan, bahan penghambat api, atau pipa air yang rusak)	6	☐ Meningkatnya ketergantungan pada sumber air yang kurang aman			
7	☐ Berkurangnya kapasitas penggunaan peralatan medis dan laboratorium yang memerlukan air minum		Kerusakan pada pipa plastik yang terletak dekat permukaan			
F.3	ENERGI					
	TINGKAT DAMPAK					
	BESAR		SEDANG		KECIL	
1	☐ Gangguan pasokan listrik (baik karena alasan keselamatan(sengaja diputus), atau langsung disebabkan kebakaran)	1	☐ Akses listrik yang terputus-putus dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan medis dan laboratorium	1	☐ Kesulitan dalam menyediakan kontrol termal yang menyebabkan penurunan kenyamanan bagi petugas kesehatan dan pasien.	
2	☐ Penghentian prosedur medis yang bergantung pada listrik, seperti dialisis, ruang perawatan intensif, laboratorium, terapi oksigen, radioterapi, peralatan pencitraan dan diagnostik)	2	☐ Rusaknya sumber energi alternatif (seperti generator listrik)	2	☐ Rusaknya makanan akibat suhu penyimpanan yang tidak sesuai	
3	☐ Terganggunya penyimpanan obatobatan, vaksin, dan perlengkapan medis penting lainnya yang bergantung pada pendinginan	3	☐ Terganggunya supply bahan bakar	3	☐ Terganggunya penggunaan perangkat medis yang bergantung pada energi	
4	☐ Rusaknya persediaan medis dan laboratorium, vaksin, farmasi, susu, persediaan bank darah, dan persediaan	4	☐ Meningkatnya permintaan konsumsi energi dari AC atau pendingin udara lainnya	4	☐ Adanya tiang listrik yang tumbang atau rusak dengan kabel yang masih dialiri listrik, meningkatkan risiko sengatan listrik	

		medis penting lainnya yang bergantung pada pendinginan						
5	☐	Gangguan rantai pasokan bahan bakar	5	☐	Berkurangnya kapasitas penyediaan layanan kesehatan yang bergantung pada listrik, seperti peralatan dialisis, ruang perawatan intensif, ruang laboratorium, terapi oksigen, radioterapi, peralatan pencitraan dan diagnostik.	5	☐	Terganggunya layanan pembersihan dan disinfeksi yang memerlukan listrik (laundry, mesin pencuci piring, autoklaf, microwave)
6	☐	Terganggunya pemompaan dan pengolahan air yang bergantung pada energi	6	☐	Berkurangnya kapasitas penggunaan peralatan medis penting	6	☐	Terganggunya aktivitas memanaskan air
			7	☐	Meningkatnya permintaan umum terhadap konsumsi energi			
			8	☐	Peningkatan penggunaan dan biaya terhadap energi			
F.4	**INFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI, PRODUK DAN PROSES**							
	TINGKAT DAMPAK							
	BESAR			**SEDANG**			**KECIL**	
1	☐	Kerusakan akibat kebakaran pada tempat tersebut	1	☐	Meningkatnya angka rawat inap yang membutuhkan pelayanan medis, perlengkapan dan tenaga kesehatan tambahan	1	☐	Meningkatnya permintaan untuk melakukan strategi terkoordinasi dengan departemen kesehatan, sektor lain, pemadam kebakaran, dan relawan
2	☐	Gangguan pada rantai pasokan perlengkapan medis dan laboratorium yang penting	2	☐	Kemungkinan polusi udara dalam ruangan	2	☐	Meningkatnya permintaan akan langkah-langkah adaptasi dan rencana untuk mengurangi dampak panas, serta paparan asap dan abu pada fasilitas tersebut.
3	☐	Kerusakan pada peralatan dan perkakas medis dan laboratorium (pendinginan vaksin dan beberapa obat, proses sterilisasi, peralatan diagnosis dan terapi)	3	☐	Kemungkinan suhu dalam ruangan lebih tinggi	3	☐	Meningkatnya biaya untuk menyediakan langkah-langkah keselamatan.
4	☐	Kerusakan pada sistem komunikasi dan informasi	4	☐	Meningkatnya permintaan untuk penyediaan obat-obatan untuk masalah pernapasan (asma, bronkitis, nyeri dada, PPOK, infeksi pernapasan, dan penyakit kardiovaskular)	4	☐	Terganggunya pasokan makanan
5	☐	Meningkatnya masalah kardiovaskuler dan pernapasan, luka bakar, dan keadaan darurat yang kompleks, sehingga membebani kapasitas fasilitas	5	☐	Meningkatnya angka rawat inap yang membutuhkan pasokan medis dan tenaga kesehatan tambahan	5	☐	Jalan yang mencair mengganggu akses transportasi

6	☐	Meningkatnya kontaminasi udara dalam ruangan akibat asap, yang mengancam kesehatan pasien dan staf.	**6**	☐	Meningkatnya permintaan area pendinginan dan area istirahat bagi staf	**6**	☐	Gangguan pada rantai pasokan termasuk kipas angin dan unit pendingin udara

3. Formulir 3 Identifikasi Kerentanan

Kategori Pertanyaan	Deskripsi	Skor
Pertanyaan Tingkat 1	Pertanyaan umum untuk setiap bahaya	3
Pertanyaan Tingkat 2	Pertanyaan khusus pada bahaya banjir, badai/angin puting beliung, kenaikan muka laut, kekeringan, dan kenaikan muka laut	2

Pertanyaan Umum

No	Pertanyaan	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai			Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Pertanyaan Umum			**Rendah**	**Sedang**	**Tinggi**	
	Sumber daya kesehatan						
1	Apakah fasyankes memiliki sistem komunikasi internal (HT/sirine/sejenisnya) yang aktif pada situasi darurat?	3	Alat bantu komunikasi darurat yang digunakan untuk mengoordinasikan evakuasi, peringatan dini, atau instruksi keselamatan secara cepat antar petugas, seperti HT, pengeras suara, atau sirine. Sistem ini dianggap aktif jika berfungsi, digunakan saat simulasi, dan diketahui penggunaannya oleh petugas.	☐	☐	☐	Dokumen rencanna kesiapsiagaan bencana
2	Apakah fasyankes memiliki program KIE untuk membantu masyarakat rentan (ibu hamil, anak-anak dan lansia) untuk mengurangi dampak dan risiko bencana (tersengat listrik, terbawa arus, gigitan ular, dll)?	3	Kegiatan edukatif yang dilakukan oleh fasyankes untuk meningkatkan pemahamana masyarakat mengenai kesiapsiagaan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim	☐	☐	☐	Dokumen KIE tentang mitigasi dampak dan risiko
3	Apakah tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan dampak kesehatan (kesehatan mental/cedera/pelayanan medis) akibat bencana alam terkait iklim ?	3	Pelatihan mencakup peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menghadapi dampak bencana terkait iklim, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, atau badai/angin puting beliung, atau kenaikan permukaan laut, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik (cedera, penyakit menular) dan kesehatan mental (trauma psikologis, stres pasca bencana). Pelatihan dapat dilakukan minimal sekali setahun atau dua tahun sekali.	☐	☐	☐	Dokumentasi pelatihan

No	Pertanyaan	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai			Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Pertanyaan Umum			Rendah	Sedang	Tinggi	
4	Apakah tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan mitigasi risiko (bahan kimia/biologi/radiologi) akibat bencana alam terkait iklim ?	3	Pembekalan kepada nakes mengenai cara mengenali, melindungi diri, dan menangani paparan bahan berbahaya saat bencana. Dianggap terselenggara jika ada dokumentasi pelatihan yang relevan dan minimal sebagian nakes pernah mengikuti.	☐	☐	☐	Sertifikat pelatihan / keahlian
5	Apakah staf dan tenaga kesehatan mendapatkan pelatihan kapasitas kesiapsiagaan untuk menanggapi risiko bencana terkait iklim?	3	Pelatihan tentang apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana iklim (banjir, panas ekstrem, dll), mencakup evakuasi, triase, dan SOP tanggap darurat.	☐	☐	☐	SOP Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan atau SOP Evakuasi Keadaan Darurat
6	Apakah ada tenaga kesehatan yang dilatih terkait standar keselamatan yang tepat untuk menjaga keandalan pasokan daya listrik dalam situasi rutin maupun darurat/bencana?	3	Pelatihan teknis terkait operasi, perawatan, dan keselamatan instalasi listrik dan genset	☐	☐	☐	SOP Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan atau SOP Evakuasi Keadaan Darurat
7	Apakah fasyankes memiliki program dukungan pendampingan staf (kesehatan mental/cedera/pelayanan medis) pasca kejadian bencana?	3	Layanan dukungan psikologis, medis, atau pemulihan fisik bagi tenaga kesehatan yang terdampak bencana. Program ini dianggap ada jika tersedia akses ke psikolog, tim medis, atau SOP pascabencana untuk staf	☐	☐	☐	Poster layanan kesehatan jiwa dan psikososial di Fasyankes
8	Apakah fasyankes sudah memiliki upaya antisipasi lonjakan beban kerja untuk mendukung tenaga kesehatan existing untuk respon darurat bencana?	3	Upaya antisipasi lonjakan beban kerja mencakup pengaturan shift darurat, tenaga cadangan, atau kerja sama lintas instansi agar layanan tetap berjalan saat bencana.	☐	☐	☐	SOP Penggantian Shift
9	Apakah Fasyankes memiliki rencana penanggulangan bencana dan sudah disimulasikan yang bertujuan keselamatan dan kesehatan kerja selama kondisi darurat (termasuk mitigasi risiko radiologi/bahan kimia/biologi) ?	3	dokumen resmi yang mengatur prosedur tanggap darurat, termasuk keselamatan kerja dan risiko bahan berbahaya yang sudah pernah disimulasikan minimal satu kali dalam setahun.	☐	☐	☐	SOP Pengelolaan Limbah Medis
10	Apakah fasyankes menyediakan air bersih, makanan, dan personal hygine selama kejadian bencana bagi tenaga kesehatan minimal selama 3 hari?	3	Penyediaan logistik minimum selama bencana meliputi ketersediaan air minum, makanan siap saji, dan perlengkapan kebersihan (sabun, tisu, dsb) untuk tenaga	☐	☐	☐	Rekon Banjir sudah memasukan sektor kesehatan

No	Pertanyaan	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai			Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Pertanyaan Umum			Rendah	Sedang	Tinggi	
			kesehatan selama minimal 3 hari dan secara berkala diperiksa dan diperbarui				
	WASH dan Limbah Layanan Kesehatan						
11	Apakah fasyankes memasang katup satu arah pada pipa pasokan air untuk mencegah aliran balik saat terjadinya bencana ?*	3	alat yang dipasang pada sistem pipa air bersih agar air hanya mengalir satu arah dan tidak kembali masuk ke sumber utama (*backflow*), terutama saat tekanan air turun akibat bencana.	☐	☐	☐	Dokumentasi instalasi katup pada saluran air.
12	Apakah fasilitas pelayanan kesehatan memiliki jadwal untuk mengosongkan septic tank/IPAL sebelum bencana guna menghindari luapan?	3	Fasyankes memiliki jadwal atau SOP dalam mengosongkan septic tank/IPAL	☐	☐	☐	Dokumen perencanaan atau jadwal pemeliharaan
13	Apakah fasyankes sudah menyiapkan langkah darurat untuk memantau dan menangani air yang mungkin akan tercemar?	3	Terdapat mekanisme darurt dalam memantau dan menangani air	☐	☐	☐	memenuhi standar Permenkes No. 32 Tahun 2017.
14	Apakah fasyankes telah memiliki sistem pembuangan limbah yang aman sebelum, selama, dan setelah bencana?	3	Prosedur pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, dan pemusnahan limbah layanan kesehatan	☐	☐	☐	standar Kesehatan Lingkungan (Permenkes No. 7 Tahun 2019).
15	Apakah fasyankes memiliki prosedur pengelolaan yang aman untuk mengelola pengangkutan limbah pelayanan kesehatan (termasuk limbah berbahaya) selama dan setelah bencana?	3	Prosedur ini mencakup tata cara pengumpulan, penyimpanan sementara, dan pengangkutan limbah layanan kesehatan (infeksius, B3, dan non-B3) agar tidak mencemari lingkungan saat layanan terganggu	☐	☐	☐	Permenkes No. 18 Tahun 2020 dan PP No. 22 Tahun 2021
16	Apakah fasyankes sudah memiliki tangki penyimpanan air yang tertutup dengan baik untuk mencegah kontaminasi dan ditempatkan di lokasi yang aman saat terjadi bencana?*	3	Wadah penyimpanan air bersih dengan penutup rapat untuk mencegah masuknya kotoran, hewan, atau bahan kimia. Lokasi yang aman berarti tidak rawan banjir, roboh, atau kerusakan struktur saat gempa atau angin kencang	☐	☐	☐	Catatan inspeksi tangki air.
17	Apakah fasyankes sudah memiliki rencana untuk pasokan air darurat?*	3	Dokumen atau protokol untuk menjamin ketersediaan air bersih saat suplai utama terganggu, misalnya melalui tangki cadangan, air kemasan, atau kerja sama dengan penyedia eksternal	☐	☐	☐	Dokumen rencana pasokan air darurat

No	Pertanyaan	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai			Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Pertanyaan Umum			Rendah	Sedang	Tinggi	
18	Apakah fasyankes memiliki rencana darurat untuk memastikan pasokan air bersih yang efektif dan tepat sesuai kebutuhan selama keadaan darurat, baik jangka pendek maupun jangka panjang?*	3	Dokumen yang memuat strategi penyediaan air minimal 50 liter/orang/hari	☐	☐	☐	kualitas memenuhi standar Permenkes No. 32 Tahun 2017 selama bencana
19	Apakah fasyankes memiliki rencana penilaian yang memetakan risiko terhadap infrastruktur air dan sanitasi untuk mengidentifikasi dimana layanan dapat terganggu ketika bencana terjadi?	3	Dokumen yang mengidentifikasi potensi kerusakan infrastruktur air/sanitasi dan dampaknya, menggunakan metode penilaian risiko standar	☐	☐	☐	Dokumen rencana penilaian risiko sanitasi, laporan inspeksi berkala.
20	Apakah fasyankes sudah melakukan verifikasi kondisi keselamatan air (seperti penilaian risiko memetakan sumber daya air dan persediaan air untuk fasilitas tersebut) ?*	3	Verifikasi keselamatan air berarti telah dilakukan pemetaan sumber air, risiko kontaminasi, dan strategi penjaminan mutu air	☐	☐	☐	Permenkes No. 32 Tahun 2017
21	Apakah fasyankes secara rutin memeriksa fungsi dan kondisi keselamatan semua bagian sistem distribusi air, termasuk tangki penyimpanan, katup, pipa, sambungan, dan proses disinfeksi air?	3	Pemeriksaan rutin meliputi inspeksi fisik, uji kebocoran, pengecekan fungsi katup, serta validasi sistem disinfeksi air (misalnya klorinasi). Dianggap terlaksana jika terdapat catatan inspeksi berkala (bulanan/triwulan) dan perbaikan bila ditemukan masalah.	☐	☐	☐	Laporan inspeksi sistem distribusi air, hasil uji fungsi elemen distribusi.
	Energi						
22	Apakah fasyankes memiliki tempat yang aman untuk melindungi generator cadangan/genset (seperti lokasi di tempat yang lebih tinggi, termasuk penyimpanan bahan bakar atau baterai) dari potensi bencana ?*	3	Tempat aman adalah lokasi yang bebas banjir, terlindung dari potensi longsor, dengan ventilasi baik dan akses terbatas.	☐	☐	☐	Lokasi generator berada di tempat tinggi dan terlindungi.
23	Apakah fasyankes telah memiliki cahaya matahari yang cukup untuk memastikan jarak pandang yang baik saat terjadi pemadaman listrik?	3	Cahaya matahari cukup adalah pencahayaan alami yang memungkinkan visibilitas minimal 5 meter di area kritis	☐	☐	☐	Ruangan memiliki jendela besar dengan pencahayaan alami yang cukup.
24	Apakah fasyankes memiliki SOP keselamatan yang jelas bagi staf, termasuk aturan penting seperti larangan memperbaiki peralatan tanpa supervisi profesional, tidak menggunakan perangkat listrik yang terkena bencana, serta menghindari area bencana dengan peralatan listrik yang masih aktif?	3	Panduan tertulis yang mengatur larangan dan kewaspadaan petugas terhadap risiko kecelakaan kerja saat dan pasca-bencana. Dianggap tersedia jika disusun dalam dokumen resmi dan pernah disosialisasikan kepada staf, khususnya tim pemeliharaan dan IGD.	☐	☐	☐	Ruangan memiliki jendela besar dengan pencahayaan alami yang cukup.

No	Pertanyaan	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai			Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Pertanyaan Umum			Rendah	Sedang	Tinggi	
25	Apakah fasyankes telah memiliki rencana darurat untuk pemadaman listrik jangka pendek dan jangka panjang (sebelum, selama, dan setelah bencana)?	3	Rencana ini mencakup penggunaan genset, cadangan bahan bakar, pengaturan prioritas penggunaan listrik, dan SOP pemadaman	☐	☐	☐	Dokumen rencana darurat yang disusun dan diuji
26	Apakah fasyankes memiliki rencana untuk mengevakuasi pasien jika fasilitas tersebut kehilangan aliran listrik dan tidak memiliki sumber energi cadangan?	3	prosedur tanggap darurat yang secara khusus mengatur langkah-langkah evakuasi pasien, terutama pasien kritis dan bergantung pada peralatan listrik (seperti inkubator, ventilator, dan alat infus otomatis)	☐	☐	☐	Dokumen rencana evakuasi pasien dalam kondisi darurat suhu tinggi.
27	Apakah fasyankes memiliki generator cadangan darurat/ genset (termasuk bahan bakar) yang mampu mencakup semua area layanan atau setidaknya peralatan penting selama dan setelah kejadian bencana?*	3	Generator cadangan memadai adalah genset dengan kapasitas minimal 70% dari total kebutuhan beban kritis fasilitas selama 8 jam nonstop.	☐	☐	☐	Dokumentasi kapasitas dan pemeliharaan generator cadangan.
28	Apakah fasyankes telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap generator cadangan darurat, termasuk memastikan ketersediaan bahan bakar ?*	3	Pemeriksaan rutin genset meliputi uji nyala, pengecekan fungsi otomatisasi, serta ketersediaan bahan bakar cadangan minimal 8–12 jam operasional	☐	☐	☐	Jadwal inspeksi dan laporan pemeliharaan generator.
29	Apakah fasyankes telah menilai sumber energi terbarukan (seperti tenaga surya) mencukupi untuk mendukung daya pada peralatan penting?	3	Sumber energi terbarukan mencukupi adalah kapasitas daya minimal 30% dari kebutuhan beban kritis peralatan prioritas.	☐	☐	☐	Laporan evaluasi kapasitas energi terbarukan.
	Infrastruktur						
30	Apakah fasyankes mampu mengelola pengurangan risiko bencana?*	3	Kemampuan pengelolaan risiko bencana diukur dari adanya dokumen manajemen risiko, struktur tim tanggap darurat, dan bukti simulasi	☐	☐	☐	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
31	Apakah fasyankes sudah meninjau ulang kondisi dan keamanan bagian bangunan yang pernah terdampak bencana iklim?	3	Pemeriksaan teknis pascabencana terhadap dinding, atap, saluran air, kabel, dan struktur lainnya. Dianggap sudah dilakukan jika ada laporan teknis atau inspeksi oleh tim pemeliharaan atau pihak profesional (PU/Konsultan Teknik).	☐	☐	☐	dokumentasi perbaikan/pemeliharaan pascabencana
32	Apakah fasyankes telah memiliki rencana evakuasi personel yang aman dan efisien (termasuk staf kesehatan dan pasien) sebelum, selama, dan setelah bencana ?	3	dokumen rencana evakuasi, denah jalur, tim evakuasi	☐	☐	☐	Dokumen Rencana Evakuasi
33	Apakah fasyankes memiliki sistem untuk mendinginkan lingkungan/ruangan?	3	Sistem pendingin ruangan mencakup AC, kipas angin, atau ventilasi silang aktif untuk	☐	☐	☐	Inventaris fasilitas

No	Pertanyaan	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai			Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Pertanyaan Umum			Rendah	Sedang	Tinggi	
			menjaga suhu ruang tetap nyaman, terutama saat cuaca ekstrem khususnya di ruang layanan utama (IGD, ruang rawat inap, ruang operasi)				
34	Apakah fasyankes sudah memiliki alat evaluasi (misalnya formulir) untuk mengidentifikasi kerusakan dan kebutuhan minimum terkait tenaga kesehatan serta pasokan medis demi memastikan kelangsungan layanan?	3	formulir atau sistem digital digunakan saat dan pasca bencana untuk mencatat kondisi bangunan, jumlah tenaga kesehatan tersedia, dan stok kebutuhan medis minimum (obat, oksigen, APD)	☐	☐	☐	Laporan penggunaan formulir pascabencana
35	Apakah fasyankes telah Memiliki rencana untuk memindahkan peralatan penting dan perlengkapan medis ke fasilitas kesehatan lain atau tempat penyimpanan yang aman ?*	3	prosedur pemindahan alat dan perlengkapan vital (alat bedah, ventilator, cold chain, dll) untuk menghindari kerusakan saat bencana. Dianggap memadai jika tertulis dalam dokumen kontinjensi dan diketahui petugas terkait logistik.	☐	☐	☐	Rencana Kontinjensi logistik
36	Apakah fasyankes sudah memiliki SOP untuk pengadaan, pengangkutan, dan penyimpanan makanan dan minuman kemasan selama keadaan darurat?	3	SOP ini mengatur jumlah, jenis, dan tata kelola logistik makanan-minuman siap konsumsi (misal: air galon, makanan kering, makanan bayi) selama darurat. Dianggap tersedia jika ada SOP tertulis dan fasyankes menyimpan logistik minimal 3 hari untuk tenaga kesehatan.	☐	☐	☐	SOP pengadaan & distribusi logistik darurat
37	Apakah fasyankes telah memberikan pelatihan/edukasi yang lebih luas pada pendidikan tenaga kesehatan untuk mencakup risiko dan respons perubahan iklim?	3	Pelatihan ini mencakup materi tentang dampak perubahan iklim pada kesehatan, respons fasyankes, dan kesiapsiagaan bencana. Dianggap terselenggara jika sudah dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun dan menyasar nakes baru maupun aktif, baik formal (dalam pelatihan kompetensi) atau informal (dalam forum rutin).	☐	☐	☐	Modul pelatihan
38	Apakah fasilitas kesehatan sudah mengevaluasi kinerja dan kerentanan bagian-bagian penting bangunannya terhadap bencana?	3	Evaluasi ini mencakup kondisi struktur (atap, dinding, fondasi), sistem kelistrikan, dan drainase terhadap risiko banjir, angin, gempa	☐	☐	☐	Laporan teknis
39	Apakah fasyankes sudah memiliki rencana untuk relokasi peralatan medis, obat-obatan, peralatan portabel,	3	Rencana ini menjelaskan langkah teknis dan logistik untuk memindahkan perlengkapan	☐	☐	☐	Rencana relokasi fasilitas & layanan

No	Pertanyaan	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai			Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Pertanyaan Umum			Rendah	Sedang	Tinggi	
	perlengkapan, atau layanan lainnya jika terjadi gangguan operasional, wabah, atau epidemi yang membebani fasilitas?		vital atau mengalihkan layanan saat fasilitas utama terganggu				
40	Apakah fasyankes sudah memperbarui struktur sistem drainase dan perlengkapan atap untuk mengantisipasi curah hujan tinggi?*	3	Pembaruan drainase mencakup pelebaran saluran, pembersihan berkala, serta perbaikan kemiringan dan jalur air. Perlengkapan atap seperti talang, penutup plafon, dan bahan atap tahan bocor.	☐	☐	☐	Dokumen renovasi/perbaikan atap & drainase
41	Apakah fasyankes memiliki ruang listrik/ruang penyimpanan air yang tahan terhadap bencana (termasuk kebocoran akibat hujan lebat) ?	3	Ruang listrik dan penyimpanan air dikategorikan tahan bencana jika kedap air, memiliki sistem drainase, sirkulasi udara baik, tidak tergenang saat hujan deras, serta berada di lokasi aman (tidak di bawah permukaan tanah/rawan longsor)	☐	☐	☐	bukti konstruksi ruang mesin tahan bencana
42	Apakah fasyankes memiliki pengetahuan, pengalaman (mempertimbangkan kerusakan sebelumnya) dan sumber daya (termasuk manusia, material, keuangan, rantai pasokan dan logistik) untuk mengelola risiko akibat bencana terkait iklim?	3	Fasyankes dianggap memadai jika memiliki staf terlatih dalam tanggap darurat, Rencana kontinjensi logistik dan keuangan, dan Jaringan pasokan bahan penting saat darurat (obat, bahan bakar, makanan, APD)	☐	☐	☐	Laporan audit risiko iklim
43	Apakah fasyankes memiliki mekanisme terkoordinasi di seluruh sektor kesehatan untuk mengelola respons dan risiko bencana kesehatan, dengan melibatkan berbagai tingkat pemerintahan (termasuk pembagian sumber daya, pemindahan pasien, dan dukungan tenaga kesehatan)?*	3	Mekanisme ini mencakup protokol tertulis atau nota kesepahaman (MoU) dengan dinas kesehatan, RS rujukan, dan BPBD atau lembaga lain yang relevan	☐	☐	☐	MoU/kerja sama lintas sektor (dengan Dinkes, BPBD, rumah sakit lain)
44	Apakah fasilitas kesehatan memiliki ruang penyimpanan, baik di dalam maupun di luar gedung, untuk perlengkapan tambahan, dengan mempertimbangkan faktor seperti aksesibilitas, keamanan, suhu, ventilasi, cahaya, dan kelembapan?	3	Ruang penyimpanan yang dimaksud adalah ruangan untuk menyimpan tempat tidur tambahan atau penunjang alat kesehatan lainnya.	☐	☐	☐	MoU/kerja sama lintas sektor (dengan Dinkes, BPBD, rumah sakit lain)
45	Apakah fasyankes sudah memastikan perlindungan peralatan dan pasokan listriknya bebas dari potensi kerusakan akibat bencana?	3	Perlindungan termasuk pemasangan pelindung petir, stabilizer, rak tahan air, posisi alat jauh dari titik banjir, serta perlakuan khusus terhadap kabel, panel listrik, dan UPS	☐	☐	☐	Dokumen laporan pemeliharaan & inspeksi listrik
46	Apakah fasilitas kesehatan sudah punya sumber daya untuk menerapkan langkah pengurangan risiko pada gedung, teknologi, produk, dan prosesnya?	3	Sumber daya mencakup dana pemeliharaan, teknisi atau konsultan teknis, prosedur penguatan struktur, dan audit berkala	☐	☐	☐	laporan belanja mitigasi bencana

No	Pertanyaan	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai			Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Pertanyaan Umum			Rendah	Sedang	Tinggi	
			terhadap proses layanan medis dan nonmedis				
47	Apakah fasyankes telah memiliki jadwal untuk memeriksa fasilitas secara berkala, baik secara internal maupun eksternal, untuk melihat tanda-tanda kerusakan (misalnya retakan atau elemen struktur yang amblas) guna menghindari atau mengurangi dampak bencana?	3	Jadwal pemeriksaan disebut berjalan jika ada dokumen tertulis tentang frekuensi inspeksi (misalnya per triwulan), dengan checklist teknis (atap, dinding, saluran, fondasi). Termasuk audit sarana oleh pihak eksternal (PU, konsultan, tim dinas teknis)	☐	☐	☐	laporan hasil inspeksi
48	Apakah fasyankes memiliki rencana terkoordinasi dengan kepala departemen kesehatan kota untuk memastikan persiapan yang tepat menghadapi bencana terkait iklim yang sedang berlangsung?	3	Rencana ini mencakup komunikasi formal (surat, pertemuan, grup koordinasi), skema bantuan logistik dan personel, serta pembagian tugas saat masa siaga	☐	☐	☐	Rencana Kontinjensi
49	Apakah fasyankes telah mengalokasi anggaran untuk kesiap siagaan dan respon darurat bencana?	3	Anggaran dinilai tersedia jika tercantum dalam DPA/RKA fasyankes untuk pengadaan alat evakuasi, pelatihan kebencanaan, perbaikan struktur, atau cadangan logistik darurat. Juga dapat berupa pos khusus dalam dana operasional atau hibah	☐	☐	☐	laporan realisasi anggaran bencana
50	Apakah fasilitas kesehatan punya lebih dari satu jalur akses, termasuk jalur transportasi umum yang mungkin tetap beroperasi saat atau setelah bencana?	3	Akses alternatif mencakup jalan kendaraan roda empat, jalur evakuasi, atau rute pejalan kaki yang tidak mudah terhalang banjir/tanah longsor. Dianggap memadai jika tersedia dua jalur atau lebih yang dapat digunakan saat kondisi darurat, dan pernah diuji saat simulasi.	☐	☐	☐	Denah jalur akses utama & alternatif
51	Apakah fasilitas kesehatan memiliki prosedur yang jelas, baik, dan konsisten untuk mentransfer pengetahuan jika terjadi keadaan darurat kesehatan masyarakat?	3	SOP serah terima informasi, tanggung jawab jelas & bukti pelaksanaan simulasi/transfer	☐	☐	☐	SOP transfer pengetahuan/shift handover

Kategori Pertanyaan	Deskripsi	Skor
Pertanyaan Tingkat 1	Pertanyaan umum untuk setiap bahaya	3
Pertanyaan Tingkat 2	Pertanyaan khusus pada bahaya banjir, badai/angin puting beliung, kenaikan muka laut, kekeringan, dan kenaikan muka laut	2

- ***Pertanyaan Khusus***

1. Pertanyaan Khusus Banjir

No	Pertanyaan Pertanyaan Khusus	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai Rendah	Sedang	Tinggi	Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Sumber daya kesehatan						
1	Apakah Fasyankes memiliki rencana penanggulangan bencana dan sudah disimulasikan yang bertujuan atas keselamatan dan kesehatan kerja selama kondisi darurat (termasuk mitigasi risiko radiologi/bahan kimia/biologi) ?	2	Dokumen rencana penanggulangan bencana yang mencakup protokol keselamatan kerja	☐	☐	☐	SOP Pengelolaan Limbah Layanan kesehatan
2	Apakah fasyankes menyediakan air bersih, makanan, dan personal hygiene selama kejadian bencana bagi tenaga kesehatan minimal selama 3 hari?	2	Persediaan logistik air minum, makanan siap konsumsi, dan perlengkapan kebersihan pribadi (seperti sabun, tisu, hand sanitizer, pembalut, sikat gigi, dan lainnya) yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan saat layanan terganggu akibat bencana.	☐	☐	☐	Rekon Banjir sudah memasukan sektor kesehatan
	WASH dan Limbah Layanan Kesehatan						
3	Apakah fasyankes telah memantau luapan air limbah guna memperbaiki pompa sebelum musim banjir?	2	Pemantauan dilakukan untuk mendeteksi potensi luapan air limbah dari septik tank, saluran pembuangan, atau IPAL. Dianggap dilakukan jika ada catatan inspeksi dan jadwal perawatan pompa	☐	☐	☐	Catatan pemeliharaan pompa, laporan inspeksi luapan air limbah.

No	Pertanyaan Pertanyaan Khusus	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai			Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
				Rendah	Sedang	Tinggi	
			secara rutin sebelum musim hujan, serta perbaikan teknis bila ditemukan gangguan.				
4	Apakah fasyankes memiliki informasi lengkap tentang pemasangan sistem air yang dapat mengurangi risiko kontaminasi?	2	Informasi ini mencakup denah sistem perpipaan, pemisahan saluran air bersih dan limbah, serta dokumentasi pemasangan katup *anti-siphon/backflow preventer*	☐	☐	☐	Dokumen teknis sistem air, laporan inspeksi risiko kontaminasi.
5	Apakah fasyankes sudah memiliki sistem infiltrasi air alami untuk mengurangi risiko banjir?	2	Fasilitas sumur resapan, biopori, atau drainase ramah lingkungan yang aktif digunakan dan tercatat dalam dokumen infrastruktur	☐	☐	☐	Dokumen desain atau implementasi sistem infiltrasi air.
6	Apakah fasyankes sudah memiliki lubang pembuangan limbah yang dapat bertahan saat terjadi banjir?	2	Fasilitas pembuangan limbah yang kedap air, terletak di area aman, dan memiliki sertifikasi ketahanan banjir	☐	☐	☐	Desain teknis lubang pembuangan limbah.
7	Apakah fasyankes sudah memiliki staf yang terlatih sesuai standar untuk memastikan pengendalian kualitas air, penggunaan persediaan, dan sumber alternatif yang aman?	2	Staf terlatih meliputi petugas sanitasi, teknisi air, atau penanggung jawab hygiene yang pernah mendapat pelatihan tentang pengujian air, manajemen logistik air bersih, dan pemilihan sumber air darurat	☐	☐	☐	Sertifikat atau bukti pelatihan
8	Apakah fasyankes sudah memiliki rencana untuk menyediakan dan memelihara perlengkapan pembersihan dan desinfeksi yang memadai (seperti klorin, filter, atau teknologi pengolahan air lainnya, serta alat uji kualitas air cepat) demi memastikan keselamatan air?	2	logistik dan prosedur pengadaan disinfektan (klorin, hipoklorit), filter air, alat uji kekeruhan/pH/residu klorin, dan SOP penggunaannya	☐	☐	☐	Inventaris perlengkapan pembersihan dan disinfeksi
	Infrastruktur						
9	Apakah fasyankes telah Menentukan lokasi yang aman untuk layanan dan peralatan penting dalam situasi darurat banjir ?*	2	tempat dengan elevasi lebih tinggi atau terlindungi dari genangan, digunakan untuk ruang UGD,	☐	☐	☐	Penentuan lokasi aman untuk layanan dan peralatan

No	Pertanyaan Pertanyaan Khusus	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai			Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
				Rendah	Sedang	Tinggi	
			genset, tangki air, dan penyimpanan obat yang terdokumentasi dalam rencana kontinjensi				
10	Apakah fasyankes telah Memiliki rencana keselamatan untuk melindungi peralatan medis, perlengkapan laboratorium, dan paket makanan dari risiko terkena air banjir?	2	Rencana tertulis yang mencakup prosedur pemindahan, perlindungan fisik (seperti elevasi/perlindungan waterproof), dan daftar peralatan prioritas.	☐	☐	☐	Rencana perlindungan peralatan medis dan perlengkapan
11	Apakah fasyankes telah mengidentifikasi kapasitas, sumber daya, dan kebutuhan untuk mengatasi dan mengelola banjir dengan lebih baik?	2	Identifikasi meliputi jumlah pompa cadangan, kebutuhan logistik, kapasitas daya tampung pasien saat banjir, dan kekuatan SDM untuk siaga yang terncantum dalam dokumen kontinjensi atau kesiapsiagaan	☐	☐	☐	Catatan inventaris sumber daya untuk penanganan banjir.
12	Apakah fasyankes memiliki infrastruktur tempat penyimpanan bahan kimia berbahaya guna menghindari kerusakan atau pelepasan saat terjadi banjir?*	2	ruang penyimpanan B3 (seperti disinfektan, reagen laboratorium, gas medis) yang kedap air, berpintu rapat, tidak di bawah tanah, dan memiliki pengaman tumpahan (spill kit)	☐	☐	☐	Dokumentasi inspeksi dan pemetaan risiko bahan kimia.
13	Apakah fasyankes telah Menanam pohon di lokasi aman yang tidak menghalangi akses atau menimbulkan bahaya bagi bangunan selama bencana ?	2	Pohon ditanam sebagai bagian dari fungsi resapan dan penghijauan, tetapi tidak boleh mengganggu jalur evakuasi, menjatuhkan ranting besar, atau membahayakan bangunan saat angin kencang.	☐	☐	☐	Peta lokasi penghijauan yang aman dan efektif.
14	Apakah fasyankes telah memiliki perkiraan konsumsi (seperti jumlah yang digunakan per minggu) persediaan medis, farmasi, nutrisi dan laboratorium penting, peralatan perlindungan diri, makanan, dll., dengan menggunakan skenario banjir yang paling mungkin?	2	Perkiraan konsumsi disusun berdasarkan skenario darurat (misalnya keterisolasian selama 3–7 hari) dan mencakup kebutuhan esensial per minggu yang	☐	☐	☐	Laporan proyeksi kebutuhan persediaan medis.

No	Pertanyaan Pertanyaan Khusus	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai Rendah	Sedang	Tinggi	Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
			terncantum dalam dokumen kontinjensi atau kesiapsiagaan				

2. Pertanyaan Khusus Badai / Puting Beliung

No	Pertanyaan Pertanyaan Khusus	Skor	Definisi Operasional	ntervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai Rendah	Sedang	Tinggi	Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Sumber daya kesehatan						
1	Apakah fasyankes sudah mengimplementasikan program dukungan pendampingan (kesehatan mental/cedera/pelayanan medis) pasca kejadian bencana?	2	Program dukungan pendampingan adalah layanan terorganisasi yang memberikan konseling, pelayanan medis, atau rehabilitasi kepada korban bencana	☐	☐	☐	SOP Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan atau SOP Evakuasi Keadaan Darurat
	WASH dan Limbah Layanan Kesehatan						
2	Apakah fasyankes dilengkapi dengan program pendidikan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan kepada masyarakat dalam menghadapi risiko badai ?	2	Program pendidikan kesehatan masyarakat adalah kegiatan terjadwal berupa penyuluhan, pelatihan, atau distribusi media edukasi tentang risiko badai/angin puting beliung yang ditujukan kepada masyarakat sekitar fasyankes.	☐	☐	☐	Dokumen rencana darurat fasilitas kesehatan.
3	Apakah fasyankes memantau luapan air limbah guna memperbaiki pompa sebelum badai dan setelah badai terjadi ?	2	Pemantauan dilakukan untuk mendeteksi risiko luapan air limbah dari saluran pembuangan, IPAL, atau septik tank yang dapat meluber akibat curah hujan ekstrem dari badai	☐	☐	☐	Data hasil survei dampak edukasi.
4	Apakah fasyankes memiliki sistem pengelolaan air hujan yang mampu mengatasi banjir akibat badai ?	2	Sistem ini meliputi drainase permukaan, kolam retensi, sumur resapan, dan talang air yang cukup kapasitasnya untuk menampung curah hujan ekstrem saat badai.	☐	☐	☐	Data tingkat banjir sebelum dan setelah pemasangan sistem.
5	Apakah fasyankes memiliki sistem pengelolaan air hujan untuk	2	desain lanskap dan sistem aliran air hujan	☐	☐	☐	Pengukuran

No	Pertanyaan Pertanyaan Khusus	Skor	Definisi Operasional	ntervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai Rendah	Sedang	Tinggi	Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	menghindari genangan air di sekitar fasilitas ?		(kemiringan tanah, saluran air, tanggul kecil) yang mencegah genangan di area akses masuk, ruang rawat, atau area parkir ambulans.				genangan air di musim hujan.
	Energi						
6	Apakah fasyankes secara rutin menilai sistem energinya guna memastikan sistem tersebut mampu mengatasi peristiwa badai dan meminimalkan dampaknya (misalnya panel surya fotovoltaik, baik yang dipasang di atap maupun di tanah)?	**2**	Pemeriksaan berkala pada kekuatan struktur penopang panel surya, koneksi ke sistem listrik cadangan, dan ketahanan terhadap angin kencang	☐	☐	☐	Laporan audit sistem energi yang diperbarui secara berkala.
	Infrastruktur						
7	Apakah fasyankes memiliki sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mengelola dan mengurangi risiko dampak kesehatan akibat badai?	**2**	Mencakup akses informasi dari BMKG atau BPBD, SOP notifikasi kepada staf, dan aktivasi protokol siaga. Dianggap tersedia jika informasi badai dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat melalui sistem komunikasi internal (HT, WA grup darurat, sirine).	☐	☐	☐	Data pemantauan dan respons kesehatan.
8	Apakah fasyankes memiliki jendela dan pintu yang dilaminasi atau dilindungi untuk mencegah pecah dan bocor saat badai?*	**2**	Perlindungan mencakup kaca laminated, pelindung jendela (teralis, kayu penahan), atau segel pintu tahan angin	☐	☐	☐	Pembaruan kaca yang lebih aman
9	Apakah fasyankes memiliki mekanisme untuk menjaga operasional tetap berjalan saat badai, dan melakukan evaluasi serta perbaikan fasilitas melalui pelatihan atau lokakarya setelahnya ?	**2**	Mekanisme operasional saat badai adalah prosedur dan sumber daya yang memungkinkan layanan kesehatan esensial tetap tersedia selama badai, serta kegiatan evaluasi berbasis pelatihan pascabadai	☐	☐	☐	Rencana kesinambungan operasional yang efektif
10	Apakah fasyankes menanam pohon di tempat aman yang tidak akan menghalangi akses ke fasilitas atau menimpa bangunan selama acara?	**2**	Pohon ditanam jauh dari jalur utama evakuasi, tidak dekat dengan kabel listrik atau struktur vital, serta dipangkas secara berkala agar tidak tumbang.	☐	☐	☐	Data pemantauan pohon dan dampaknya pada akses fasilitas.

3. Pertanyaan Khusus Kenaikan Muka Air Laut

No	Pertanyaan Pertanyaan Khusus	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai Rendah	Sedang	Tinggi	Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Sumber daya kesehatan						
1	Apakah ada tenaga kesehatan yang dilatih terkait standar keselamatan air, kontrol kualitas, dan pengolahan yang benar dalam situasi rutin maupun darurat/bencana (kenaikan muka air laut)?	2	Tenaga medis telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang berkompeten, dengan materi mencakup keselamatan air, kontrol kualitas air, dan prosedur pengolahan air yang sesuai standar dalam situasi darurat atau bencana.	☐	☐	☐	Prosedur pengelolaan air bersih dalam situasi darurat dan perubahan iklim
2	Apakah fasyankes dilengkapi sistem informasi yang mapan untuk mengelola keselamatan dan kesehatan kerja dalam situasi darurat?	2	Sistem yang terintegrasi dan teruji yang mencakup proses pengumpulan, pemantauan, dan pelaporan data terkait keselamatan serta kesehatan kerja yang aktif digunakan dalam situasi darurat.	☐	☐	☐	Peningkatan sistem informasi untuk mengelola keselamatan kerja dalam keadaan darurat
	WASH dan Limbah Layanan Kesehatan						
3	Apakah fasyankes memiliki sistem evaluasi untuk memantau sistem atau pasokan air sebelum, selama, dan setelah peristiwa gelombang badai?	2	Mekanisme yang mencakup penilaian berkelanjutan terhadap kualitas dan ketersediaan pasokan air yang dilaksanakan pada setiap tahap sebelum, selama, dan setelah peristiwa gelombang badai, dengan pencatatan dan pelaporan yang jelas.	☐	☐	☐	Sistem evaluasi untuk pemantauan pasokan air
4	Apakah fasyankes memiliki mekanisme untuk melindungi sumber air tawar di sekitar fasilitas dari semua jenis kontaminasi, termasuk intrusi garam?	2	Prosedur yang mencakup pengawasan dan tindakan preventif untuk mencegah kontaminasi atau intrusi air asin yang dapat mengancam kualitas dan keberlanjutan sumber air tawar sekitar fasilitas.	☐	☐	☐	Data kontaminasi air dan keberhasilan perlindungan sumber air tawar
5	Apakah fasyankes memiliki sistem pengelolaan air dan air limbah yang aman terhadap dampak kenaikan muka air laut, termasuk genangan air di dekat fasilitas tersebut?	2	Sistem ini mencakup saluran tertutup, tanggul perlindungan, elevasi saluran, serta pencegahan intrusi air laut ke sistem limbah atau septik tank	☐	☐	☐	Dokumentasi sistem pengelolaan air dan evaluasi dampak genangan
6	Apakah fasyankes menyediakan penutup yang tepat untuk tangki penyimpanan air untuk mencegah kerusakan,	2	Tangki air dilengkapi penutup kedap air, diberi segel atau kunci, serta ditempatkan di lokasi yang	☐	☐	☐	Penilaian terhadap kerusakan tangki air

No	Pertanyaan Pertanyaan Khusus	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai Rendah	Sedang	Tinggi	Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	pencemaran air, dan intrusi air asin jika terjadi banjir akibat kenaikan permukaan air laut?		terlindungi dari genangan dan percikan air asin.				selama banjir
7	Apakah fasyankes memiliki rencana keselamatan air, jika terjadi pencemaran air?*	2	Rencana ini mencakup prosedur identifikasi pencemaran, pengalihan sumber air, penggunaan air kemasan darurat, serta protokol desinfeksi yang tertulis dalam dokumen kesiapsiagaan	☐	☐	☐	Protokol keselamatan air yang sudah ada dan diimplementasikan
	Infrastruktur						
8	Apakah fasyankes menyediakan pelatihan tenaga kesehatan untuk menangani risiko perubahan iklim dan tanggapan terkait kenaikan muka air laut?	2	Pelatihan ini membekali tenaga kesehatan dengan informasi mengenai dampak air asin terhadap kesehatan, pencegahan penyakit akibat air tercemar, dan prosedur tanggap darurat rob	☐	☐	☐	Bukti pelatihan dan sertifikasi tenaga kesehatan dalam manajemen risiko perubahan iklim.
9	Apakah fasyankes memetakan lokasi fasilitas relatif terhadap bahaya kenaikan muka air laut?	2	Pemetaan lokasi fasilitas adalah peta yang menunjukkan posisi fasilitas kesehatan dengan analisis bahaya terkait dampak kenaikan muka air laut, termasuk identifikasi titik rawan banjir atau kerusakan lainnya.	☐	☐	☐	Peta lokasi fasilitas dengan overlay risiko kenaikan muka air laut.
10	Apakah fasyankes memiliki rencana untuk menilai infrastruktur publik yang rentan di sepanjang wilayah pesisir fasilitas kesehatan (misalnya sistem angkutan umum dan jalan raya, sistem air dan pembuangan limbah, infrastruktur energi, rute alternatif untuk fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, logistik dan rantai pasokan untuk perlengkapan medis dan laboratorium, air minum, makanan dan perlengkapan lainnya)?*	2	Rencana penilaian infrastruktur publik adalah prosedur yang melibatkan evaluasi terhadap semua infrastruktur penting di wilayah pesisir yang berisiko terhadap kenaikan muka air laut atau bencana terkait.	☐	☐	☐	Dokumen rencana penilaian infrastruktur publik.
11	Apakah fasyankes memiliki pendanaan untuk melindungi fasilitas dan aset yang rentan dari kenaikan permukaan laut?	2	Pendanaan dapat berasal dari anggaran internal, APBD, atau hibah yang dialokasikan untuk penguatan infrastruktur, relokasi alat, atau peninggian struktur.	☐	☐	☐	Bukti alokasi pendanaan untuk perlindungan fasilitas.
12	Apakah fasyankes memiliki rencana evakuasi untuk memindahkan peralatan medis, laboratorium, dan administrasi penting ke fasilitas pelayanan kesehatan lain atau ke tempat	2	Rencana ini harus mencakup daftar peralatan penting, prosedur pemindahan, titik tujuan penyimpanan aman, dan personel yang	☐	☐	☐	Dokumen rencana evakuasi fasilitas kesehatan.

No	Pertanyaan	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai			Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Pertanyaan Khusus			Rendah	Sedang	Tinggi	
	penyimpanan atau lokasi aman jika terjadi keadaan darurat gelombang badai?		bertanggung jawab				
13	Apakah fasyankes memiliki tindakan mitigasi untuk menangani skenario kenaikan muka air laut dan ancaman yang teridentifikasi, termasuk rekayasa, perencanaan, serta solusi kesiapsiagaan untuk fasilitas dan lingkungan sekitar masyarakat (misalnya stasiun pompa air hujan, pemetaan dataran banjir, penilaian dampak perubahan iklim di masa mendatang)?	2	Tindakan mitigasi mencakup analisis risiko berbasis spasial, pemasangan pompa air, proteksi bangunan, atau perencanaan infrastruktur berbasis data iklim jangka panjang	☐	☐	☐	Dokumen rencana mitigasi dan solusi kesiapsiagaan.
14	Apakah fasyankes punya rencana untuk mempertimbangkan relokasi fasilitas?*	2	Rencana ini bersifat jangka panjang dan mencakup studi kelayakan teknis, sosial, dan anggaran untuk memindahkan seluruh atau sebagian layanan ke lokasi yang lebih aman	☐	☐	☐	Studi kelayakan relokasi dan dokumen perencanaan strategis.

4. Pertanyaan Khusus Kekeringan

No	Pertanyaan Pertanyaan Khusus	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai Rendah	Sedang	Tinggi	Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Sumber daya kesehatan						
1	Apakah fasyankes memiliki rencana penjadwalan khusus untuk kerja di luar ruangan saat cuaca panas ?	2	Rencana penjadwalan khusus untuk kerja di luar ruangan seperti penyesuaian jam kerja (menghindari siang hari/puncak suhu), pengaturan rotasi tugas agar durasi paparan panas tidak berlebihan, pemberian waktu istirahat dan rehidrasi yang cukup.	☐	☐	☐	Kebijakan pengelolaan jadwal kerja tenaga kesehatan.
2	Apakah fasyankes menyediakan fasilitas penunjang untuk staf yang melakukan aktivitas luar ruangan (seperti tabir surya/topi/air minum)?	2	Fasilitas penunjang meliputi perlindungan dari paparan panas (tabir surya, topi pelindung, payung), serta akses air minum yang cukup untuk untuk kegiatan luar (screening lapangan, imunisasi keliling, dll) dan didistribusikan kepada petugas.	☐	☐	☐	Dokumen distribusi perlengkapan perlindungan tenaga kerja.
3	Apakah Fasyankes telah memberikan edukasi tentang strategi perlindungan untuk keadaan darurat kesehatan jika terjadi efek suhu tinggi, serta kontaminasi air dan makanan kepada pasien, staf, dan masyarakat?*	2	Edukasi dilakukan melalui leaflet, penyuluhan, poster, media sosial, atau kelas edukasi pasien tentang bahaya suhu ekstrem, risiko dehidrasi, serta keamanan makanan dan air.	☐	☐	☐	Dokumen rencana komunikasi risiko kesehatan masyarakat.
4	Apakah tenaga kesehatan mengetahui tentang informasi peringatan polusi udara?	2	Tenaga kesehatan dapat mengakses, memahami, dan merespons informasi peringatan dini kualitas udara, seperti paparan polutan PM2.5, PM10, dan asap kebakaran hutan.	☐	☐	☐	Sistem peringatan polusi udara dan bukti komunikasi ke staf.
5	Apakah fasyankes mengetahui cara menjaga lingkungan fasilitas tetap sejuk (misalnya menutup jendela yang terkena sinar matahari pada siang hari dan membukanya pada malam hari saat suhu turun; menutup tirai yang terkena sinar matahari pagi atau sore; mematikan lampu yang tidak penting dan peralatan listrik yang menghasilkan panas; tidur di ruangan yang lebih dingin atau menggunakan kipas angin listrik untuk meredakan suhu jika suhu di bawah 35°C)?	2	Pengetahuan dan penerapan strategi pendinginan pasif (tanpa AC) dinilai memadai jika dilakukan secara rutin dan tercantum dalam SOP kebersihan / operasional	☐	☐	☐	Laporan penerapan strategi pengelolaan suhu ruangan.

	WASH dan Limbah Layanan Kesehatan						
6	Apakah fasyankes memiliki sistem penampungan air hujan dengan penyimpanan air yang aman?	2	Sistem penampungan air hujan dengan penyimpanan air yang aman adalah penampungan air hujan untuk mengumpulkan, menyaring, menyimpan, dan menjaga kualitas air hujan agar dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air non-konsumsi (misalnya untuk sanitasi, pembersihan, atau irigasi hijau), serta tidak menimbulkan risiko kesehatan. Sistem ini harus memenuhi syarat keamanan dari kontaminasi biologis, kimia, dan fisik.	☐	☐	☐	Laporan desain dan inspeksi sistem penampungan air hujan.
7	Apakah fasyankes sudah memiliki rencana untuk menghemat dan mengelola air guna mengurangi penggunaan air, khususnya jika terjadi kekeringan berkepanjangan?	2	Rencana mencakup pengaturan jadwal penggunaan air, pemanfaatan air daur ulang untuk kegiatan nonmedis (kebersihan, taman), dan pemeliharaan keran/pipa untuk mencegah kebocoran	☐	☐	☐	Laporan strategi efisiensi penggunaan air.
	Infrastruktur						
8	Apakah fasyankes memiliki kesiapan dan pelatihan untuk tenaga kesehatan dalam menghadapi periode kekeringan ekstrem?	2	Pelatihan mencakup topik penyakit terkait dehidrasi, diare, dan manajemen pasien saat kekurangan air	☐	☐	☐	Bukti pelatihan tenaga kesehatan dalam kesiapsiagaan terhadap kekeringan.
9	Apakah fasyankes melakukan penilaian kondisi kekeringan (identifikasi, analisis, dan memahami tren) – tren saat ini, masa lalu, dan perubahan di masa mendatang – untuk menerapkan tindakan pencegahan?	2	Penilaian dilakukan dengan menggunakan data dari BMKG atau laporan Dinkes/BPBD, serta pengalaman lokal terhadap musim kering	☐	☐	☐	Laporan analisis tren kekeringan dan strategi mitigasi.
10	Apakah fasyankes memiliki mekanisme untuk menyediakan atau memulihkan layanan air ke fasilitas tersebut dengan cepat?*	2	Mekanisme mencakup kerja sama dengan PDAM, truk tangki air, sumur cadangan, atau sistem penampungan air hujan.	☐	☐	☐	Dokumen rencana kesiapsiagaan pemulihan layanan air.
11	Apakah fasyankes memiliki alat peneduh eksterior, pepohonan, atau fitur arsitektur lain yang mengurangi panas dan kekeringan?	2	Alat ini mencakup kanopi, tirai luar, atap hijau, vegetasi rindang, dan ventilasi silang. Dianggap memadai jika secara visual tersedia di area terbuka dan memberikan perlindungan panas bagi pasien, staf, atau pengunjung.	☐	☐	☐	Laporan keberadaan dan efektivitas sistem peneduh.
12	Apakah fasyankes memiliki jendela yang dapat dibuka untuk menyediakan ventilasi ?	2	Ventilasi alami dinyatakan tersedia jika sebagian besar ruang layanan atau ruang kerja memiliki jendela yang bisa	☐	☐	☐	Dokumentasi desain bangunan dan

			dibuka, berfungsi baik, dan digunakan untuk sirkulasi udara saat suhu tinggi atau pemadaman listrik.				sistem ventilasi.
13	Apakah fasyankes memiliki seperangkat prosedur yang mapan untuk mengevaluasi dan menerapkan rencana manajemen risiko secara berkelanjutan agar tetap responsif terhadap kebutuhan fasilitas dalam menghadapi bencana yang sedang berlangsung dan pasca kekeringan?	2	Seperangkat prosedur manajemen risiko berkelanjutan di fasyankes adalah sistem yang terdiri dari kebijakan, pedoman operasional, dan mekanisme evaluasi	☐	☐	☐	Dokumen kebijakan manajemen risiko dan evaluasi kesiapsiagaan fasilitas.
14	Apakah fasyankes memiliki vegetasi berdaun lebat di dekat jendela untuk memberikan pendinginan alami?	2	Vegetasi yang dimaksud berupa tanaman berdaun lebar atau rambat yang ditanam strategis di dekat jendela untuk mengurangi panas langsung dari matahari	☐	☐	☐	Dokumentasi penanaman vegetasi untuk pendinginan alami.

5. Pertanyaan Khusus Kebakaran Hutan dan Lahan

No	Pertanyaan Pertanyaan Khusus	Skor	Definisi Operasional	Intervensi (tingkat kerentanan) 1 Tinggi, tidak tersedia, tidak mampu 2 Sedang, dalam proses, tidak lengkap 3 Rendah, selesai, tercapai Rendah	Sedang	Tinggi	Usulan contoh dokumen pendukung/ Observasi
	Sumber daya kesehatan						
1	Apakah fasyankes memiliki rencana aksi alternatif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di luar ruangan untuk menghindari atau membatasi aktivitas mereka di luar ruangan guna menghindari paparan asap dan abu (misalnya, berfokus hanya pada pelaksanaan tugas berprioritas tinggi, dengan menerapkan langkah-langkah perlindungan pekerja)?	2	Rencana aksi mencakup pembatasan jam kerja luar ruang, penugasan prioritas, dan penyediaan pelindung diri yang termuat dalam kebijakan internal atau rencana kontijensi	☐	☐	☐	Dokumen kebijakan perlindungan tenaga kesehatan terhadap paparan asap dan abu.
2	Apakah fasyankes memiliki ruangan yang sejuk yang bisa digunakan sebagai opsi pendinginan bagi staf ?	2	Ruangan sejuk mencakup ruang istirahat atau klinik ber-AC atau dengan ventilasi dan sirkulasi udara baik, serta suhu ruang relatif stabil saat udara luar panas dan tercemar asap	☐	☐	☐	Laporan fasilitas pendinginan di lingkungan kerja.
3	Apakah fasyankes memberikan tawaran perawatan khusus bagi staf untuk mengobati penyakit akibat kebakaran hutan (seperti iritasi mata dan kulit, penyakit yang berhubungan dengan suhu panas, polusi udara dan paparan abu dan asap, serta untuk stres mental, dan penyakit pernapasan dan kardiovaskular kronis) ?	2	Tawaran pelayanan mencakup konsultasi kesehatan, pemberian obat iritasi/pernapasan, penanganan gangguan psikosomatik, dan rujukan bila perlu	☐	☐	☐	Laporan penyediaan layanan medis terkait dampak polusi udara dan panas ekstrem.
4	Apakah fasyankes memiliki alat pelindung diri yang memadai bagi staf, termasuk bagi petugas kebersihan (seperti masker respirator (respirator N-95 yang pas), sarung tangan kulit, kacamata atau kaca mata pengaman, pakaian (kemeja lengan panjang dan celana panjang), dan sepatu dengan sol yang kuat)?*	2	APD yang dimaksud meliputi masker N95/pelindung pernapasan, kacamata pengaman, pakaian tertutup, sarung tangan, dan sepatu sol kuat.	☐	☐	☐	Laporan distribusi alat pelindung diri dan inspeksi pemakaian.
5	Apakah tenaga kesehatan di fasyankes sudah terlatih dalam masalah kesehatan masyarakat akibat perubahan iklim khususnya terkait dengan dampak kebakaran hutan terhadap kesehatan manusia?	2	Pelatihan mencakup materi tentang gangguan pernapasan, penyakit jantung akibat polusi, dan cara merespons paparan asap/abu	☐	☐	☐	Bukti pelatihan tenaga kesehatan tentang dampak kebakaran hutan terhadap kesehatan.

	WASH dan Limbah Layanan Kesehatan						
6	Apakah fasyankes sudah memantau sistem distribusi air untuk polutan terkait kebakaran?	2	Fasyankes memiliki sistem pemantauan kualitas air pada jaringan distribusi internal (pipa, tandon, kran) guna mendeteksi kemungkinan kontaminasi oleh polutan dari kebakaran hutan (partikulat halus, karbon, abu)	☐	☐	☐	Laporan pemantauan kualitas air dan hasil analisis polutan.
7	Apakah fasyankes memiliki tangki penyimpanan air dengan penutup yang sesuai untuk melindungi dari panas yang berlebihan?*	2	Tangki tertutup rapat dan terlindung dari sinar matahari langsung agar kualitas air tidak menurun akibat suhu ekstrem	☐	☐	☐	Dokumentasi inspeksi tangki penyimpanan air dan standar proteksi.
8	Apakah fasyankes memiliki rencana pengelolaan air untuk melindungi persediaan air dan sumber air alternatif dari kontaminasi partikel kebakaran hutan?	2	Rencana ini mencakup penyaringan tambahan, pemeriksaan kualitas air, dan cadangan air kemasan jika air utama tercemar asap atau abu	☐	☐	☐	Dokumen strategi mitigasi risiko kontaminasi air akibat kebakaran hutan.
	Energi						
9	Apakah fasyankes memiliki tempat yang aman untuk melindungi generator cadangan (termasuk penyimpanan bahan bakar atau baterai) dari risiko kebakaran?*	2	Lokasi penyimpanan generator yang aman dengan area atau ruang khusus untuk menyimpan dan mengoperasikan genset dan sumber daya listrik cadangan lainnya yang dilengkapi dengan sistem perlindungan kebakaran, berjarak aman dari area rawan api, dan memiliki ventilasi serta akses terbatas.	☐	☐	☐	Dokumentasi lokasi dan perlindungan generator cadangan.
10	Apakah fasyankes memiliki SOP tentang langkah-langkah keselamatan (tindakan mitigasi risiko), seperti tidak menyalakan listrik kembali setelah mati sampai diperiksa profesional, tidak menggunakan peralatan listrik yang terkena api hingga diperiksa teknisi, berhati-hati saat memindahkan peralatan dekat kabel listrik di atas kepala, dan tidak bekerja di area yang penuh asap tebal?	2	SOP harus mencakup prosedur tidak menyalakan listrik sebelum pemeriksaan, hindari kabel tergantung, area kerja penuh asap, dan larangan penggunaan peralatan listrik rusak.	☐	☐	☐	Dokumen pedoman keselamatan dan prosedur operasional standar.
	Infrastruktur						
11	Apakah fasyankes memiliki rencana kontinjensi kualitas udara dalam ruangan saat sebelum, selama dan setelah kebakaran hutan untuk membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan?	2	Rencana mencakup sistem pemantauan kualitas udara, pembatasan akses ke ruang tertentu, pengaktifan filter, dan komunikasi risiko kepada staf dan pasien	☐	☐	☐	Dokumen rencana kontinjensi kualitas udara dalam ruangan.
12	Apakah fasyankes menyediakan filter udara yang sesuai di	2	Filter udara mekanik (HEPA/filter karbon aktif)	☐	☐	☐	Dokumentasi sistem

	area kerja dalam ruangan untuk mengurangi paparan asap dan debu secara keseluruhan?		digunakan di ruang pelayanan utama (IGD, rawat inap, farmasi) untuk menyaring debu halus dan partikel asap				filtrasi udara dalam fasilitas.
13	Apakah fasyankes memiliki rencana atau prosedur darurat terkait dengan dampak kebakaran hutan (seperti suhu panas, polusi udara, asap, abu) di fasilitas tersebut?	2	Rencana ini mencakup aktivasi siaga, penyebaran APD, pengalihan pasien rentan, dan protokol pemantauan gejala akibat paparan.	☐	☐	☐	Dokumen strategi mitigasi risiko kebakaran hutan.
14	Apakah fasyankes memiliki pengaturan untuk memindahkan pasien ke tempat penampungan sementara yang aman?*	2	Tersedia prosedur tertulis dan/atau sistem koordinasi internal yang menetapkan langkah evakuasi medis pasien dari dalam fasyankes menuju lokasi aman (shelter sementara) pada saat terjadi kondisi darurat atau bencana.	☐	☐	☐	Pedoman Rumah Sakit Siaga Bencana Dokumen rencana evakuasi pasien dalam situasi darurat.
15	Apakah fasyankes memiliki tim yang terlatih dan siap atau orang yang khusus menangani kesehatan dan keselamatan kerja, untuk mengelola bahaya (misalnya menyediakan masker respirator yang sesuai dengan bahaya dan situasi kerja; evaluasi medis untuk penggunaan respirator yang aman; pengujian kecocokan untuk respirator yang pas; pelatihan tentang topik seperti cara menggunakan dan merawat masker respirator; dan evaluasi program)?	2	Tim ini bertugas menangani distribusi APD, edukasi pemakaian respirator, evaluasi medis, dan pelatihan pemakaian APD spesifik seperti N95	☐	☐	☐	Laporan pelatihan dan kesiapan tim keselamatan kerja.
16	Apakah fasyankes memiliki lokasi yang aman untuk sistem penyimpanan bahan bakar (misalnya gas, bensin, solar) atau tindakan perlindungan lainnya?*	2	Lokasi penyimpanan bahan bakar dengan akses terbatas (ruang atau area khusus) dan terlindung dari potensi api atau ledakan, serta dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran, ventilasi memadai, dan jarak aman dari area pelayanan.	☐	☐	☐	Dokumentasi lokasi dan perlindungan penyimpanan bahan bakar.

Direktorat Kesehatan Lingkungan
Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia

2025